

方良百病

(第五集)

賈河先 趙鴻鳴 編著
馮添生 審訂

科学技术文

80784

贾河先 赵鸿鸣 编著
冯涿尘 审订

百病良方

第五集



科学技术文献出版社重庆分社



责任编辑: 朱栋均
技术设计: 王 维

百病良方 (第五集) 贾河先 赵鸿鸣 编著

科学技术文献出版社重庆分社 出 版

重庆市市中区胜利路132号

新华书店重庆发行所 发 行

中共重庆市委机关印刷厂 印 刷

开本: 787×1092毫米1/32 印张: 5.5 字数: 12万

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

科技新书目: 195-233 印数: 1-100 000

ISBN7-5023-0398-7/R·98 定价: 1.95元

C0128700



序

读过《百病良方》的人，众口皆曰：“是实实在在的良方”。“良方”必出自良医之手。良医者谁？重庆市中医研究所主治中医师贾河先也。他，近年来声誉渐起，知名度渐高。之所以有今天，这是贾河先用汗水换来的，是心血浇灌的结果。二十多个冬去春来，他钻研医术，博采众方，探索幽微，特别是著书立说的意识极强，而且成效彰彰可纪。新近的信息表明：他的著作字数，洋洋百余万；书籍出版后，不久即告罄；著述的发行总量，即将突破百万册大关。他用“河先精神”，多次跻入国际书展。由此观之，河先真乃自学成才的佼佼者也。其代表作中，最享盛誉的便是《百病良方》。至此已成书1—5集，自成系列，其针对性、启发性、可读性、科学性均较强，内容丰富，文笔流畅，深入浅出，通俗易懂，是广大医务人员和病家难能可贵的参考书。

希望河先同志继续开阔医学视野，追求新的高度，不断博采众方，建造人们喜闻乐见的“良方库”。
乐以为序。

中华全国中医学会重庆分会副秘书长 冯涤尘
重庆市中医研究所副所长

一九八八年孟秋

目 录

内 科

1. 流行性感胃…(1)
2. 创伤性气胸…(3)
3. 胃粘膜脱垂
症……………(5)
4. 胃肠型荨麻疹
疹……………(10)
5. 结肠激惹综
合征……………(11)
6. 肠结核……………(13)
7. 旋毛虫病……………(14)
8. 结肠小袋纤
毛虫病……………(16)
9. 麻痹性肠梗
阻……………(18)
10. 梅毒性直肠
炎……………(19)
11. 慢性肝炎血
清蛋白倒置…(20)
12. 胆心综合征…(22)
13. β -受体兴奋
症……………(24)
14. 腹型过敏性
紫癜……………(26)
15. 蛇毒性窦性
心动过缓……(27)
16. 心电图ST-T
改变……………(28)
17. 高血压危象…(29)
18. 脑动脉硬化
症……………(30)
19. 化脓性脑膜
炎……………(32)
20. 奔走性癫痫…(34)
21. 颅内压增高
症……………(34)
22. 肌肉收缩性
头痛……………(35)
23. 臂丛神经痛…(37)

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 24. 腓总神经损伤……………(39) | 39. 大骨节病……(62) |
| 25. 癔病性黑蒙症……………(41) | 40. 莱特氏综合征……………(65) |
| 26. 癔病性瘫痪…(41) | 41. 庆大霉素肾损害……………(66) |
| 27. 强迫性神经症……………(44) | 42. 镇痛药肾病…(67) |
| 28. 躁狂抑郁症…(45) | 43. 慢性地方性氟中毒……………(69) |
| 29. 坏血病……………(48) | 44. 安定中毒……………(70) |
| 30. 失血性贫血…(49) | 45. 阿托品过量反应……………(71) |
| 31. 行军性血红蛋白尿……………(51) | 46. 迟发性运动障碍……………(72) |
| 32. 遗传性出血性毛细血管扩张症……………(52) | 47. 酒(乙醇、酒精)中毒…(74) |
| 33. 老年性紫癜…(54) | 48. 一氧化碳中毒……………(76) |
| 34. 血栓性血小板减少性紫癜……………(54) | 49. 铅中毒……………(78) |
| 35. 血小板无力症……………(55) | 50. 蜈蚣螫伤……(81) |
| 36. 血友病……………(56) | 51. 蝎螫伤……………(82) |
| 37. 糖尿病酮症…(57) | 52. 蜂类螫伤……(83) |
| 38. 骨质疏松症…(59) | 53. 蛭类(蚂蝗)螫伤……………(83) |
| | 54. 毒蜘蛛螫伤…(84) |

妇 产 科

- | | |
|----------------|----------------|
| 55. 梅毒性流产…(85) | 56. 梅毒性不孕…(88) |
|----------------|----------------|

57. 胎盘滞留……(89)

58. 产后子宫收

缩痛……(90)

儿 科

59. 风疹……(92)

60. 水痘……(93)

61. 脊髓灰质炎…(95)

62. 小儿迁延性
肺炎……(97)

63. 小儿情感性

交叉擦腿症…(99)

64. 婴儿蒙被缺

氧综合征……(100)

65. 小儿肌性斜
颈……(101)

外 科

66. 肛管直肠周
围脓肿……(103)

67. 肛门周围化
脓性汗腺炎…(105)

68. 肛门直肠神
经官能症……(107)

69. 肛门失禁……(109)

70. 肛门部下疳…(111)

71. 糖尿病并发
疖肿……(113)

72. 变形性膝关
节炎……(114)

73. 胸部迸伤……(117)

74. 胸部挫伤……(119)

75. 梨状肌损伤
综合征……(121)

76. 肩部软组织
扭挫伤……(123)

77. 肘部软组织
扭挫伤……(125)

78. 腕关节劳损…(129)

79. 腕管综合征…(131)

80. 跗管综合征…(134)

81. 踝关节扭伤…(137)

皮 肤 科

82. 夏季皮炎……(139)

83. 念珠菌性

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 甲沟炎.....(140) | 90. 肛门瘙痒症...(149) |
| 84. 糜烂性包皮 | 91. 肛门疣状皮 |
| 龟头炎.....(141) | 肤结核.....(151) |
| 85. 鳞状毛囊角 | 92. 肛门扁平湿 |
| 化症.....(142) | 疣.....(152) |
| 86. 毛发红糠疹...(143) | 93. 胼胝.....(153) |
| 87. 利尔黑变病...(144) | 94. 鸡眼.....(153) |
| 88. 足口病.....(146) | 95. 瘢痕疙瘩.....(155) |
| 89. 松毛虫病.....(146) | |

五 官 科

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 96. 突发性耳聋...(157) | 99. 眶上神经痛...(163) |
| 97. 夜盲症.....(160) | 100. 眼底出血症...(164) |
| 98. 色盲.....(162) | |

内 科

1. 流行性感 冒

流行性感 冒（简称流感）是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，主要通过唾沫传染，具有高度传染性，如不及时控制，每易引起暴发、流行或大流行。临床特点为起病急，全身中毒症状明显，有发热、头痛、乏力、全身酸痛等。婴儿、老年人及体弱者易并发肺炎等。

临床表现

流感的潜伏期很短，约 1—3 天。在临床上可分为单纯型、肺炎型和中毒型流感。

（1）单纯型流感：头痛，发热、畏寒、乏力、全身酸痛。发热持续 2—3 天后渐降。在全身症状和发热消退时，鼻塞、流涕、喷嚏、咽痛、干咳等呼吸道症状常较明显。部分患者有食欲不振、恶心、便秘等症状。症状消失后，显得疲倦，体力恢复较慢。

（2）肺炎型流感：高热不退，气急，紫绀，阵咳，咯血，病程可延长至 3—4 周。白细胞计数低，中性粒细胞减少。

（3）中毒型流感：高热不退，神志昏迷，成人常有谵

妄，儿童可发生抽搐，并出现脑膜刺激征。少数病人血压下降或休克。

流感可通过血象检查、血清学检查、病毒分离等确诊。

流行性感属属于祖国医学的“时行感冒”和“风温”的范畴。多系气候反常，人感受邪毒、疠气而发病。邪从口鼻而入，主要蕴结于肺胃二经。若邪轻，仅见风热袭表之证；若邪重，则多肺胃气分或卫分同病见证。冬季发病较多。

辨证分型治疗

(1) 风寒束表：恶寒重，发热轻，无汗，头痛，咳嗽痰稀，四肢酸痛，苔白而润，脉浮缓。治宜辛温解表。

方药：荆芥10克，防风10克，柴胡12克，前胡10克，羌活12克，紫苏10克，桔梗10克，茯苓10克，川芎10克，甘草6克。水煎服。

(2) 风热袭表：发热重，恶寒轻，咽红疼痛，咳嗽痰稠，口渴，出汗，苔薄黄，脉浮数。治宜辛凉解表。

方药：银花30克，连翘30克，竹叶10克，牛蒡子20克，桔梗12克，薄荷10克，芦根30克，甘草6克。水煎服。

(3) 肺热壅盛：发热较高，不恶寒，咳嗽气喘，痰黄稠或咯血，口渴思饮，舌红苔黄，脉滑数。治宜清热解毒，宣肺止咳。

方药：紫花地丁30克，蒲公英30克，板蓝根30克，瓜蒌30克，黄芩15克，桔梗15克，甘草10克，赤芍30克，丹皮12克。水煎服。

(4) 邪毒内陷：高热不退，烦躁不安，谵妄，昏迷，颈项强直，舌红苔黄，脉细数。治宜清热解毒，清心开窍。

方药：玄参30克，麦冬30克，莲子心10克，连翘30克，郁金12克，菖蒲12克，钩藤30克，银花30克，黄连10克，水牛角

屑30克。水煎服。

针刺治疗

(1) 体针：取穴风池、大椎、合谷。高热者加刺曲池。头痛甚者加刺太阳、印堂。喉痛甚者加刺少商。后三穴并可点刺出血。

(2) 耳针：取穴额枕、肾上腺、皮质下。

验方治疗

(1) 大青叶30克，生石膏30克，山楂15克，银花30克，黄芩15克，杏仁12克，柴胡15克，甘草10克，黄芩30克。水煎服。

(2) 板蓝根30克，蒲公英30克，羌活10克，葛根30克，菊花20克，柴胡30克，大黄10克，甘草10克。水煎服。

预防

加强体育锻炼，提高机体抗病能力。集体单位如有流感流行趋势，要做到早发现，早报告，早诊断，早隔离，早治疗。并可用以上验方熬大锅汤服药预防。

2. 创伤性气胸

气胸是指肺泡和脏层胸膜破裂，空气经裂口（隙孔）进入胸膜腔，产生胸膜腔内积气和肺脏萎缩。

气胸可分为自发性气胸和创伤性气胸两大类。自发性气胸的中药治疗见《百病良方》第三集。本文为创伤性气胸的中药治疗。

创伤性气胸指胸部刺伤、枪弹伤、严重挫伤、肋骨骨折，或由于颈、胸、上腹部疾患为诊断及治疗所进行的各种手术操作（如针刺过深或气管切开误伤肺叶胸膜等）所产生

的气胸。创伤性气胸常为血气胸。

气胸发病的急缓，据胸腔内积气的多少、快慢和原有肺部情况而定。迅速产生的大量气胸，往往发病急骤，少量气胸可无明显症状。

创伤性气胸的主要症状：胸痛，气急，咳嗽，咯血，心慌难忍等。创伤性血气胸则肺泡破裂，血管出血，呼吸道分泌物增多，使淤血、积气、分泌物停聚，胸腔和支气管广泛堵塞，换气功能受碍，以致缺氧，甚至产生呼吸衰竭。

对于创伤性血气胸，消除呼吸道分泌物和淤血，是治疗的关键。祖国医学认为，胸为肺之分野，清阳所聚之地，肝经之脉布于胁肋。肺主气，肝主藏血，气为血帅，血为气母。故胸肋损伤，气滞血淤，责之肝肺两脏，而以肺为关键。其治疗，宜活血化淤，宣肺涤痰，疏肝理气。

内服方药

苡仁30克，香附15克，旋覆花12克，炙苏子12克，杏仁12克，桔梗15克，法半夏12克，桃仁10克，红花10克，当归15克，赤芍15克，柴胡10克，茯苓20克，玄胡12克。水煎服。

加减：便秘者加大黄、枳实；咳血多者加三七、藕节炭、茜草。肺热者加桑白皮、黄芩、芦根。咳喘多痰者加炙麻黄、川贝母、枇杷叶。胸痛剧烈者加乳香、没药。

外治方药

当归60克，姜黄30克，生大黄60克，赤芍30克，土鳖虫30克，血竭15克，川断60克，川芎30克，骨碎补40克，没药30克，煅自然铜30克，各研细末，和匀，加凡士林适量调成膏药，外敷骨折处，并加半环式胶布固定胸廓。

用以上方药治疗，待血气胸消失后，再投以补肺益脾、

和营生新、续筋接骨之药（内服），促进组织修复和骨折愈合。

对于针刺过深造成创伤性气胸者（患者有胸闷胀如充气样感觉，背部疼痛、胸闷气短、心慌难忍），除立即在常规消毒下作抽气处理外，可内服中药，以减轻症状，促进康复。

方药：生石膏30克，大黄10克，黄芩15克，杏仁12克，厚朴12克，瓜蒌10克，葶苈子12克，桔梗10克，枳实10克，甘草10克，水煎服。

3. 胃粘膜脱垂症

胃粘膜脱垂症是由于胃窦部粘膜通过幽门管脱入十二指肠所造成。严重时，脱垂的粘膜可阻塞幽门，引起幽门梗阻及上消化道出血现象。

胃粘膜脱垂症是由于慢性炎症、水肿、恶性细胞浸润等原因引起胃窦部粘膜皱襞的肥大、冗长以及粘膜下组织松弛易动，当遇有强大的胃蠕动推动时，便滑入幽门管。本病常与胃炎、胃溃疡、十二指肠炎、十二指肠溃疡等病同时存在。

胃粘膜脱垂症多见于30—60岁的男性。很多病人没有症状，或因伴有十二指肠溃疡，其症状为溃疡病症状所掩盖。胃粘膜脱垂症常见的症状为非周期性的上腹部不适或疼痛，进食或服碱性药物不能缓解，有时进食后疼痛加剧。左侧卧位往往可使疼痛减轻或缓解，而右侧卧位常使疼痛加剧。其他症状有上腹部气胀、暖气、嗝酸、胃灼热、反胃、恶心、呕吐等。

脱垂的粘膜可阻塞幽门，从而产生持续性上腹部疼痛、恶心、呕吐等幽门梗阻征象及呕血、黑粪等上消化道出血的征象。

胃粘膜脱垂症可通过胃镜检查、胃肠X线钡餐检查等确诊。

胃粘膜脱垂症属于祖国医学的“胃脘痛”范畴。系气虚下陷所致。治宜升提活血。

中药治疗

方药：黄芪60克，党参60克，枳实30克，升麻10克，柴胡10克，细辛5克，蒲公英10克，肉桂10克，红花12克，蒲黄10克，川芎15克，丹参30克，三棱10克，莪术10克，丹皮10克，甘草6克。水煎服。

加减：合并有胃、十二指肠球部溃疡者加白芨12克，白芷10克，元胡10克，儿茶10克。或用锡类散3克，饭后2小时服，每日服3次。伴有肥厚性胃炎者加炮山甲10克，王不留行12克。合并有萎缩性胃炎或肠化生者加水蛭5克，或加土鳖虫10克。伴有食道炎者饭后服黄连素粉0.4克，每日服3次，温开水送服（不能多喝水）。本病疗程较长，应坚持服药。

推拿治疗

一、胃热食滞型：胃脘嘈杂不适，时有烧灼感，噯腐吞酸，呕吐酸苦黄水，腹痛拒按，大便秘结，小便短黄，舌红苔腻，脉洪数有力。

（1）上腹摩按法

患者仰卧，两下肢伸直，医生坐其侧。医生以一手或两手的四指并置于上腹部之巨阙、幽门穴处，自上向下呈直线摩动，经中脘、阴都至水分穴止，反复摩按5—10分钟。

（2）侧腹挤推法

患者仰卧，医生站其头部前方。医生以两手拇指分别置于侧腹上部石关及腹哀穴处，自上向下，同时由两侧自外向内挤推腹部肌肉，经大横、神阙至水道、关元穴止，反复挤推 3—5 分钟。

（3）摩动季肋下法

患者仰卧或侧卧，两下肢微屈曲，医生坐其侧。医生以一手四指掌侧置季肋下不容、承满穴处，另一手四指掌侧置其相对之背部阳纲、意舍穴处，两手同时向腋中线合摩，反复操作 5—10 分钟。按摩背部时用力宜稍大。

（4）束腹法

患者仰卧，医生坐其侧，医生以两手四指对置脊柱正中线之悬枢及命门穴处，再经三焦俞、肾俞、志室，再向腹部京门、章门至腹正中线止，反复作束腹式摩动 3—5 分钟。

束腹时应使两手将两侧腰部肌肉用力抱拢。束腹至正中线时，两手应将腹部肌肉交叉捏紧，并微向上拿提。

操作时有腰肌向前牵拉感，治疗后有腰部轻松感。

（5）腰部补消兼施法

患者侧卧，两下肢屈曲，医生坐其侧，医生用一手四指指端置一侧腰部肾俞穴处，自腰后向腹部推动 1—2 分钟。

医生再以另一手四指掌侧置一侧腹外侧大横、府舍穴处，自上向下摩动髂骨内缘至水道、归来穴处止，反复操作 3—5 分钟。

自腰向前推动时应用力均匀而有节律，宜缓不宜急。治疗后，腰及下腹均有轻松感。

（6）按阴陵法

患者仰卧，下肢伸直，医生坐其侧。医生用拇指置小腿内上方阴陵泉穴处，沿胫骨内缘向下推动至内踝上方三阴交

穴处止，反复操作1—2分钟，再以两手拇指并置阴陵泉穴处按压3—5分钟。

按压穴位时可配合揉法。治疗时有酸胀感，治疗后有小腿温热感及小腹舒适感。

（7）脊背拿提法

患者俯卧，医生坐其侧。医生以两手拇指置脊柱一侧之内缘，其余四指掌侧置其外侧。或用一手拇指及食指分置其内、外侧，自背部上方大杼穴平高处，自上向下拿提背部及腰部肌肉至腰骶部之关元俞穴止，反复操作3—5次。

拿提背部肌肉时应先作纵形拿提，后作横形拿提。拿提时应将肌肉拿紧，向上提时应将肌肉提起。根据需要可拿提一侧腰背肌肉或左右交替拿提。

二、脾胃阳虚型：胃脘胀痛，绵绵不绝，喜按，食少，不纳硬食。口吐清水，面色苍白，手足不温，有时大便溏泻，舌淡、苔薄白，脉沉细。可作以下推拿治疗。

（1）脐周团摩法

患者仰卧，医生坐其侧。医生用掌心置神阙穴上，以脐为中心，先作顺时针方向旋转5—10分钟，再作逆时针方向旋转团摩5—10分钟。

（2）上腹横摩法

患者仰卧，医生坐其侧。医生用两手四指掌侧并置于腹部左或右侧之腹哀、章门穴处，经关门、太乙、商曲至对侧腹哀、章门穴处止，反复横摩5—10分钟。

（3）摩侧腹法

患者侧卧，两下肢微屈曲，医生坐其侧。医生以一手四指掌侧置侧腹上部不容、承满穴下，另一手四指掌侧置背部魂门穴处，前后对置，再自上向下合摩侧腹部，摩动经大横、

腹结至府舍穴止，腰背部摩动经意舍至志室穴止，反复摩动5—10分钟。

(4) 腹肌拿提法

患者仰卧，医生坐其侧，医生以两手四指分置腹部两侧章门穴处，自外向内将腹部肌肉挤起，然后两手交叉扣拢，两手四指掌侧置腹部一侧，拇指掌侧置腹肌另一侧，自两侧之关门、太乙、滑肉门穴平高处，自上向下逐渐移动至天枢、水道、归来穴处止，反复拿提3—5次。

(5) 背部拳揉法

患者俯卧，医生坐其侧。医生以手握拳自背部左或右侧之肩中俞穴处拳揉1—2分钟后，再自大杼穴平高处起，经脾俞、胃俞至肾俞、大肠俞穴止。再予对侧背部施以同样操作方法，两侧反复拳揉3—5分钟。

(6) 揉足三里法

患者仰卧或直坐，卧位时下肢伸直，医生坐其侧。医生以食指背屈揉按足三里穴2—3分钟。再以手四指置小腿外侧自阳陵泉处向下至悬钟穴止，抚摩1—2分钟。

简易气功治疗

在推拿治疗后，嘱患者取左侧卧式。行均匀而自然之腹式呼吸。此时，由于幽门口向上，腹式呼吸可使粘膜退回，改善局部血液循环，加之气功的意守丹田和入静，将使大脑皮层处于良好的保护性抑制状态，因而有利于功能的恢复，练简易气功，每日早晚各一次，每次约一小时，坚持2—3个月为一疗程。

热敷疗法

当推拿治疗后，在作简易气功治疗的同时，还可作热敷治疗。方法是：左侧卧位，左腿自然伸直，右腿膝屈曲，踝

关节部放在左小腿上，上腹部放热水袋热敷30分钟。每日1次。1个月为一疗程。

艾灸疗法

常用穴：百会、中脘、神厥、足三里。

方法：以艾条悬灸每穴5分钟，或隔姜、附子饼以艾炷灸，每穴3—5壮。

4. 胃肠型荨麻疹

胃肠型荨麻疹是荨麻疹（皮肤变态反应性疾病）的一种类型。每次发作均有腹部隐痛，或（脘腹）绞痛，或上吐下泻（肠胃症状），腹痛较剧烈时全身出现片状红色皮疹（大小不规则风团或丘疹），高于皮面，压之褪色，瘙痒难忍。腹痛缓解后，皮疹（风团）也随之消失。大多数患者的肠胃症状在发疹前发生，或发疹过程中发生，诊断并不困难。也有的患者腹痛每于子夜或凌晨发作，随即伴发荨麻疹。

中医认为胃肠型荨麻疹的发病与湿热有关，或与血虚有关。不论何种类型，其治疗均应分发作期与缓解期分别论治。

辨证分型治疗

（1）肠胃湿热型：发疹前或发疹过程中发生脘腹痛或不适，恶心呕吐，大便稀溏或不爽，舌淡红，苔白腻或黄腻。

① 发作期治疗方药：苍术15克，厚朴12克，陈皮12克，茯苓15克，黄芩12克，连翘15克，地肤子15克，蝉蜕10克，丹皮12克。水煎服。

加减：皮疹痒甚者加蛇蜕、苦参、徐长卿。脘腹痛甚者

加炒枳壳、焦楂曲。疹红赤或咽红加银花、地骨皮。

② 缓解期治疗方药：上方与香砂六君丸（成药）交替服用。

（2）血虚生风型：患者平素形体畏寒，腹痛常于子夜或凌晨发作，或受寒后发作，随即伴发荨麻疹。腹痛喜温喜按，呕吐清涎，舌淡苔白。

① 发作期治疗方药：制附片10—30克（先熬），党参30克，白术12克，防风12克，当归20克，干姜10克，炙甘草10克，陈皮10克，台乌10克，升麻10克，白芍30克，黄芪60克，制乳香6克，制没药6克。水煎服。

② 缓解期治疗方药：人参再造丸（成药），每次服10克，每日服2次。

5. 结肠激惹综合征

结肠激惹综合征又称结肠过敏症，是一种以结肠生理紊乱为突出表现的全身性功能性疾病。临床上以腹痛、便秘、腹泻和粘液便等单独出现或混合出现为其特征。并常伴全身性神经官能症表现。患者粪便不含任何病理性成份（如脓、血、细菌等），纤维结肠镜检查也没有器质性病变。

临床表现

顽固的便秘与腹泻交替出现，腹痛，腹胀，伴有失眠、焦虑、烦闷、忧郁、头痛、头面发热、手足汗出、心悸等神经官能症表现。

结肠激惹综合征属祖国医学的“郁症”范畴。其病位在肝脾（胃），病机是肝气郁滞，疏导失常，以致脾胃功能紊

乱，大肠传导失司。

辨证分型论治

(1) 肝郁痰结型：左少腹痛，并可触及条索状包块，严重者右少腹亦可出现。大便秘结，3—4日解大便一次，并带有粘液，结粪成细条状、卵石状或羊屎状不等。便秘与腹泻交替，腹泻时夹多量粘液，每于左少腹疼痛后排便，次数不等。治宜疏肝理气，导痰化浊。

方药：柴胡15克，白芍20克，枳实10克，甘草6克，法夏12克，陈皮12克，茯苓30克。水煎服。

加减：便秘症状突出时加槟榔、瓜蒌仁。腹泻症状突出时加白术、神曲。

(2) 肝郁气滞型：大便干涩难下，以痉挛性便秘为主要症状，胁肋胀痛，暖气，呃逆，甚至胆汁性呕吐，食欲不振，腹胀欲便，排便不畅，后重窘迫等。治宜顺气导滞，降逆通便。

方药：槟榔15克，木香10克，枳实10克，台乌10克，柴胡12克，沉香8克（研末冲服）青皮10克，白芍15克。水煎服。

(3) 肝郁肠湿型：便秘，3—4日大便一次，干结难下，但腹痛不剧烈，神经官能症症状明显，如失眠、焦虑、烦闷、忧郁、头痛、头面发热、出汗、心悸等。治宜滋水涵木，舒肝清热。

方药：生地30克，山药10克，山萸肉12克，丹皮12克，茯苓12克，泽泻30克，柴胡12克，当归30克，白芍15克，山栀12克，大枣15克。水煎服。

(4) 肝郁湿阻型：每日排便十多次，每于餐后腹绞痛即泻，泻后痛减。腹泻呈周期性发作。兼见胸脘胀闷，肠鸣，头晕，纳呆，四肢倦怠，大便稀溏，舌苔腻浊，脉濡

滑。治宜燥湿化浊。

方药：陈皮10克，白芍30克，白术10克，防风12克，藿香12克，厚朴12克，法半夏12克，茯苓30克。水煎服。

（5）肝郁风泄型：肠鸣泄泻，腹痛奔迫，大便稀溏，日3—5次不等，食少纳呆，脘痞口渴，舌红少苔，脉细弦数。治宜柔肝安胃。

方药：柴胡12克，白芍30克，白蒺10克，神曲15克，生地30克，厚朴12克，山药30克，甘草6克。水煎服。

注：本病腹泻与一般腹泻不同，本病腹泻多为神经性、情绪性，虽有粘液便，但不含病理成份，其病机以肝郁气滞为主，切莫投以葛根芩连汤、四神丸、理中汤之类，否则腹泻不止，病症难愈。本病的便秘由肠道痉挛所致，若用攻下药（如大黄等）会使结肠受到强烈的刺激，以后便秘更顽固。

6. 肠 结 核

肠结核是结核菌引起的传染病。其传染途径有消化道传染、血行播散、淋巴播散。饮用带结核菌的牛奶，与结核病人使用共同的饮食器具，取食或舔啃被结核菌污染过的玩具或物品，吞咽带菌痰液，都可使结核菌侵入肠道而引起肠结核。肠结核也可继发于开放性肺结核之后（血行播散），也可继发于淋巴结核之后（淋巴播散）。

肠结核轻症患者没有任何症状。重症有不规则发热、腹痛和消化道障碍（包括食欲减退、消化不良、恶心、呕吐、腹胀、腹泻或腹泻与便秘交替。腹痛的部位在脐上、脐周

围、下腹部尤其是右下腹部，呈阵发性疼痛或阵发性绞痛，腹痛可发生在饭后2—3小时或5—6小时。腹痛发作时常伴有腹鸣，并有肠梗阻，大便带血，甚至是脓血便。大便有腐臭味，大便量多。患者消瘦，或出现营养不良性水肿、贫血和糙皮病等。

肠结核可通过OT试验、大便镜检与细菌培养，X线钡餐检查等确诊。

肠结核属于祖国医学的“泄泻”、“腹痛”等范畴。中医认为，脾主运化，肝主疏泄，肝得脾所输布的饮食精微滋养后，疏泄功能才能正常。若脾失健运，气化不利，升降失调，浊阴内阻，上泛则发为呕吐，下迫则发为泄泻。其治疗，宜调补中气。

方药：黄芪30克，党参30克，白术12克，当归12克，陈皮10克，升麻6克，柴胡6克，甘草6克，防风10克，白芍15克，皂刺12克。水煎服。

注：此方须连服60剂后改服补中益气丸（连续服用1—3年）。

7. 旋毛虫病

旋毛虫病又名旋毛线虫病，是一种人畜共患的动物源性寄生虫病。人由于生食含旋毛虫幼虫囊包的猪肉而感染，旋毛虫寄生于人体小肠上段而发病。主要症状有发热、胃肠道症状、肌痛、水肿和血中嗜酸性粒细胞高度增多。

旋毛虫是一种胎生线虫。除人体外，任何食肉哺乳动物如猪、猫、犬、鼠及多种野生动物（狐狸、狼、熊、北极

熊、鬣狗、豺、狮子、豹)都可以作为旋毛虫病的宿主。

猪为主要传染源。人主要因生吃猪肉或吃未熟透的含旋毛虫幼虫包裹的猪肉而感染，人不直接传染人。本病分布于全世界，常见于温带。旋毛虫幼虫包裹有较强的抵抗力，6英寸厚的猪肉内旋毛虫包裹在 -30°C 以下贮存20天才死亡。猪肉厚度2.5毫米，在 70°C 以上烫1分钟不能杀死幼虫。熏烤、腌制、曝晒不能杀死包裹幼虫。包裹幼虫在腐肉中亦能存活2—3个月，在 79°C 以上方能被杀死。

旋毛虫病暴发流行与食生肉习惯有密切关系。

人体感染旋毛虫后有一定程度的免疫力，感染轻者可不发生症状。若病人生食的猪肉含幼虫包裹数达5个/克体重者，则可致命。

旋毛虫病可分以下三个阶段：

(1) 幼虫在肠内发育期(或侵入期，约一周)：由于脱囊幼虫钻入肠壁发育成熟，引起十二指肠、空肠炎症，粘膜充血水肿。约半数病人自感染第2—7天，有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、便秘、食欲不振等胃肠道症状，同时伴有乏力、畏寒、发热等。

(2) 幼虫移行期(2—3周)：约自感染后一周，雌虫生产大量幼虫，侵入血循环，引起显著异性蛋白反应。患者有弛张型高热，视感染轻重持续2天至2月余不等。部分患者于热退3—10日可再次发热，或伴有荨麻疹或斑丘疹。幼虫自血循环移行至肌肉，可引起肌炎，全身肌肉酸痛，全身各部肌肉均可受累，以腓肠肌、三角肌、双头肌与眼部肌肉酸痛为最常见。肌痛一般持续3—4周，部分可达2个月以上。肌肉局部有水肿，伴疼痛、压痛与显著乏力。肌痛严重，发热时间长，有皮疹者大多出现眼部症状。重度感染

者，肺、心肌与中枢神经系统亦被累及。某些病例的肺、肝、肾等脏器亦有病变，可能与幼虫移行过程中所产生的毒素和代谢产物以及肌纤维破坏所产生的有毒物质对机体的损害以及机体的过敏反应有关。

(3) 包囊形成期(4—16周)：幼虫在被横纹肌肉包围形成囊包后，急性炎症消退，全身症状逐渐消失，但局部肌肉仍感酸痛无力，且可持续甚久。

患者如在新近有吃生猪肉或吃过半生不熟的猪肉史，又有发热、肌肉疼痛和水肿，并有胃肠道症状、血中嗜酸粒细胞增多者，应考虑有旋毛虫病的可能。确诊则依靠血清学检查及肌肉活组织检查。

旋毛虫病属于祖国医学的“虫积”范畴。多由饮食不洁，嗜食生腥，虫随口入，损伤脾胃。脾主肌肉，脾损则肌肉酸痛，运化失职，发为泄泻。治宜健脾清热，解肌杀虫。

方药：槟榔15克，鹤虱12克，雷丸12克，茺莢12克，细辛6克，苦楝皮12克，苦参30克，柴胡15克，白芍30克，甘草10克，生大黄10克。水煎服。

预防

(1) 切断传播途径：进行卫生宣传教育，不吃生猪肉或半生不熟的猪肉，不生吃其他动物肉。加强食品卫生管理，未经卫生检验的猪肉不准上市。

(2) 控制与管理传染源：改善养猪方法，提倡圈养，用熟料喂猪，加强粪便管理。消灭鼠类。

8. 结肠小袋纤毛虫病

本病系结肠小袋纤毛虫寄生于人体结肠引起的疾病。一

般情况下，人较少感染结肠小袋纤毛虫，但人与猪共栖时，人群常可感染此病。结肠小袋纤毛虫污染水源可造成局部地区暴发流行。本病的主要临床表现有腹泻，排粘液脓血便，腹痛，里急后重，发热等。

本病通过粪一口传播，人主要通过食入被结肠小袋纤毛虫包裹污染的食物或水而感染本病。猪是结肠小袋纤毛虫病的主要传染源。猪的感染率约 20—100%。

世界上许多地区都有结肠小袋纤毛虫病，牧猪人及屠宰工人的感染率较高，感染后多数人成为无症状带虫者。

结肠小袋纤毛虫病可分为急性型和慢性型两种类型。

急性型的主要临床表现为腹痛、里急后重、粘液脓血便、发热等，类似痢疾。

慢性型的主要临床表现为排糊状便或水样便，或腹泻与便秘交替出现。

粪便中发现结肠小袋纤毛虫滋养体即可确诊为本病。作乙状镜检查时，于粘膜溃疡边缘括取材料作镜检，同时取病变组织作病理切片，常可发现结肠小袋纤毛虫滋养体。

结肠小袋纤毛虫病属于祖国医学“腹痛”、“泄泻”、“虫积”等范畴。多由饮食不洁，虫随口入，损伤脾胃，湿热下注大肠而成泄泻。治宜祛湿解毒杀虫。

方药：苦参50克，蛇床子50克，槟榔15克，加水 300 毫升，浸泡 10 小时（夏季只浸泡 5 小时），煎沸半小时，待温分 3 次服，每日服 1 剂。或用本药液作保留灌肠，连续 5—10 日。

预防

加强卫生宣传教育，搞好环境卫生，注意个人卫生和饮食卫生。不喝生水。农村不要用新鲜粪便施肥，避免直接接

触粪便，及时治疗被结肠小袋纤毛虫感染的病猪。

9. 麻痹性肠梗阻

肠内容物在肠道内通过受到障碍时，称为肠梗阻。肠梗阻形成后，不仅可引起肠管本身的解剖和功能上的变化，还可影响全身。

肠梗阻可分为三大类：①机械性肠梗阻；②动力性肠梗阻（又称为功能性或神经性肠梗阻）；③血管性肠梗阻。

麻痹性肠梗阻属于动力性肠梗阻当中的一种，是肠壁肌肉活动受到抑制而失去蠕动能力，肠腔内容物不能向下运行。这种情况比较常见，例如在急性弥漫性腹膜炎、腹部手术后、腹膜出血和感染等，均可发生麻痹性肠梗阻。

临床表现

轻微腹痛（或不痛），呕吐，不排便，肛门不排气，腹胀严重，由于大量气体和液体积聚在肠腔内使腹内压增高和横膈抬高，可引起呼吸加快和心跳加速，还可导致少尿，肠鸣音消失。X线检查有助于确诊。

麻痹性肠梗阻属于祖国医学的“虚胀”范畴。中医认为系吐泻过度，泄甚脾惫，脾阳受损，运化失职，中焦壅滞，升降紊乱。治宜振奋脾阳。

中药治疗

方一：附子10—30克（先熬），干姜10克，党参30克，白术15克，陈皮12克，法半夏12克，甘草10克。水煎服。

方二：公丁香 1.5克，肉桂 1.5克，木香 1.5克，麝香 0.15克，

共研细末，用熟鸡蛋去壳，对剖，去掉蛋黄，纳药末于半个鸡蛋（蛋白）的凹陷处，覆盖在脐上，外扎纱布。2小时后若闻肠鸣，矢气频传，则病情缓解。若尚未生效，可再敷一次。

本方所用辛温芳香药品，如麝香，旨在加强渗透之力，促使肠蠕动功能恢复正常。

方三：桃仁10克，桂枝6克，生大黄10克（后下），芒硝10克（冲服），枳实10克，厚朴10克，甘草6克。水煎服。

本方适用于胸腰椎骨折并发症——麻痹性肠梗阻，亦称肠麻痹。

方四：当归30克，白芍30克，蒲公英20克，山楂20克，神曲20克，麦芽20克，丹皮10克，阿胶10克，芒硝10克（冲服），柴胡6克，厚朴10克，黄芩6克，没药10克，槟榔10克，枳壳10克。水煎服。

本方适用于腹膜炎过程中的麻痹性肠梗阻。

针灸疗法

取穴：中脘、天枢、大横、足三里、阴陵泉、阳陵泉，神厥只宜灸。由胸腰椎骨折所致者，可加脾胃俞、肾俞、气海俞、大肠俞等背俞穴。

10. 梅毒性直肠炎

梅毒性直肠炎，主要是通过性交感染梅毒螺旋体引起的一种直肠炎症性疾病。第二、三期梅毒，有时在直肠发现。梅毒螺旋体先累及粘膜下层，使组织脆弱，后因动脉炎，粘膜坏死，形成溃疡。溃疡边缘突起，向外翻转，底硬，常盖

有黄绿色分泌物，直肠壁变厚，变硬，弹性消失，且因纤维组织增生，收缩而形成直肠狭窄。

临床表现

梅毒性直肠炎的症状有：排便不净，里急后重，粪便内混有脓血，腹胀。

患者有梅毒病史。直肠指诊溃疡底硬，边缘突起，直肠壁变厚，无弹性。窥器检查可见溃疡边缘外翻，底不平。直肠分泌物内有梅毒螺旋体（显微镜检查）。血液检查及脑脊液检查有阳性梅毒反应。

梅毒性直肠炎属于祖国医学的“结毒”范畴。是由于与有毒之人交接或感触淫毒所致，或因脏腑虚弱，肾气虚衰，毒恶邪气损伤荣卫，邪淫欲火郁滞而成。

中药治疗

治疗原则：泻火解毒。

方药：黄连15克，黄芩30克，黄柏15克，栀子12克，紫花地丁30克，蒲公英30克，赤芍30克，白芍30克，苦参30克。水煎服。

注：严重的梅毒性直肠炎（晚期梅毒）尚须配合砷剂铋剂治疗。

11. 慢性肝炎血清蛋白倒置

慢性肝炎出现白蛋白降低、球蛋白升高，简称蛋白倒置，反映肝细胞受到损害，肝内蛋白质的合成能力降低。伴有麝香草酚浊度试验（麝浊）、硫酸锌浊度试验（锌浊）指数升高。

辨证分型论治

(1) 脾失健运，气血亏虚：肝区隐痛，劳累尤甚，精神倦怠，气短懒言，食欲不振，面色淡白或萎黄，牙龈出血，妇女月经量少色淡，或肌肤淤斑晦暗，舌质淡胖，脉虚细无力，血清蛋白倒置。治宜健运脾胃，补益气血。

方药：黄芪30克，白术12克，茯苓15克，首乌15克，山药30克，大枣30克，桑椹30克，鸡血藤30克，板蓝根30克，白蔻10克，砂仁6克，当归15克，丹参30克。水煎服。

(2) 脾肾两虚，湿热未尽：血清蛋白倒置，头晕目眩，脘腹胀满，胁肋疼痛，食纳不振，大便溏稀，腰腿酸痛软弱，口苦口粘，小便黄短而赤。治宜调补脾肾，利湿清热。

方药：山药30克，首乌15克，金樱子30克，菟丝子30克，杜仲12克，白术12克，黄芪30克，苡仁30克，板蓝根30克，苍术12克，肉苁蓉15克，肉桂6克，制附片15克（先熬）。水煎服。

(3) 肝肾亏损，血热毒蕴：血清蛋白倒置，肝区隐痛，五心烦热，失眠多梦，劳累则肝区隐痛加重，神疲体瘦，眼目干涩，肝掌，蜘蛛痣，面色晦暗，舌面龟裂，舌红少苔脉细数。治宜滋补肝肾，凉血解毒。

方药：山萸15克，枸杞15克，黄精30克，首乌15克，桑椹30克，丹参30克，当归20克，生地30克，板蓝根30克，女贞子30克，鳖甲30克，鸡内金15克，赤芍30克，沙参30克。水煎服。

(4) 肝郁气滞，淤血阻络：血清蛋白倒置，胁肋胀痛或刺痛，暖气胸闷，脘腹胀满，纳差，口干不欲饮，舌质紫暗或舌有淤斑，肝脾明显肿大。治宜疏肝理气，活血化淤。

方药：川楝子12克，郁金20克，丹参30克，香附15克，白芍30克，首乌15克，山楂15克，鸡血藤30克，五灵脂10克，板蓝

根30克，黄芩30克，鳖甲30克，龟版30克，生牡蛎30克，内金15克。
水煎服。

以上不论是哪一型，如果麝浊、锌浊长期增高，可加芦荟8克，研末冲服（1日量）。服后有轻泻的副反应，不需处理。连服一周为一疗程，间歇3天，再行第二疗程。

附注：血清蛋白倒置纠正后，尚需守方巩固疗效。板蓝根、黄精、白术、黄芪、鸡血藤等药物，对纠正蛋白倒置有良好作用。此外，首乌、桑椹、丹参、枸杞、当归、山药、熟地等，能改善肝细胞的功能，促进蛋白质的合成，对提高血清白蛋白水平（纠正蛋白倒置）也有良效。

12. 胆心综合征

胆心综合征是指患者同时患有胆系疾病（例如胆囊炎、胆石症）和冠心病的一种急重病症。临床上，常在胆道病的患者中发现心电图异常，有时伴有心绞痛发作，甚至发生急性心肌梗塞。冠心病患者中也常发现有胆结石、胆囊炎。胆囊、胆道疾患与冠心病并存是否有直接的还是偶然的因果关系，目前尚无定论，但胆心综合征在临床上确非少见。内科患者多由于心前区闷痛或绞痛，伴有心悸，被诊断为冠心病。但疼痛持续时间较长，有的甚至长达10余小时，用硝酸甘油、麝香保心丸等扩张冠状动脉解除痉挛的药物不能缓解疼痛，且发作频繁。症状多在食油腻或情绪激动时诱发，有的伴有恶心、呕吐，或者胸闷、胃脘痛。有的患者每吃脂肪食物，疼痛势必发作，且痛势剧烈难忍，疼痛有时在右胁部向下引至右下腹，上至胃脘部，恰在肝胆经气循行部位。有的

患者心前区疼痛发生时先从脊柱两肩胛区开始，疼痛放射至两肋直至左胸骨旁，有时压迫右肋缘，疼痛即加剧。

胆心综合征患者心电图有改变，如出现ST-T异常、运动试验阳性、窦性心动过缓、窦性心动过速、房性早搏、室性早搏、心房颤动、房室传导阻滞、不完全性左束枝传导阻滞、心肌梗塞等。患者胆道疾患治愈后，心电图才得以明显改善。

胆心综合征属于祖国医学的“胆心痛”、“心腹痛”、“心悸”等范畴。《灵枢·经脉篇》说：“胆足少阳之脉，……是动则病。苦，善太息，心胁痛不能转侧……”。《诸病源候论》说：“心腹痛者，由于脏腑虚弱，……邪气发作，与正气相击，上冲于心则心痛，下攻于腹则腹痛，上下相攻，故心腹绞痛，气不得息”。中医认为胆心综合征多由肝胆湿热，或肝胆气结，心脉淤滞，或阳气虚弱，痰湿痹阻。其治疗，宜清利湿热，活血化淤，益气温阳。

辨证分型治疗

(1) 肝胆湿热型：胸闷脘胀，食欲不振，口干少饮，情志不舒时易导致胸胁满痛，便干尿黄，舌红苔黄脉细数。治宜清热利湿，舒肝利胆。

方药：龙胆草12克，茵陈30克，柴胡12克，黄芩15克，金钱草30克，郁金40克，泽泻30克，丹参30克，赤芍30克，大黄10克，芒硝10克，栀子10克。水煎服。

(2) 肝胆气结，心脉淤滞：右肋满闷与左上胸掣痛、刺痛同时发作。每于情志不舒与进食脂肪食物后发作。舌淡紫，苔腻，脉细弦。治宜疏肝理气，活血化淤。

方药：丹参30克，金钱草30克，柴胡15克，青皮10克，香附15克，赤芍30克，川楝子12克，生蒲黄10克，五灵脂10克，内

金15克，檀香8克（研末冲服），当归15克。水煎服。

（3）阳气虚弱，痰湿痹阻：心前区闷痛，食少神疲，情绪忧郁，时或肝胆区胀痛，脉细弦，舌淡苔白。治宜益气温阳，利胆排石。

方药：桂枝12克，瓜蒌30克，薤白30克，郁金40克，玄胡12克，海金沙10克，金钱草30克，内金15克，香附15克。水煎服。

针刺治疗

（1）体针：取穴膻中、期门、内关、足三里、阳陵泉、太冲。每次2—3穴，平卧平泻，留针20—30分钟。

（2）耳穴：肝胆、胰、脾胃、心、神门、内分泌，每次3—4穴。亦可以王不留行籽用0.5×0.5cm方形胶布按压所取穴并保留，三日换一次，每天自压3—4次，疼痛时按压止痛较好。（此法以后简称“耳压法”）

13. β -受体兴奋症

β -受体兴奋症，又称 β -受体亢进症、 β -受体过敏综合症。临床表现有交感神经兴奋性增加的症候群，如心悸、气短、乏力、多汗、胸闷、失眠、情绪激动、焦虑不安、心率增加、心音亢进、血压轻度升高等。心电图检查可见窦性心动过速，多数患者呈ST段缺血型或近似缺血型下移，或T波倒置、低平。患者没有冠心病、心肌炎、甲状腺功能亢进等器质性病变，若采用 β -受体阻滞剂（如心得宁、心得安等）治疗，可使症状获得改善，心电图也可恢复正常。但精神紧张时病又复发，且病程较长。现代医学认为 β -受体兴奋症的发病机理是植物神经功能紊乱，交感神经兴奋性增加。

β -受体兴奋症属于祖国医学的心气不足、心阴亏损范畴。气阴两虚，虚热上扰心神，本虚标实，而成此症。治宜益气养阴，滋阴降火，宁心安神。

方药：葛根60克，生地30克，党参30克，麦冬20克，五味子20克，柏子仁15克，酸枣仁15克，阿胶15克，生龙骨30克，生牡蛎30克。水煎服。

加减：气虚明显者加黄芪30克，白术12克，黄精30克；阴虚明显者加北沙参30克，丹参30克，天冬20克，玄参20克，当归10克；失眠明显者加黄连10克，茯神30克，合欢皮15克，夜交藤30克。

本方以葛根为主药。科学研究证明葛根具有广泛而显著的 β -受体的阻滞效应，与心得宁的 β -受体的阻滞作用相似，但无明显的抑制心脏的作用，可降低血压，减慢心率，扩张冠状动脉，降低心肌耗氧量，改善脑与外周循环，可使因 β -受体兴奋而产生的心电图ST-T段改善乃至恢复正常。方中还伍用党参、麦冬、五味子组成的生脉散，生脉散具有协调心血管功能的双向调节作用，通过改善心室顺应性，降低心肌自律性，不应期延长，心率减慢，心肌耗氧量下降，从而起到良好的治疗作用。

总之，中医治疗 β -受体兴奋症，是从根本上调节机体的功能，纠正机体的植物神经功能紊乱，达到阴平阳秘、气血调和的目的。其远期疗效较心得宁、心得安等为优。对心得安有禁忌者，用中芪治疗同样有效。

针刺疗法

(1) 体针：取穴内关、神门、足三里、三阴交、太冲等穴，补法。

(2) 耳穴：皮质下、内分泌、交感、神门、心，用耳

压法。

14. 腹型过敏性紫癜

腹型过敏性紫癜,又称亨诺氏症、许兰-亨诺氏综合症,是过敏性紫癜的一种类型(过敏性紫癜见《百病良方》第二集第101页),属毛细血管变态反应性疾病。青少年较为多见。典型症状为急性腹痛(突然发作),恶心呕吐,腹泻或有血水样便,四肢特别是臀部突然发生皮疹和出血点,同时伴有尿血、鼻衄。本病往往反复发作,若不伴有皮肤紫癜,常可误诊为急腹症。

单纯腹型者(腹痛症状突出)又称亨诺氏症,伴有关节症状者(关节肿胀和疼痛)又称许兰-亨诺氏综合症。

腹型过敏性紫癜属于祖国医学的“发斑”、“肌衄”、“葡萄疫”、“腹痛”等范畴。中医认为系脾虚肝旺、寒热错杂之证。多由素禀不足,脾气素虚所致。脾虚则运化失职,湿热内生。湿热久蕴,必耗营血。脾统血而藏营,肝体阴而藏血。湿热久蕴则脾气更虚,肝亦失其柔润之性。肝气失其敛藏之职,乘虚而克脾土。脾受木贼,则呕吐泄泻。营阴受损,湿热逼迫血分,阳络伤则血从上溢为鼻衄,阴络受损则血从下渗而大便带鲜血。湿热内生,脾风逆于腠理,每因肝气触发而致遍体风疹瘙痒。其治疗当以扶脾敛肝,寒热并调,酸苦辛并用,辅以宁络止血。

方药:乌梅30克,黄连10克,黄芩10克,党参30克,炮姜10克,川椒10克,白芍30克,枳实10克,防风10克,炙地榆30克,焦山栀10克。水煎服。

亦可将上药共研细末，水泛为丸，如梧桐子大，每次服10克，1日服2次，开水吞服，连服1月，防止复发。

方中乌梅、白芍配黄连、黄芩酸苦泄热，收敛肝气。党参、炮姜健脾治中，扶助脾气。配枳实、川椒苦辛通降。加地榆、山梔止血清热。全方刚柔相济，寒热并调，扶脾敛肝，宁络止血，方证相符，疗效较好。

艾灸疗法

取穴：神厥、中脘、天枢、足三里。

因有紫癜，故不宜针刺。

15. 蛇毒性窦性心动过缓

蛇毒性窦性心动过缓系被毒蛇咬伤经抢救后遗留的心率缓慢的一种病症。患者感胸脘痞闷，心悸，不欲食，脉迟缓（每分钟50次左右）。

蛇毒性窦性心动过缓属于祖国医学的“心阳受损”、“心阳不振”范畴。系蛇毒入侵，心阳受伤，痰浊中阻。治宜温心阳，化痰浊。

方药：桂枝20克，炙甘草15克，黄芪30克，党参30克，石菖蒲10克，法半夏10克，陈皮10克，苍术10克。水煎服。

本方重用桂枝、炙甘草，仿张仲景用温补心阳之峻剂桂枝甘草汤方意。方中党参、黄芪补心气，健脾土，石菖蒲、半夏、陈皮、苍术燥湿化痰，宣通阳气。诸药合用，可使心阳振，痰湿化，故治疗蛇毒性窦性心动过缓有较好疗效。

针刺疗法

（1）体针：取穴内关、足三里、膻中、大椎，予补

法。

(2) 耳穴：心、分质下、内分泌、神门、交感、肾上腺，用耳压法。

16. 心电图 ST-T 改变

心电图 ST 段下降及 T 波倒置是临床常见的一种异常波型。多见于心肌缺血、心肌劳损、高血压性心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、肺源性心脏病、病毒性心肌炎、风湿性心肌炎等。患者自感心悸、胸闷、胸痛、气急、乏力、少气懒言。脉结代或细弦。

心电图 ST-T 改变属于祖国医学的“心悸”、“怔忡”等范畴。多系气虚血淤所致。心主血脉。行血无力，血脉不得流畅，心失荣养，故心慌，气短，甚而血滞为淤，阻滞脉络，故胸闷、胸痛，脉弦细或结代。治宜益气活血。

方药：黄芪60克，丹参30克，太子参30克，赤芍30克，瓜蒌15克，薤白30克。水煎服。

加减：气陷（少气懒言，疲乏无力）症状突出者加柴胡、升麻、郁金；兼肝阳上亢（头昏、头痛、心烦易怒、血压高）者加石决明、钩藤、杜仲；兼痰湿（头晕、胸脘痞闷）者加地龙、石菖蒲、半夏；热病后期（舌红少苔，口干口苦）者加连翘、沙参、板蓝根等；血淤明显者加三七粉；气急明显加葶苈子。

针刺疗法

取穴：膻中、内关、合谷、足三里、三阴交、太冲，平补平泻。

17. 高血压危象

高血压危象是指高血压病程中，患者周围小动脉发生暂时性强烈痉挛，导致血压急剧升高的一种危重症。如果抢救不及时或治疗不当，可导致脑水肿、脑溢血、脑疝等更危重的病症。

引起高血压危象的病因有：①恶性高血压或急进性高血压；②急慢性肾炎；③慢性肾盂肾炎；④多囊肾，肾动脉狭窄；⑤嗜铬细胞瘤，柯兴氏综合征；⑥妊娠毒血症；⑦药物影响（如服用110降压片两个月以上突然停药）。⑧饮食不当（如同时服用利血平、胍乙啶、酒、香蕉、巧克力等）；⑨颅内出血。

临床表现

在原有高血压的基础上，血压突然急剧升高达200/120毫米汞柱以上，病人伴有头痛、头晕、视物模糊、恶心呕吐、便秘、尿少，甚至偏头痛、失语、眼底出血等。

高血压危象属于祖国医学的“眩晕”、“头痛”、“中风”、“厥证”等范畴。中医认为本病的病因较多，但离不开风、火、痰、气、血等因素。其病理为风痰上扰，气血上逆，上扰清窍所致。其病位主要在脑。这除了与肝、肾脏等有关外，还常与腑气不通降有联系。“六腑以通为用”，腑气以下降为顺。腑气通降，五脏的功能才能协调，才能维持人体的“升降出入”。

中药治疗

方一：生大黄粉10克（冲服），厚朴10克，石决明30克，

钩藤30克(后下)，川牛膝30克，地龙15克，生地15克。水煎服。

注：本方服后可泻下大量粪便，症状减轻。此方适用于高血压危象伴大便秘结（即使大便不秘结，但身体壮实），不适用于严重阳虚之高血压危象患者。

从现代医学的观点分析，中医的“泻下法”可使大量的粪便、液体排出体外，从而起到减轻腹压和减少血容量作用，有利于预防和减轻脑水肿，降低颅内压。此外，腹腔突然减压，可使腹腔内（包括胃肠内）的毛细血管和大血管扩张充血，使血液重新分布，回流减少，也有利于降低血压和颅内压。这与中医所说的平肝降逆，引血下行的作用极相似。再有，根据药理分析，泻下药如大黄之类有利尿作用，并能使钾、钠的排出量明显增加，同时还有抑制钠离子在肠内吸收的作用，这对于降低血压和减轻颅内压均极为有利。

高血压危象还有一种类型，相似于中医的“戴阳证”。症状为：畏光，目不易睁，面赤，心悸，心烦，形寒嗜卧，冷汗淋漓，四肢不温，脉沉微细，血压常可高达200/120毫米汞柱（在原来高血压的基础上血压突然升高）。证属心肾阳衰（阴盛戴阳），格阳于上。治宜破阴回阳，宣通上下。

方二：制附片10克（先煎），干姜5克，葱白5枚，淡秋石10克，五味子5克，煅龙骨30克，煅牡蛎30克。水煎服。

针刺疗法

取穴太冲、合谷；或十宣放血；头痛甚者加太阳、头维、印堂点刺出血；痰甚者加丰隆、足三里豁痰。

18. 脑动脉硬化症

脑动脉硬化症系脑动脉内膜粥样硬化所致的缺血性脑动

脉功能障碍疾病，多见于中老年人。本病病久易发生中风（脑血管意外）。

临床表现

（1）中年以上年龄组，近期持续出现既往未有的头晕头痛，头昏胀痛，疲乏，嗜睡或失眠多梦，思维散乱，注意力不易集中，记忆力明显减退，尤易遗忘近事等类似神经衰弱症状。

（2）近期内逐渐发生情绪和性格的改变，如对外来的心理和精神刺激的承受力和机敏度明显改变，情绪不稳定，或表现为急躁易怒，语言增多，喋喋不休，或孤僻沉默寡言，易伤情感，处理人际关系简单幼稚等。

（3）头痛，眼胀，项紧，恶心，并且症状逐日加重。

（4）有语言障碍加重趋势，肢体麻木或震颤，甚至瘫痪，皮肤有异常感。

脑动脉硬化症可通过脑电图、脑血流图、血脂等检查确诊。

脑动脉硬化症属于祖国医学的“眩晕”范畴。中医认为，人到中年以后，易因饮食起居不节，情志失调，劳逸失度等因素导致五脏功能发生由盛而衰的病理变化。本病主要是心、肝、脾、肾等脏器功能的衰减，阴阳失调，气血亏虚，因而产生痰浊淤血等病理产物滞留脑脉，使脑脉血流失畅，脑失濡养，从而发生脑组织的功能和器质性病变。而多数脑动脉硬化的病理变化，关键在于“本虚”。本虚包括肾阴亏虚，阳气虚弱。并在“本虚”的基础上续发“标实”。标实乃脑脉淤滞和痰浊脂质留踞清空。

辨证分型治疗

（1）肾虚血淤：头晕头昏，有高血脂病史，头部刺

痛，耳鸣，眼花，午后面部烘热，失眠多梦，易忘近事，反应迟钝，四肢及指、趾麻木，右上肢颤抖，口燥咽干，舌红少津，舌边紫暗有淤斑，脉弦细。治宜益肾活血。

方药：首乌30克，枸杞15克，女贞子30克，桑椹20克，丹参30克，当归20克，桃仁10克，红花10克，泽泻30克，玉竹12克，杜仲15克，淮牛膝30克，草决明30克，黄精15克。水煎服。

(2) 气虚血淤：头晕，巅顶有重压感，颈项攀紧，耳鸣眼花，夜寐不实，记忆力明显减退，气短，胸闷，肢软无力，语言滞涩，面色萎黄，舌淡胖，有齿痕，苔白，脉弱。治宜益气活血。

方药：黄芪60克，人参叶30克，白术12克，龙眼肉12克，茯苓10克，当归30克，赤芍15克，升麻10克，葛根30克，寄生30克，丹参30克，三七粉8克(冲服)，生龙骨30克，生牡蛎30克。水煎服。

(3) 痰淤交阻：眩晕时作，晕甚欲扑，头痛如锥刺，阴雨天及夜间头部沉重作痛，伴胸闷刺痛，恶心呕吐，记忆力差，思维迟钝，形体肥胖，舌质紫暗，苔白厚腻，脉沉滑。治宜祛痰化淤。

方药：白术15克，苍术15克，法夏12克，天麻10克，茯苓10克，泽泻30克，丹参30克，山楂30克，川芎10克，桃仁10克，菖蒲10克，远志10克，三七粉8克(冲服)，莪术10克。水煎服。

耳压法

取穴：内分泌、皮质下、神门、交感、心、肝、肾。

19. 化脓性脑膜炎

化脓性脑膜炎是小儿(尤其是婴幼儿期)较常见的急性

传染病。脑膜炎球菌、肺炎球菌、流行性感菌、葡萄球菌、大肠杆菌等化脓菌均能引起脑膜炎。各种细菌所致的化脓性脑膜炎的临床表现大致相仿。

儿童时期化脓性脑膜炎发病急，出现高热，头痛，呕吐，食欲不振，精神萎靡。起病时神志一般清醒，病情进展可发生嗜睡、谵妄、惊厥和昏迷。病情严重者在起病24小时内即出现惊厥、昏迷。体格检查每见嗜睡、谵妄或昏迷、颈强直。如未及时治疗，病情加重，颈强直引起头向后仰，背肌僵硬，病儿可成角弓反张。皮肤出现出血点。病情严重者可出现呼吸节律不整及异常呼吸等中枢性呼吸衰竭症状，瞳孔改变，脑水肿进一步加重，最终引起脑疝。

婴幼儿期化脓性脑膜炎起病急缓不一，由于前囟尚未闭合，骨缝可以裂开，而使颅内压增高及脑膜刺激症状出现较晚，临床表现可不典型。先有发热、呕吐、腹泻、咳嗽，继之嗜睡、烦躁、易激怒、感觉过敏、哭声尖锐、眼神发呆、双目凝视，有时用手打头，摇头，往往发生惊厥才引起家长注意，到医院就诊。前囟饱满和布氏征阳性是重要体征，有时皮肤划痕试验阳性。

化脓性脑膜炎可通过血象检查（白细胞总数、中性粒细胞明显增加）、脑脊液检查等确诊。

化脓性脑膜炎属于祖国医学的“温病”、“暑痧”范畴。中医认为，暑邪酷烈，变化迅速，最易激动肝风。小儿稚阴未充，肝常有余，脾常不足，不论外感或内伤饮食，易从火化，使痰火内闭，发为“惊风”。其治疗，宜清热，解毒，开窍，豁痰，化湿。

方药：羚羊角2克，生石膏30克，生地15克，黄连6克，白蔻6克，丹皮6克，黄芩10克，僵蚕6克，地龙6克，佩兰6克，

杏仁6克，生大黄6克，钩藤15克，大青叶15克，苡仁15克。水煎服。并另服至宝丹一粒（分次送服）。

20. 奔走性癫痫

奔走性癫痫是癫痫病的一种类型（精神运动性发作）。发作时头痛，上肢轻微抽动，眼结膜充血，眼前出现散在性的彩色闪光点，眨眼之间意识丧失，但不昏倒，能在室内外徘徊，步态慌张而不稳，约10分钟后自行缓解。但不能回忆发病经过。每当情绪紧张、生气、劳累即易发作。

奔走性癫痫（癫痫精神运动性发作）属于祖国医学的“痫证”范畴。多由思虑伤脾，惊恐损伤肝肾，阴不敛阳，生热生风，上扰心神而发病。治宜息风安神。

方药：淮牛膝30克，代赭石30克，白芍30克，生龙骨30克，生牡蛎30克，炙龟版30克，玄参15克，天冬15克，茵陈30克，川楝子10克，白芷10克，细辛6克，羌活10克，藁本10克。水煎服。

针刺疗法

取穴：百会、哑门、风池、长强、膻中、鸠尾，平稳时平补平泻，发作时多取泻法，强刺激不留针。

21. 颅内压增高症

颅内压增高症是常见的神经系统病症。临床表现为：

①头痛反复发作，可历时数月；②痛处固定，痛如锥刺，伴

有恶心；③肢体有麻木感；④舌质紫暗，舌边有淤点。作眼底检查可发现视神经乳头边缘模糊。患者神志清楚，无抽搐。

颅内压增高症属于祖国医学“血淤头痛”范畴。《证治汇补》说：头痛“自外入者，风寒暑湿之邪；自内发者，气血痰郁之异。或蔽覆其清阳，或淤塞其经络，与气相搏，脉满而痛”。治宜活血化淤，宣通阳气。

方一：全蝎尾、紫河车各20克，研粉各分20包，1日服2次，每次服1包，温开水调服。

方二：川芎15克，赤芍30克，桃仁10克，红花10克，丹参30克，生地30克，五灵脂10克，地鳖虫10克，法半夏10克，生石决明30克，陈皮6克。水煎服。每日1剂。

颅内压增高症常伴发阴虚症候，其常心烦易怒，口苦，失眠等。治宜滋阴清热。

方三：生地30克，天冬20克，麦冬20克，玄参20克，酸枣仁15克，竹叶12克，莲子心10克，知母10克，石决明30克，泽泻30克，淮牛膝30克，猪苓15克，夜交藤30克。水煎服。

针刺疗法

取穴阴陵泉、三阴交、太冲、百会；头痛甚时可加太阳、印堂、头维点刺放血。

22. 肌肉收缩性头痛

肌肉收缩性头痛又称紧张性头痛，由于较长期的焦虑、紧张或疲乏等因素可引起颈项部、头部肌肉的持久收缩和相应动脉的扩张而产生头痛。

肌肉收缩性头痛是一种慢性头痛，大多与精神因素有关。疼痛位于两侧额枕部或颞部，有的呈束紧样疼痛（束箍样痛）。病人往往还有头部沉重、受压与闷胀感，疼痛可以日以继夜（持续）存在。检查除有局部肌肉的按痛外，其它均无异常发现。

肌肉收缩性头痛，类似于祖国医学的“内伤七情”头痛。《脉因证治》说：“头痛之证，……或两边……，恼怒即发”。中医认为本病经年累月不愈，辨证虽有阴虚、火盛的不同，但都具有病程缠绵、束箍样痛、胀闷麻木及局部肌肉发作时压痛等风邪潜伏厥阴、少阳、阳明之络，气血郁遏不通之特点，治疗必须先以峻药祛散风邪，疏通经络，再随兼证分别伍用育阴、泻火之剂。

中药治疗

方药：白芷75克，川芎30克，炙川乌30克，甘草30克，天麻30克。共研细末，每次服3克，每日服2次。

加减：兼肝火盛者以龙胆泻肝汤加石决明30克煎汤送服以上药末。胃火旺盛者以玉女煎煎汤送服以上药末。肾阴亏者用六味地黄汤送服以上药末。无明显兼证者以细茶一撮、薄荷1.5克泡水送服以上药末。

方中白芷、川芎、天麻入阳明、少阳、厥阴，去头部潜伏之风邪。乌头、白芷、川芎祛风散寒，通络止痛，为各种风寒性疼痛之要药。甘草和中益气解毒，更以细茶、薄荷清利头目之药为引，共奏祛风镇痛、疏经和血之功。如方中另加全蝎30克（研细末），疗效更佳。

针刺治疗

取穴：风池、风府、肩井、天柱、太阳、头维、后溪、合谷、足三里、昆仑。每次选用2—3穴。

手法：强刺激。

此外，对颈部肌肉的按摩、热敷，都有一定疗效。

患者对治疗应有信心，生活必须有规律，禁吸烟，禁喝酒，应坚持体育锻炼，日久自有效果。

23. 臂丛神经痛

臂丛神经痛是指在颈部和上肢臂丛神经分布区内的疼痛，可由多种病因引起，多见于成人。

臂丛神经痛可分为原发性和继发性两类，以继发性为多见。臂丛神经炎及肩神经炎常发生于受寒、流感后，邻近组织炎症，各种感染性疾病的恢复期，血清病，免疫接种或手术后。原发性患者无明确的病因。继发性臂丛神经痛则是由邻近组织病变所引起，如颈肋、颈椎病，前斜角肌综合征，锁骨骨瘤或第一肋骨的骨膜炎，锁骨下动脉瘤等均可压迫臂丛而引起臂丛神经痛。此外，动作过猛地举手及牵引向后或头部旋转及偏向对侧时，可以牵引臂丛造成神经纤维断裂。创伤、锁骨骨折、肩关节脱臼等亦可使臂丛神经遭受直接外伤，引起臂丛神经痛。

临床表现

发病呈急性或亚急性。疼痛为本病之主要症状。疼痛先见于颈部神经根部，数天后向臂及手部伸展。肢体的外侧面疼痛最剧，此时病人不能向患侧躺卧，自动抬起患侧上肢时即感到剧痛，夜间常因疼痛而影响睡眠。检查时，在下颈椎侧方、颈椎棘突、第七颈椎横突、锁骨下窝等处有压痛。旋转头部或头弯向一侧时可出现疼痛。三角肌、前锯肌、菱形

肌、三头肌、冈上肌、冈下肌等多有萎缩。患肢亦常无力。前臂运动受限制。一般在感染性臂丛病变时以感觉障碍为主，在外伤性臂丛病变时以运动障碍为主。由颈肋所致之臂丛神经痛，还有非常特殊之血液循环障碍（同侧手发冷而呈紫紺，桡动脉搏动减弱）及第七颈椎横突之压痛，同时疼痛可放射到手部。

X线摄片检查、脑脊液的动力学和化验检查以及椎管造影检查、肌电图检查等有助于诊断。

臂丛神经痛属于祖国医学的“痹证”范畴。风寒湿邪杂合侵犯人体，经络阻滞，不通则痛。治宜通络、行痹、止痛。

中药治疗

方一：威灵仙12克，羌活12克，当归30克，黄芪60克，独活12克，秦艽15克，桂枝15克，络石藤30克，乳香10克，没药10克。水煎服。

方二：威灵仙注射液4毫升，肌肉注射。

推拿治疗

（1）摩按肩周法

患者直坐，医生坐其侧。医生双手自病侧颈肩部沿肩峰与肩胛区反复摩按5—10分钟。再自患侧肩峰、三角肌处向肘部、腕部顺序向下，反复摩按5—10分钟。

摩按肩部时应摩动肌肉，不应限于摩擦皮肤。

（2）捏上臂法

患者仰卧，左或右上肢稍外展，医生坐其侧。医生以拇指掌侧置其上臂外侧，其余四指置上臂内侧青灵穴处着力捏压，反复操作1—2分钟。

再以拇指置上臂外侧，其余四指掌侧置极泉下方，自上

向下沿肱骨内缘逐步下移经青灵至少海穴止，反复操作 2—3 分钟。

（3）推按阳明三穴法

患者侧卧，医生坐其侧。医生用拇指掌侧或两拇指对置，自肩髃穴起，依手阳明大肠经各穴顺序推至合谷穴止，反复操作 3—4 分钟。在缓推的过程中，重点用拇指按压肩髃、曲池、合谷三穴。

（4）捏颈肌法

患者俯卧或直坐，头微前倾，医生坐或站其侧方。医生用两手并置一侧之枕后风池穴处，拇指在颈肌外侧，其余四指并置颈项肌内侧，将肌肉微向上提起后，再自上向下拿捏至肩中俞穴止，反复操作 3—5 分钟。左侧颈肌拿捏后再施用于右侧。

针刺疗法

取穴：风池、天柱、肩井、肩贞、肩髃、天宗、臂臑、外关、中渚等穴，平补平泻，后期可配合艾灸。

24. 腓总神经损伤

腓总神经是坐骨神经的一大分支，位于腓骨小头之下，位置表浅，易于损伤。故腓总神经损伤在临床上多见。造成腓总神经损伤的原因有腓总神经炎症，常发生在感冒（受寒）之后，神经本身受压迫，如小腿绷带或石膏、夹板固定太紧，睡眠位置不当，长久蹲位作业等。

临床表现

足下垂，足内翻，小腿外侧及足背皮肤感觉减退或丧

失，影响足步行走。

腓总神经损伤所表现的症状属祖国医学的“痿证”范畴。痿可由五脏病变引起，但与肝脾肾关系密切。故本证之主要病机为阳明之脉虚，肝肾之脉弱，宗筋失润，不能约束，缓纵不收，机关不利。因阳明属土，主约束筋骨而利机关，为后天之本，气血之化源，养五脏六腑，濡筋肉四肢。阳明脉盛，则气血充盈，宗筋得养，则足步灵利。《素问·痿论》云：“阳明者，五脏六腑之海，主润宗筋，宗筋主束骨而利机关也。……故阳明确则宗筋纵，带脉不引，故足痿不用也。”肝藏血主筋，肾藏精主骨，肝肾二脏精血盛，则筋骨壮运动有力。若邪淫阳明，经脉气虚，肝肾不足，精血亏损，则化源不充而脏腑失养，筋脉失荣而机关不利，肢节痿弱而足不能步。

对本症的治疗，当宗《内经》“治痿独取阳明”之旨，从肝肾脾胃论治。

中药治疗

方药：枸杞15克，当归30克，熟地30克，山药30克，补骨脂12克，骨碎补10克，黄精30克，仙灵脾30克，寄生30克，续断30克，复盆子12克。水煎服。

针灸治疗

取穴：患肢足三里、解溪、太冲、太溪、商丘等穴。

方法：足三里、太溪行提插捻转补法。解溪、太冲、商丘平补平泻法，针刺得气后留针30分钟，中间行针2次，起针后艾条灸足三里5分钟，每日1次，6次为1疗程。休息3天，再行第2个疗程。

25. 癔病性黑蒙症

癔病的临床症状多种多样，视觉障碍多为黑蒙。患者突然失明，这时瞳孔反射及眼球活动如常，眼底检查亦无阳性体征。患者平素多为性情孤僻，郁郁寡欢，一旦受到某种精神刺激，突然双眼看不见物体，眼科检查一切正常，但患者自诉眼前一片漆黑，每次发作（黑蒙）可持续数分钟至数小时。严重者发作频繁，一天内可发作数次。

癔病性黑蒙症属于祖国医学的“暴盲”、“脏躁症”范畴。《审视瑶函》说：“其故有三，曰阴孤，曰阳寡，曰神离。……病于阳伤者，缘忿怒暴悖。……病于阴伤者，多色欲悲伤，思竭哭泣太频之故。……伤于神者，因思虑太过，用心之极，忧伤至甚，惊恐无措，致使脏腑气机升降失常，气血功能紊乱，精气不能上奉于目，肝窍被蒙，故盲而不见也。”说明癔病性黑蒙症的发作，多与情志因素有关。其治疗，除药物外，尚须配合心理治疗，告慰患者应宽情畅怀。针对患者的病态心理，加以疏导。正如《灵枢·师传》所说：“告之以其败，语之以其善，导之以其所便，开之以其所苦，虽有无道之人，恶有不听者乎？”明确指出以诚恳的语言开导、劝说，解开病人的思想疑虑，这是治疗癔病性黑蒙症必不可少的环节。

方药：生甘草15克，大枣30克，浮小麦30克，百合30克，柏子仁15克，柴胡10克，枳壳15克。水煎服（急煎与服）。

26. 癔病性瘫痪

癔病，亦称歇斯底里，在青年女性中发病较多。其临床

症状错综复杂。癔病性瘫痪，是癔病后肢体活动障碍的一种表现。病程可长可短。肢体瘫痪是主要症状。瘫痪部位有：截瘫、偏瘫、单肢瘫、四肢瘫、三肢瘫。除肢体瘫痪外，可伴有感觉障碍，痉挛发作，精神障碍，语言障碍，听力障碍，视力障碍等。

癔病性瘫痪，其“本”在癔病。其发病因素有：精神创伤，外伤，受凉，劳累，注射药物、化学药品中毒等，或由其他疾病引起癔病。

癔病属于祖国医学之“脏躁症”范畴。其病机常在于心、肝、肾之阴液不足，而郁怒伤肝、心火亢盛每为诱因。木郁火发，木火上扰心肾，耗伤肾水。肾水亏虚则不能荣骨，肝阴不足则不能养筋，终至发生瘫痪。心神被扰又常兼失眠、多梦、惊悸、怔忡、烦躁不安，甚至不能主宰身肢而成瘫痪。

中医治疗癔病性瘫痪，首先要解除病人的精神负担，正确对待自己的疾病，做到“四相信”（即相信医生，相信诊断，相信自己的病能治好，相信一次就能治好）。药物治疗（主要针对癔病）和针灸治疗（主要针对瘫痪）并举。要做到“四相信”，医生要做到五心，对病人热心、诚心、耐心、细心、关心。只有这样才能取得病人的信赖。最好找已治好的病人现身说法，或让病人看已治好病人留下的照片、录相等，待病人有迫切要求治疗的心情时才给以针刺治疗，不治则已，下针必效。如果第一次针刺不见效，再给几次、几十次治疗也不易奏效。

中药治疗

方药：浮小麦60克，大枣60克，甘草15克，百合30克，生地15克，夜交藤60克，鸡子黄2个（分冲），栀子10克，淡豆豉10克，

莲子芯10克，**郁金**12克，**菖蒲**12克。水煎服。

本方主要针对瘧病。

加減：失眠嚴重者加遠志、龍眼肉、茯神。口干者加石斛。腰膝酸軟者加川斷、杜仲、枸杞。痰濕重、舌苔厚膩者加苡仁、薏仁、半夏。消化不良者加內金、神曲等。

針灸治療

針灸治療主要针对癱瘓。

(1) 體針

穴位：取身體最敏感的穴位，如上肢癱取寸平穴（相當於內關穴），下肢癱取泉中穴（相當於涌泉下一寸）。

手法：用22~26號2寸長的針刺入穴位，採用提插與捻轉的方法不斷加強刺激。針感出現後，可讓病人活動患肢。也可在進針後就讓病人活動患肢。在床上反復活動自如後即可起針，下床行走。

(2) 電針

穴位：涌泉穴為主穴，上肢配曲池、外關，下肢配足三里、懸鐘。

方法：常規消毒皮膚，快速將針刺入，作針刺通電，輸出電壓為6伏，斷續或持續刺激均可。通電後，患肢隨着電流的刺激而收縮或顫動，讓患者看到患肢的顫動（或收縮）。表示電針已起到治療作用，以加強暗示。

對患者一定要配合心理治療。心理治療和針刺治療是相輔相成的，兩者不能偏廢。現代醫學認為，患瘧病者主要是大腦皮質的弱化。心理治療可提高患者的信心，針刺治療可促使大腦皮質引起興奮，二者結合，使弱化的大腦皮質恢復正常。對瘧病性癱瘓患者施以針刺治療和心理治療，往往能在瞬間治愈。

27. 强迫性神经症

强迫性神经症，又称强迫症，是神经症中较少见的一种疾病。它的主要症状为各种各样的强迫现象。这是一种病人明知不必要，但又无法抗拒的观念或行为，它经常反复出现，使病人十分痛苦。

强迫性神经症病因尚未阐明。临床上主要表现为三种形式：

(1) 强迫观念：病人的思想上为一些毫无意义的想法所纠缠。这种想法明知不对但无法摆脱和难以克制。病人经常想些缺乏意义的问题，例如“走路时为什么地板会响”，“ $2 + 2$ 为什么等于4”等等。有时病人会怀疑自己做过的事没有做好，虽反复检查仍不放心，例如怀疑自己写错了字或做错了事，外出时担心家里门、窗、抽屉没有锁好、关好。自己虽未做坏事，却怀疑自己被别人当作坏人而忐忑不安。也有些病人在接触某些事物或词句时就有相反的观念出现，例如听到、看到“高大”、“寒冷”的字句时，脑子里立即出现“矮小”、“暑热”等相对立的概念。

(2) 强迫行为：即明知没有必要而又不可克制的行为。如每逢看见电线杆、石块、柱子等便抑制不住要依次触摸或点数。也可有反复地洗手、洗衣等行为。常与强迫观念同时存在。

(3) 强迫情绪（又称“恐怖症”）：对某些事物或环境产生不必要的恐惧感而无法控制。如怕上高楼，怕经过广场，怕细菌、怕患癌，怕脏物，怕灰尘，怕高空，怕黑夜，

怕火，怕水，怕刀剪，怕绳索等。反复洗手，大便后反复用纸擦肛门（怕脏）。

因为病人知道自己的想法或行为是完全不必要的，而且怕别人讥笑，因此在一般情况下总是尽量掩饰，以免被人察觉。强迫观念出现时病人总是焦虑不安，严重的甚至会出现消极自杀的想法。

病人除上述强迫症状外，其他均正常，并且迫切求治。因此，这种病容易诊断。

强迫性神经症属于祖国医学的“癡证”范畴。中医认为多由思虑太过，心脾受损；心阴不足，神失所主，或情志不舒，肝气郁结，疏泄无权，横逆犯脾，脾失健运，内生痰湿，痰气郁结，上蒙心神，导致本病。其治疗，宜健脾豁痰，活血化淤，宁心安神。

方一：夜交藤60克，酸枣仁15克，柏子仁12克，当归30克，茯苓30克，陈皮10克，法半夏10克，甘草6克，菖蒲12克，远志12克，竹茹12克。水煎服，连服数月。

方二：丹参30克，郁金30克，红花30克，生地30克，桃仁12克，赤芍30克，川芎10克，三棱10克，莪术10克，当归30克，香附15克，生龙骨30克，生牡蛎30克。水煎服。连服半年。

针刺治疗

取穴：太阳、内关、合谷、太冲、足三里。

方法：每次取2—3对穴位，得气后留针半小时左右，每日针1—2次，疗程3个月。

28. 躁狂抑郁症

躁狂抑郁症，又名情感性精神病，是以情感障碍为原发

症状的精神病。本病可仅有躁狂状态发作，称为躁狂症；或仅有忧郁状态发作，称为抑郁症。也可两者兼有，交替发作，称为躁郁证。通常，把前两者称为单相情感性精神病，把后者称为双相情感性精神病。

本病常反复发作，自行缓解。

临床表现

多数起病较急。躁狂症发作时，以情绪高涨、思维敏捷、动作增多为基本症状。抑郁症发作时，以情绪低落、思维迟缓、动作减少为主要表现。躁狂抑郁症患者躁狂状态和抑郁状态可交替出现或混合出现。

(1) 躁狂症：情绪高涨是躁狂症最基本的症状。表现持久而强烈的兴奋和喜悦。患者眉飞色舞，谈笑风生，兴致勃勃，洋溢着欢乐的情绪，使接触他的人也感到轻松愉快，具有能“感染”旁人的特点。但患者自制能力很弱，稍不称心便可暴跳如雷，片刻后又呈现高涨的基本情绪。严重患者可呈激烈忿怒，谩骂不休，缺乏欢乐感情。

思维敏捷是本病的另一个特征。患者联想迅速，口若悬河，滔滔不绝，一个话题未完，另一个话题又开始。

动作增多。患者整天忙碌不停。可能订出许多好高骛远的计划，但往往虎头蛇尾，一事无成。自觉才智过人，精力旺盛。到处走访，提出各种“建议”，并对人横加指责和干涉。趾高气扬，自高自大。患者可能一反往常节俭谨慎习惯，乱交异性朋友。衣着阔绰，穿红戴绿，挥金如土，特别慷慨。严重患者通宵不眠，声嘶力竭。

强烈而高涨的情绪可影响判断力，自我评价过高，形成夸大妄想。妄想内容不断变更，可根据医生或旁人的提示随口杜撰，即兴而就，随即又加以否定。

躁狂症患者面色红润，体温略高，代谢旺盛，食欲亢进，口渴多饮，月经改变，性欲亢进。

（2）抑郁症：情绪抑郁是最突出的症状。开始时，往往先有无精打采、乏力、失眠等，常误诊为神经官能症。症状充分暴露时，患者情趣极为低落、忧伤，对任何事物都失去兴趣。“忧念丛生，悲观失望，消极厌世。

思维迟钝也是抑郁症的一个明显症状。病人自己感到“脑子变得迟钝”，无力胜任任何工作，把自己看成是废物和寄生虫。有的病人把过去的错误缺点无限上纲，从而形成罪恶妄想。在罪恶妄想的支配下，病人可能拒绝进食，认为自己“不配吃饭”，“不配做人”，因而产生自杀行为。有的病人把自己体内的一些不适，如便秘、纳减、胸闷等看成是不治之症，认为内脏已经腐烂，心肺不复存在。

病人呆滞少动，应答迟钝。严重时病人终日不言不动，卧床不起（忧郁性木僵），自杀的危险性很大。有的病人有幻觉幻听。

抑郁症症状常昼重夜轻。午后或傍晚症状减轻。早晚病情判若两人。

抑郁症患者体重下降，胃纳不佳，性欲减退，便秘，心率改变，失眠。

（3）躁狂抑郁症：躁狂症状和抑郁症状交替出现。

躁狂抑郁症属于祖国医学的“癫狂”、“郁症”范畴。多由情志所伤，忧思恼怒，导致脏腑阴阳失调，心神失主。痰火上扰则发为狂症，痰气郁结则发为郁症。两者还可以相互转化，或同时出现。

辨证分型治疗

（1）痰火扰心：狂躁易怒，叫骂不休，不避亲疏，登

高而歌，气力过人，舌红苔黄腻，脉滑数。治宜镇心涤痰，泻肝清火。

方药：青礞石15克，大黄15克，黄芩10克，芒硝10克(冲)，枳实12克，胆南星10克，菖蒲10克，龙胆草10克，黄连10克。水煎服。

(2) 痰气郁结：精神抑郁，表情淡漠，寡言少语，反应迟钝，悲观失望。舌淡苔白，脉弦滑。治宜理气解郁，化痰开窍。

方药：半夏12克，橘红12克，胆南星10克，枳实12克，木香₁₀克，香附12克，菖蒲12克，郁金12克，茯苓12克，川贝母6克。水煎服。

针刺治疗

(1) 躁狂症：主穴取百会、翳风。配穴取人中、少商、曲池。耳穴取肝、胆。

(2) 抑郁症：主穴取百会、翳风。配穴取合谷、足三里。耳穴取心、内分泌、交感。

29. 坏血病

坏血病又名维生素C缺乏综合征，是缺乏维生素C(抗坏血酸)所引起。

维生素C缺乏后数月，患者全身乏力，食欲差，精神抑郁，小儿生长迟缓，烦躁不安，消化不良，并有下列症状出现：

(1) 出血：全身可有出血点，开始时只是牙龈易于出血，继则皮下组织、肌肉、关节、腱鞘等处均有出血，形成

血肿或淤斑。小儿淤斑多见于下肢。内脏、粘膜亦可有出血现象，如鼻衄、血尿、便血及月经过多等。

小儿常见下肢肿胀、疼痛。两腿外展，小腿内弯，呈假性瘫痪状。局部皮肤温度略增高。

(2) 牙龈炎：牙龈肿胀、发炎、疏松、易于出血，牙齿疏稀，牙龈萎缩，牙根浮露，最后牙齿松动而脱落。

(3) 毛囊角化：毛囊周围出血，毛发易折断或卷曲，毛发部位轻易损伤后即可出现淤斑。

(4) 其他：虚弱，低血压，呕吐，抵抗力弱，易受各种感染，伤口愈合缓慢，浮肿，脸色苍白等。

血液检查：维生素C浓度低。经维生素C作诊断治疗后，见效迅速。

坏血病属于祖国医学的“虚证”、“血虚”范畴。气血虚弱，不能外荣肌肤，故见淤斑，治宜补益气血。

方药：大枣30克、蜂蜜30克，韭汁30克，梨汁30克。大枣洗净，去核，用蜂蜜、韭汁、梨汁调匀后口服，不需煮熟。

30. 失血性贫血

失血性贫血是由于各种不同的原因引起血液流失至血管外，使血容量和血红蛋白量低于正常而产生的一组临床症候群。

急性失血的常见病因有：胃、十二指肠溃疡、胃癌，肝硬化食道静脉破裂，慢性胃炎，不明原因之胃出血，伤寒，肝脾破裂等出血；血友病，血小板减少性紫癜，急性白血病，再生障碍性贫血等的出血；宫外孕，前置胎盘等引起的大

出血，各种外伤引起的出血。

慢性失血的常见病因有：溃疡病、胃癌的慢性失血，内痔、肠息肉、肠钩虫病等的出血。

急性失血的症状随出血量增加而加重。失血量500毫升（占全血容量10%），常无症状，失血量达1000毫升时（占全血容量20%）就会出现面色苍白，直立活动时心动过速和轻度低血压。失血量达1500—2000毫升时（占全血容量30—40%），就会出现心动过速，出现显著体位性低血压，皮肤出冷粘汗，缺氧，头疼，常引起虚脱。失血量达2500毫升时（占全血容量50%），就会出现严重休克，常引起死亡。

如果失血量虽大于50%（2500毫升），但失血速度较慢，症状就相对轻一些。急性失血最大危险是脑缺血昏迷；冠状动脉缺血性心肌梗塞和肾小管缺血性坏死。

急性失血除输血急救外，可配合用中药治疗。

失血性贫血属于祖国医学的出血引起的“血虚”范畴。主要与心、脾、肝、肾四脏有关。治疗当以“虚者补之”，“损者益之”为大法。

辨证分型治疗

（1）心血虚：心悸怔忡，头晕眼花，失眠多梦，面色萎黄或苍白，舌淡苔白，脉细弱。治宜养心安神。

方药：红参10克（嚼服），麦冬30克，五味子20克，酸枣仁15克，柏子仁15克，黄精30克。水煎服。

（2）脾气虚：食少，倦怠，头晕目眩，少气懒言，乏力，自汗，大便溏薄，舌淡，脉虚无力。治宜益气健脾。

方药：红参6克（嚼服），茯苓15克，白术15克，甘草10克，陈皮10克，扁豆12克。水煎服。

（3）肝血虚：头晕目眩，目涩，耳鸣胁痛，惊惕不

安，手足麻木，甚至抽搐，妇女月经涩少，舌质淡，脉弦细。治宜补血养肝，活血化淤。

方药：当归30克，熟地20克，赤芍30克，川芎12克，女贞子30克，柴胡10克，香附15克，丹参30克，枸杞15克，黄精30克。水煎服。

（4）肾阴虚：腰酸，耳聋，咽痛，颧红，两足痿弱，视物模糊，舌红绛，少津，脉沉细无力。治宜补肾养血，滋阴降火。

方药：知母12克，黄柏12克，熟地30克，山萸15克，山药30克，丹皮12克，茯苓15克，泽泻30克。水煎服。

（5）气随血脱：面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，目眩头晕，心慌气短，干渴欲饮，甚者二便失禁，人事不省，舌淡，脉微细或芤。治宜补气固脱。

方药：红参10克（另炖），附片20克（先熬），生牡蛎30克。水煎灌服或鼻饲。病情缓解后，随证调理。

31. 行军性血红蛋白尿

行军性血红蛋白尿是由于长途步行或跑步引起红细胞在微血管中机械性损伤的一种急性溶血性贫血。这种病人在骑自行车或游泳后并不发病，只是在长途步行或跑步后才出现症状，故称之为行军性血红蛋白尿。患者长途步行或跑步后，感腰痛，腿酸，腹痛，同时出现一过性酱油色尿，6～12小时后尿色正常。症状很快消失，可有肝脾肿大，但很少发生黄疸。

以上症状可反复发作（发作于长途步行或跑步之后）。

行军性血红蛋白尿与阵发性睡眠性血红蛋白尿不同，前者发生于长途步行或跑步之后，后者发生于睡眠之后。

行军性血红蛋白尿经血液、尿液检查可确诊（血浆游离血红蛋白升高，结合球蛋白降低，尿中含有大量血红蛋白）。

行军性血红蛋白尿属于祖国医学的“尿血”、“虚劳”范畴。多由脾虚不运，脾不统血所致。治宜健脾补虚。

方药：苡仁30克，茯苓30克，苍术15克，藿香10克，白茯苓10克，白术15克，党参30克，蝉衣6克，续断30克，琥珀10克，小蓟15克，仙鹤草30克。水煎服。

32. 遗传性出血性毛细血管扩张症

遗传性出血性毛细血管扩张症是一种常染色体显性遗传性疾病，以全身毛细血管扩张、出血为特征。

本病有遗传史，可从早期出现症状，即从幼年就有出血表现，随着年龄增加，出血加重。

临床表现

（1）毛细血管扩张：表现在皮肤、睑结合膜、眼底、鼻、唇、口腔、舌、上腭、牙龈、面部、指甲床、躯干、消化道、呼吸道、泌尿道、肝、脾、神经组织；可形成肺动静脉瘘或其他部位动静脉瘘，严重病例可触到震颤，听到杂音。扩张为三型：结节型、蜘蛛样和血管瘤样。加压部分褪色。

（2）出血：凡毛细血管扩张部位均可出血，以反复鼻衄（鼻出血）为特征。也有消化道出血、血尿、咯血、皮肤出血。出血均为自发出血或轻微创伤后出血不止。

（3）其它表现：多次出血可形成贫血，由于供血不足

可形成杵状指（趾）或反复脑栓塞。

毛细血管镜检查，可发现毛细血管异常分布排列。

遗传性出血性毛细血管扩张症属于祖国医学的“血证”范畴。其发生发展主要与肺、脾、肝、肾有关。临床表现为肺热、血淤、气虚等证型，治宜凉血、活血、益气。

辨证分型论治

（1）肺热：鼻燥衄血，口干咽燥，甚者咯血，伴发热，齿衄，舌质红，苔薄，脉数。治宜清泄肺热，凉血止血。

方药：菊花30克，桑叶15克，芦根30克，杏仁10克，山梔10克，黄芩12克，生地30克，赤芍30克，茜草12克。水煎服。

加减：失血伤阴，失眠烦躁者加玄参、麦冬、生牡蛎。肝火偏旺，头痛目赤者加龙胆草、茵陈、黄连。

（2）血淤：肌衄，血色暗，淤斑紫黑，身倦乏力，口渴不欲饮，舌质红绛或有淤斑，脉细涩。治宜活血化淤。

方药：三七粉3克（冲服），阿胶12克（烊服），桃仁12克，红花12克，当归20克，熟地30克，赤芍30克，川芎10克。水煎服。

（3）气虚：鼻衄，齿衄，皮肤淤斑，甚至吐血、便血、尿血，面色苍白，神疲乏力，头晕，耳鸣，心悸，舌淡红，脉细无力。治宜补气摄血。

方药：党参30克，白术15克，茯苓15克，黄芪60克，当归30克，川芎10克，赤芍30克，仙鹤草30克，茜草12克，三七粉8克（冲服），小蓟12克。水煎服。

加减：吐血加侧柏叶、白及粉。便血加槐花、地榆炭。尿血者加琥珀、大蓟。眼底出血加生地炭、蒲黄、荷叶、生石决明、龟板胶。肾阳虚（腰膝酸软、怕冷）者加淫羊藿、干姜、补骨脂、鹿角胶。肾阴虚（腰酸、失眠、口干不思饮、耳鸣）者加枸杞、女贞子、沙参、麦冬、龟板等。

33. 老年性紫癜

老年性紫癜多发生于60岁以上较消瘦的老年人。老年人血管弹性降低，且皮下组织减少，影响到毛细血管床支持构架，因而受到轻微损伤即可发生出血。

临床表现

身体暴露部位如面部、颈部、手背或衣服易摩擦部位的皮肤，可自发地出现紫癜。受轻微外伤亦可出现紫斑，口腔粘膜偶然可出现紫癜。

毛细血管脆性试验阳性。其他实验室检查均正常。

老年性紫癜属于祖国医学的“肌衄”范畴。年老体衰，气虚不能摄血，发为肌衄。治宜补气摄血。

中药治疗

方药：黄芪60克，当归30克，党参30克，三七粉3克（冲服），丹参30克，赤芍30克，生地30克，山萸15克，茜草12克，阿胶15克，首乌15克。水煎服。

34. 血栓性血小板减少性紫癜

血栓性血小板减少性紫癜，有溶血性贫血、血小板减少、神经系统症状三大特征。本病的病因尚未阐明。本病可发生于新生儿至70岁以上的老年人，常见20—40岁，女性多见。

临床表现

（1）暴发性发病或缓慢发病，起病时90%病例有发

热、关节疼痛、胸腹部疼痛及血管痉挛性苍白和发绀。

(2) 继则出现溶血性贫血、黄疸。

(3) 神经系统症状：头痛、昏厥、麻木、抽搐，神志障碍以至昏迷。

(4) 皮肤、口腔、牙龈、鼻出血、视网膜出血，血尿，呕血，黑便，妇女月经过多。出血主要由于血小板减少及凝血因子减少。

(5) 少数病例可出现肾功能不全，胰腺、胃肠道梗死及心脏传导障碍，部分病例肝脾轻度肿大。

血液检查：血红蛋白低于6克%，血小板只1—5万/立方毫米，血中胆红素升高，患者可有尿蛋白及血尿。

血栓性血小板减少性紫癜属于祖国医学的“血淤”、“发斑”等范畴。中医认为造成出血的原因虽多，其内因性出血的发病原理，却不外乎火热、气虚与血淤三类。淤血内蓄（血栓），血脉阻滞，流行不畅，致血不循经，可致出血。治宜活血、化淤、止血。

方药：丹参15克，赤芍30克，川芎15克，熟地15克，当归30克，桃仁12克，红花12克，炒蒲黄12克，五灵脂12克，麝香0.1克（冲服），川牛膝30克，三七粉8克（冲服），三棱10克。水煎服。

35. 血小板无力症

血小板无力症是遗传性疾病。常在儿童期开始发病，男女均可患此病，随着年龄增长，病情可减轻。

临床表现

皮肤、粘膜自发性出血，呈散在紫癜，鼻衄，齿衄。也

可发生血肿、咯血、尿血、关节腔及胃肠出血，妇女月经过多，分娩后可有大量出血，创伤或手术后可出血不止。

检查患者的血小板的数量并不减少。但血小板的功能低下无力，因此同样可以出现紫癜，故称血小板无力症，又称血小板衰弱症。

实验室检查：血小板计数正常，但不聚集，形态异常。出血时间延长。血小板体内粘附力降低。血块不收缩，凝血酶原消耗不良。

血小板无力症属于祖国医学的“血证”、“衄血”、“虚证”范畴。中医认为气虚不能摄血，脾虚不能统血，是本病的病因病机。治宜健脾益气，以资生血之源，气足则能摄血。

中药治疗

方药：红参5—10克（嚼服），山药30克，莲米10—30克，大枣30克，黄精10—30克。水煎服。

剂量随年龄而定，小儿剂量酌减。

36. 血友病

血友病是先天遗传性疾病，常因轻微损伤而引起严重出血。包括血友病甲、乙、丙三型。

出血是血友病的主要特征。小儿出生数周即可发生出血现象。随着年龄增长，出血症状可逐渐减轻。血友病的出血往往是自发性的出血，或轻微外伤可引起持续数小时、数日、数周的出血。血友病丙出血症状较轻，血友病甲、乙常出现如下症状：

(1) 皮肤、粘膜、肌肉出血：常发生于轻微外伤，如拔牙及扁桃腺手术后，出现皮肤粘膜淤斑、皮下血肿、肌肉出血，形成深部血肿。血肿可压迫周围组织器官，产生麻痹、坏疽；口、咽、鼻、颈部血肿甚至可引起窒息。

(2) 内脏出血：可发生在胃、肠、腹膜后，引起腹痛、呕血及便血；肺出血可发生大咯血，泌尿系出血可发生血尿，颅内出血可引起死亡。

(3) 关节出血：这是血友病的特征，多发生在踝、膝、肘、腕、肩及髋关节，有红肿热痛，酷似急性炎症。肿胀的关节张力很大，以致可发生肌肉痉挛、关节活动受限。出血停止后，血肿慢慢吸收，功能可完全恢复。多次出血，可使关节发生畸形、骨质破坏或呈慢性炎症。

血友病可通过血液检查(凝血活酶生成试验等)而确诊。

血友病属于祖国医学的“血证”、“虚劳”范畴。多因先天血脉脆弱，脏腑失调，气不摄血。气失统摄，不但脾虚失统摄之权，肾之元气亦弱。治宜摄脾固肾，或助肾之元阳。

方一：仙灵脾30克，鹿含草30克，黄芪30克，党参30克，当归20克，白芍30克，生牡蛎30克，鸡血藤30克，木瓜20克，三七粉3克(冲服)，阿胶15克，茜草10克，生地30克，仙鹤草30克，乳香5克，没药5克。水煎服。

方二：生花生米100—200克，嚼服(一日量)。长期连续服用。

37. 糖尿病酮症

糖尿病酮症是糖尿病患者严重缺乏胰岛素时，不能很

好利用体内葡萄糖，促使脂肪加速分解为脂肪酸，在体内生成酮体，酮体产生的数量、速度超过组织利用的数量、速度时，则血中酮体升高，成为酮血症。大量酮体从尿中排出，而为酮尿症。酮血症和酮尿症统称为糖尿病酮症。自觉症状有：渴饮无度，头晕头昏，恶心呕吐，小便多。

酮体是酸性的物质，若在体内继续增多，可以引起酮症酸中毒，乃至出现酸中毒昏迷、循环衰竭、肾功能衰竭等，对人体危害很大。因此，及时积极有效地治疗糖尿病酮症，以减少或制止酸中毒昏迷的出现。

糖尿病酮症可通过空腹尿糖、尿酮检查等确诊。

糖尿病酮症属于祖国医学的“阴虚燥热”范畴。中医认为糖尿病的病机，阴虚为本，燥热为标。由于津血同源，阴津耗伤则津血亏少，阴不化气，气虚鼓动无力，血运更滞，导致血淤，淤而化热，热则不仅伤阴，而且克伐正气，致气机运化失常，浊邪壅塞。于是“阴浊”、“淤热”蓄积停留体内，清阳受阻不得升，浊阴不得降而上逆。燥热、血淤、浊邪三者为患，互为因果，形成恶性循环，遂致气阴两伤，使病情不断加重。治宜清热解毒，养血调血，消除酮症。

方药：生黄芪40克，黄芩15克，黄连15克，黄柏15克，栀子20克，当归20克，赤芍15克，生地30克，川芎15克，茯苓15克，泽泻15克。水煎服。

加减：头痛头晕者加夏枯草、钩藤、生石决明、菊花；胸闷刺痛者加红花、丹参、山楂；渴饮无度者加石斛、玉竹、生石膏、知母；恶心呕吐者加陈皮、竹茹、代赭石、旋覆花；小便频多者加五倍子、桑螵蛸、复盆子，疮疡疖肿者加蒲公英、银花、马齿苋、紫花地丁。

38. 骨质疏松症

骨质疏松症多见于老年人，多由于钙、锰、硼的缺乏或其他原因，降低了骨骼硬度，因而导致本病。

骨骼是有机组织，也是身体的架构。正常人在 35 岁时，骨骼最坚硬，此后逐渐减弱。这种现象妇女特别显著。妇女初患骨质疏松症时，她们的骨骼强度不及男人的 30%。妇女在 35 岁后，骨质疏松症发展较快，在停经后，更是加快。日常生活中可以见到一些老年妇女，遇到轻微的碰撞，就发生了骨折，这就是得了骨质疏松症的缘故。骨质疏松症的病因和分类有以下几种：

（1）老年性和绝经期后骨质疏松：这一类型的骨质疏松随年龄而增长，主要因性激素水平低下，蛋白质合成性代谢刺激减弱，成骨细胞功能减退，基质形成减少。

（2）内分泌性：除性腺功能减退外，骨质疏松尚可见于皮质醇增多症，长期使用糖类皮质激素，肢端肥大症及甲状腺机能亢进症患者。

（3）废用性：各种原因的废用，如石膏固定，瘫痪或严重关节炎，由于不活动，不负重，对骨骼的机械刺激减弱，可造成肌肉萎缩，骨形成作用减少，骨质吸收作用增加，形成骨质疏松。

（4）营养性：蛋白质缺乏，骨有机基质生成不良。维生素 C 缺乏也可影响基质形成。饮食中长期缺钙（每日不足 400 毫克），也可导致骨质疏松症。饮食中缺锰、缺硼也可导致骨质疏松。美国一位篮球超级球星常出现骨折，患了骨质

疏松症。医生分析这位运动员的血液时，发现他血中没有锰，锌和铜的含量亦不足。这位球星在服用了矿物质补充剂和改变饮食后六个星期，又生龙活虎地重返球坛了。此后科学家又对动物和人进行锰剂试验，其结果都说明锰缺乏是引起骨质疏松症的原因之一。美国农业部的一份研究报告说：微量元素硼在预防老年妇女的骨质疏松症方面起着重要作用。

（5）遗传性：骨质疏松症的发病与遗传也有关。

临床表现

患者常有周身骨痛，乏力，登楼或体位改变对骨痛和乏力更明显。机体活动受到严重障碍，时间久了下肢肌肉往往有不同程度的萎缩。如合并有脊椎压缩骨折，患者的身高可缩短。或因胸廓畸形使肺活量减少，从而影响心肺功能。

骨质疏松症可通过X线检查及腰椎指数测量法诊断。

骨质疏松症属于祖国医学的“痿症”等范畴。中医认为“肾主骨”，肾精的盛衰与骨骼的生长代谢有密切关系。肾精足，髓腔充，则骨骼坚；肾精亏，髓腔空，则骨骼脆。

《素问·上古天真论》说：“男子八岁，肾气实，发长齿更……，七八……天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆实，八八则齿发去”。“女子七岁，肾气盛，齿更发长，……七七，任脉虚，太冲脉衰，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也”。详细地阐明了年龄与肾精盛衰的关系。根据目前对肾职能的研究表明，肾虚者有丘脑-垂体-性腺轴功能减退，性激素分泌下降，从而导致机体成骨功能减退，发生骨质疏松。说明肾虚是发生骨质疏松症的重要因素。因此，骨质疏松症的治疗应以补肾益精为主。

中药治疗

方药：女贞子30克，菟丝子30克，枸杞15克，山药30克，补

骨脂15克，黄芪30克，茯苓15克，淮牛膝30克，骨碎补10克，川断30克，狗脊30克。水煎服。

预防

(1) 多吃含钙食物：含钙较多的食物有：牛奶、牡蛎、鸡蛋、黄豆及豆制品、猪骨头汤、鱼、虾、干贝等。萝卜缨、白菜、芹菜、油菜、蒜苗、韭菜、红枣、柿子、橄榄等含钙量也高。

吃的食物中要是脂肪太多，会影响钙的吸收。而食物中加点醋，却能促进食物中钙的溶解，使人容易吸收钙质。

还有一点，钙在人体内的吸收和利用常受其他成份的影响。影响钙吸收利用率较大的是磷的配比量。当钙和磷的比例在1:1—1:2时，钙的吸收率最高。在食品中，钙磷之比在此范围内要数水产品了。如牡蛎、鳗鲡、凤鲊、梭子蟹等可食部分含有的钙磷比例均在1:1—1:2的最佳范围内。鱼类等水产品内还含有吸收钙必需的维生素D，这是牛奶等含钙食物所不及的。

国外学者认为，鱼类等水产品，其含矿物质种类和数量都比畜肉丰富。如日本，土壤中含钙量少，水和蔬菜中含钙量也相对大为减少，所以，日本人多以吃小鱼和海藻来补充钙的不足。他们吃小鱼时，几乎整条地吃下去，这样可以保证钙的充分吸收。

我国水产品很丰富，特别是淡水鱼的生产发展很快，而淡水鱼内钙的含量有的比海水鱼还多，而且钙在淡水鱼肉内是同蛋白质结合在一起的，更有利于消化和吸收。

鱼类罐头和其他的一些蛋类加工品，一般都能连鱼骨头一起食用，也有利于钙的吸收。

(2) 补充含硼食物及含锰食物：含硼食物有苹果、梨、

葡萄、坚果仁、绿叶蔬菜、豆科植物等。

含锰食物有麸皮、菠菜、茶叶等。但麸皮、茶叶中的锰不易为人体吸收，而肉类、牛奶、鸡蛋等食物中的锰虽含量甚微，但生物利用率较高，是重要的锰的食物来源。

(3) 从事适当的体育运动，如慢跑、散步、骑自行车、登山、跳舞等等，特别是在阳光下的体育运动，更能获得维生素 D，有利于食物中钙的吸收，有利于预防骨质疏松症。

39. 大 骨 节 病

大骨节病是一种慢性、进行性的以骨关节增粗畸形、肌肉萎缩、运动障碍为特征的地方病。病因尚不清楚。这种病主要流行于我国吉林、黑龙江、辽宁、山西、陕西、甘肃、河南、内蒙古等地。患者如离开病区，症状可以减轻或延缓发展，轻者可自愈。若重返病区，病情仍可继续发展。非病区的健康人迁入病区后也可得病。因此，有学者认为此病与水质不良、微量元素中毒或缺乏、粮食真菌中毒等因素有关。

临床表现

起病缓慢，患者早期无明显症状，有时感觉疲乏及四肢运动不灵活，特别是在早晨，需要活动一番才能运动自如。指、趾及小腿可有痉挛及隐痛。检查可发现指、腕、肘、膝、踝关节有触痛和不定时的捻发样摩擦音，手指末节轻度向掌侧弯曲，尤其是食指。

病情进一步发展，患者疲乏加重，四指关节疼痛，小腿和前臂发痛，工作或行走后疼痛加重。四肢关节运动更不灵

活。检查可见手指关节或膝踝关节稍微增粗。指、腕、肘、膝、踝关节有轻度伸展和屈曲困难，肘关节不能完全伸展。四肢关节内出现明显而恒定的捻发样摩擦音。手、前臂及小腿肌肉轻度萎缩。此时身材高低尚如常人，尚可负担一般的体力劳动。患者可有轻度扁平足。

病变发展至第二度时，患者精神及体力更差，行走不便，尤其下坡时更感困难。只能从事轻的劳动。关节显著疼痛。病人出现短指畸形，握拳时指头不能接触掌面。肘关节痉挛性屈曲。四肢肌肉明显萎缩。关节突然剧痛。扁平足较重。

病变达第三度时，患者活动困难，行走时呈现鸭步，有极明显的短指畸形，身材矮小，双手不能握拳。肘关节屈曲极为明显，无法伸展到150度。四肢肌肉极度萎缩，腰椎前弯。劳动力极度减退，甚至丧失劳动能力。智力发育则正常。

如果病变尚处于第一度时，能离开流行区，疾病可不再发展而日趋恢复。达第三度时，恢复则困难。

本病对生命无直接威胁，对生殖能力也无明显影响，但对劳动力影响甚大。

本病可通过X线检查等确诊。

大骨节病属于祖国医学的“骨痹”、“筋痹”范畴。俗称“矮人病”、“算盘子病”、“柳拐子病”、“水土病”。中医认为多系起居不慎，水土不服，风寒湿三气杂至，合而为痹。初病在腑，病久入脏，肝肾终受其害。且肝主筋，肾主骨，肝肾病损则筋骨失养，筋骨的发育和成长失其常度，出现四肢屈伸不利，筋肉萎缩，甚至骨节增粗、畸形，身材矮小，短指，鸭步跛行。

辨证分型治疗

(1) 肝肾虚损：身材矮小，短指，关节增粗，屈伸不利，肌肉瘦削，四肢无力，舌淡，苔白，脉沉缓。治宜补益肝肾，强筋壮骨。

方药：熟地30克，仙灵脾30克，山萸12克，肉苁蓉15克，菟丝子15克，枸杞15克，麦冬15克，五味子15克，白芍15克，鹿角胶10克。水煎服。

(2) 风寒湿痹：关节疼痛，活动不便，四肢困重，腕闷，纳呆，大便不爽，苔白腻，脉弦滑。治宜散寒除湿，祛风止痛。

方药：防己15克，黄芪30克，桂枝15克，秦艽15克，茯苓15克，白术15克，独活12克，羌活12克，寄生30克，威灵仙12克。水煎服。

针刺治疗

指腕关节疼痛：合谷透后溪，八邪，外关。

肘关节疼痛：曲池透少海，四渎，支沟。

肩关节疼痛：肩井，肩髃，肩贞透极泉。

髋关节疼痛：大肠俞，闭孔，骨边，殷门。

膝关节疼痛：阳陵泉透阴陵泉，下五里，足三里。

趾踝关节疼痛：悬钟透三阴交，太溪斜刺昆仑，八风。

验方治疗

(1) 玉米秆灰、谷草灰、麦秆灰共1.5公斤，加水5公斤充分搅拌，浸泡一昼夜，然后取其澄清液过滤，煮沸浓缩成1.5公斤即成。每日服3次，每次服20毫升，一个月为一疗程。

(2) 松节75克，蘑菇5克，红花5克，加水50毫升，熬至25毫升，过滤后加白酒5毫升，每次服10毫升，每日2次。

40. 莱特氏综合征

莱特氏综合征又名关节炎、尿道炎、结膜炎综合征，属变态反应性疾患，多发于痢疾后，青年男性常见。首先出现尿道炎，继则出现结合膜炎、关节炎及皮肤粘膜损坏，伴有发热，乏力，纳差等症。莱特氏综合征的病因尚未阐明。患者的白细胞增高，血沉增快。

莱特氏综合征属于祖国医学的“痹证”范畴。多系内有蕴热，与风湿相搏，或风寒湿痹郁久化热，流注关节经络。治宜祛风除湿，蠲痹通络。

辨证分型治疗

（1）风湿热型：病势急重，骨节红肿，焮热剧痛，不可屈伸，发热烦渴，咽干喉痛，喜饮量少，尿黄便秘，舌质红绛，苔黄厚腻，脉滑而数。治宜清热利湿，祛风通络。

方药：生石膏30—90克，知母12克，黄柏12克，银花藤30克，鸡血藤30克，蚕砂30克，赤芍15克，丹皮12克，土茯苓30—90克，地龙12克，桂枝10克，生大黄10克，山豆根12克，板蓝根30克。水煎服。

（2）风寒湿型：骨节漫肿，皮色不红，疼痛如掣，屈伸不利，痛处固定，畏寒喜暖，面色㿔白或萎黄，舌质淡嫩，苔白腻，脉弦紧或弦缓。治宜温经通络，利湿蠲痹。

方药：制川乌15克（先煎），桂枝12克，白芍20克，麻黄12克，苍术15克，黄芪30克，土茯苓30克，五加皮12克，乌梢蛇12克，细辛6克。水煎服。

(3) 寒热相兼型：骨节肿胀，灼热疼痛，反喜温熨，屈伸艰难，日轻夜重，舌质稍红，苔腻微黄，脉濡小数。治宜温经散寒，除湿清热。

方药：桂枝12克，白芍30克，麻黄10克，知母12克，苍术15克，黄芪30克，土茯苓30克，鸡血藤30克，地龙12克，蜈蚣8条，防风12克，甘草10克。水煎服。

加减（适用于以上三型）：尿频尿急、尿道灼痛、尿赤混浊、淋漓不尽、尿道口红肿、龟头糜烂溃疡者加败酱草30克，马齿苋30克，台乌12克，牛膝12克；白睛红赤，灼痛羞明、眼屎多、干涩流泪、视物不清、对光反射迟钝者加木贼15克，菊花15克，白蒺藜12克，蝉衣10克。腹痛泄泻，里急后重，便脓血或泻下粘液胶冻者加黄连10克，木香10克，白头翁30克。

验方治疗

(1) 昆明山海棠片，每日3次，每次2片，（每片含昆明山海棠浸膏0.25克）饭后服，连服2个月。

(2) 雷公藤15克（浸炙），陈皮6克。水煎服（饭后2次分服，此为1日量）。

注：雷公藤能降低毛细血管通透性，抑制滑膜炎性渗出，并能止痛消肿，见效快并无激素作用。

41. 庆大霉素肾损害

庆大霉素肾损害系指注射庆大霉素后引起的肾脏损害，其中包括氮质血症、急性肾功能衰竭等。

临床表现

头昏，乏力，纳呆，恶心，呕吐，腰酸胀疼痛，耳鸣，

面色萎黄，眼睑浮肿，心率增快，血压一过性增高，肾区叩痛或触痛。

患者肌酐增高，尿素氮增高。

庆大霉素肾损害一旦确诊，应立即停用庆大霉素，并采取相应措施治疗原发疾病。

辨证分型治疗

(1) 胃气不和，湿浊上泛型：注射庆大霉素后，出现头晕，纳呆，恶心，呕吐，舌淡红，苔腻，脉弦数。治宜和胃，降逆，祛湿。

方药：姜半夏12克，陈皮6克，土茯苓30克，生大黄10克，丹参30克。水煎服。另用川芎嗪肌肉注射或静脉滴注。

(2) 肾气不化，肾络痹阻型：注射庆大霉素后，出现头昏，纳呆，恶心，呕吐、腰酸，耳鸣，眼睑浮肿，面色萎黄，肾区叩痛或触痛。舌质淡或有淤斑，苔黄或腻，脉弦或滑。治宜益肾行淤，兼和胃气。

方药：仙灵脾30克，附片10克（先熬），生大黄10克（后下），姜半夏10克，丹参30克，陈皮6克，土茯苓30克。水煎服另用川芎嗪肌肉注射或静脉滴注。

42. 镇痛药肾病

镇痛药肾病系指长期服用镇痛药后引起肾功能受损的病变。

在人的一生中，免不了会有疼痛（如头痛、牙痛、胃痛、神经痛、月经痛等等），服用镇痛药也是常事。然而，镇痛药也和其他药物一样，应用不当会造成不良后果。镇痛

药诱发胃溃疡、胃出血、血小板减少性紫癜和支气管哮喘，已为人们所熟知，另一种不良后果就是镇痛药肾病。

长期服用镇痛药为什么会发生镇痛药肾病呢？这是因为，肾脏由肾小球和肾小管组成，它在体内的作用好比是自来水厂处理水的过滤装置，肾小球是过滤器，肾小管是排水管道。不同的是肾小球的过滤作用有一定选择性。由血液运送到肾脏的各种物质，要通过肾脏处理后排出体外，镇痛药也不例外。如果长期、大量服用镇痛药，甚至滥用镇痛药，就会造成肾脏负担过重而出现肾脏损害。

产生镇痛药肾病的原因有三：

（1）高浓度的镇痛药，对能产生生物能——ATP（三磷酸腺苷）的细胞氧化磷酸酶有抑制作用，ATP供应不足，细胞可因缺乏能量而死亡。

（2）镇痛药对能保证肾脏得到足够营养供应的前列腺素E的合成有抑制作用，因而使组织细胞营养供应发生障碍。

（3）随着镇痛药在肾小管和肾间质中的浓度越来越高，药物的溶解度大大下降，随之结晶析出并产生沉淀，使血管阻塞，尿液流通受阻。

服用镇痛药（如阿司匹林、保泰松等）如能多饮水，发生镇痛药肾病的可能性就小。

镇痛药肾病的症状：

头昏目眩，疲乏无力，口干舌燥，小便量多，伴尿频、尿急、尿痛、发热。尿常规检查可见蛋白质、红细胞、白细胞、管型。

镇痛药肾病的症状相当于祖国医学肾阴虚和下焦湿热的症候，治宜滋肾养阴和清利湿热。

方药：山药30克，山萸15克，熟地20克，丹皮12克，茯苓15克，泽泻30克，知母12克，黄柏12克，车前草30克，益母草30克，茅根30克。水煎服。

43. 慢性地方性氟中毒

慢性地方性氟中毒，是由于长期饮用高氟水引起的慢性氟中毒。由于氟沉积于骨与牙齿组织中，使钙磷代谢紊乱，影响骨骼生长，以致门牙和大牙成棕黄色或褐色，牙齿排列不整齐，表面粗糙无光泽。腰背和四肢关节酸痛、麻木、活动受限。肢体活动时疼痛缓解，休息睡眠后症状加重。晚期可出现脊柱畸形后突，体位固定，强迫步态，甚至肢体瘫痪。本病可通过尿氟检查、X线检查等确诊。

慢性地方性氟中毒属于祖国医学的“骨痹”、“筋痹”、“肌痹”的范畴。其发病与地域及饮水有关。禀赋不足，劳倦过多，以致脏腑气血虚损。居处潮湿，气候乖戾，致风、寒、湿三气乘虚而入，伤及筋骨。

辨证分型治疗

(1) 寒湿型：骨关节疼痛，肌肉沉重麻木，腰腿屈伸不利，遇寒加重，纳差，腹痛，腹泻，苔白或腻，脉弦缓。治宜祛风胜湿，散寒止痛。

方药：制川乌15克（先熬），桂枝15克，秦艽15克，防己15克，滑石30克，补骨脂12克，淮牛膝30克，苡仁30克，仙灵脾30克，杜仲12克，肉苁蓉12克。水煎服。

(2) 阴虚型：骨关节热痛，屈伸不利，肌肉抽搐灼热，烦躁，头晕，口苦口干，手足心热，失眠多梦，舌红苔

少，脉细数。治宜滋阴清热，止痛除痹。

方药：龟版30克，鳖甲30克，知母12克，黄柏12克，生地60克，当归30克，白芍30克，川牛膝30克，淮牛膝30克，阿胶12克，玄胡10克。水煎服。

（3）阳虚型：骨关节疼痛、僵硬，肌肉抽搐麻木，遇冷或劳累后症状加重，关节畸形，怕冷，食少，舌淡苔白，脉沉细。治宜温肾壮骨，活血止痛。

方药：制附片20克（先熬），肉桂6克，山药30克，熟地15克，干姜10克，杜仲12克，补骨脂12克，党参30克，骨碎补10克，当归30克，鹿含草30克。水煎服。

验方治疗

（1）熟地60克，鸡血藤60克，肉苁蓉40克，仙灵脾40克，甘草10克。加水浓煎成膏。狗脊40克，骨碎补40克，鹿含草40克，共研细末，与上膏调匀，制成药片，每片0.25克，每次服8片，每日3次，连服3个月。

（2）苁蓉、熟地、海桐皮、川芎、鹿含草、鸡血藤、骨碎补各等量，研末为丸，每丸重10克，每次服1丸，每日服3次，连服3个月。

44. 安定中毒

安定为临床常用药物，具有安定及松弛横纹肌等作用，若用药过量时可引起中毒。中毒症状有头晕，记忆力减退，醉汉样表情，嗜睡，恶心呕吐，共济失调，知觉减退乃至消失，严重者呼吸困难，紫绀，脉搏加速，血压下降，尿少，腱反射消失，昏迷，抽搐，瞳孔扩大，对光反应消失，最终

出现呼吸衰竭和循环衰竭。

一般认为服安定40片即可引起中毒。

安定中毒确诊后应立即用(温)2.5%甘草浸液洗胃,一般用甘草浸液5000毫升洗胃后患者即感头昏减轻,用至10000毫升时,患者胃部不适,恶心呕吐亦好转。服安定量100片以内引起中毒者,用甘草浸液10000毫升洗胃后,即可嘱患者卧床休息,保温3—4小时(观察)。服安定100片以上引起中毒者,须继续用甘草浸液洗胃,甘草浸液用量须达15000毫升,若服安定150片以上引起中毒者,甘草浸液洗胃应增加至20000—25000毫升后才可停止洗胃。

用2.5%甘草浸液洗胃抢救安定中毒,方法简便、有效。城乡医疗单位均可使用,药源广,价廉。

甘草中所含的甘草甜素和甘草酸的钙盐有较强的解毒作用,其机理可能是通过其吸附作用和类肾上腺皮质激素作用,加强肝脏的解毒机能。甘草甜素的水解产物葡萄糖醛酸,也是解毒的有效成份。

甘草解毒,用量宜大,只有超过正常用量数倍以上,才有可能发挥其解毒作用。

45. 阿托品过量反应

夏秋季节,农村有机磷农药中毒发病率较高。阿托品是首选解毒药物。但阿托品过量反应并不罕见。其症状有:面红、口干,吞咽困难,声音嘶哑,皮肤干燥,头痛,心动过速,心悸,发热,瞳孔扩大,视物模糊,便秘,排尿困难。严重者谵妄,狂躁,眩晕,幻觉,摸空动作和共济失调。中毒

症状可持续数小时至数天。有的甚至昏迷，血压下降，最终出现呼吸衰竭而死亡。

阿托品剂量超过 5—10 毫克，则可发生中毒症状。最低致死量为 50—130 毫克。

发生阿托品过量反应时，除停用阿托品和输液等治疗措施外，服用中药有较好效果。

方药：生大黄 15—25 克，芒硝 15—25 克，桂枝 10 克，当归 10 克，甘草 15—30 克。

用法：先煎当归、桂枝、甘草 10—15 分钟，再下大黄 2—5 分钟，再下芒硝 1—2 分钟，取汁 500—1000 毫升待温，分次口服或鼻饲，亦可同时用中药煎剂灌肠。待患者大小便通畅、神志清醒后，中药减量再服。每日一剂，维持两日。

方中加入桃仁 10 克，效果更佳。

46. 迟发性运动障碍

迟发性运动障碍是由于长期服用抗精神病药物（如氟哌啶醇、氟奋乃静、奋乃静、氯丙嗪、三氟拉嗪等）引起的持续性运动障碍。本症的特点为不自主的，有节律的、刻板式运动，睡眠时消失，情绪紧张激动时加重。常表现为吸吮、鼓腮、舐舌、转舌、咀嚼等口-舌-颊三联症及肢体不自主、无目的的摆动，肌张力降低，全身躯干运动不协调等，并常出现舌红苔黄、脉弦数等热象。

本症的病机之一乃药物性毒邪，蕴结日久，化热成毒，积聚于胃，耗伤胃阴，致脾运化失职，热邪炎上，津不上荣，故出现口-舌-颊三联症。身体四肢不自主地、有节律地

摆动震颤是由于毒邪久蕴体内，损及肝血，血亏而筋脉失养所致。

辨证分型治疗

(1) 阳明热盛，阴液不足：唇舌不自主地，有节律地运动，如吸吮、鼓腮、舐舌、转舌、伸舌、咀嚼、歪颈，甚则言语不清，进食困难，伴咽干唇燥，渴喜冷饮，烦躁不宁，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数有力。治宜滋阴清热。

方药：生石膏60—90克，生地30克，花粉30克，石斛30克，麦冬30克，瓜蒌30克，黄连15克，酒制大黄15克。水煎服。

(2) 肝阴不足，筋脉失养：四肢不自主地有节律地刻板式运动，上肢呈捻球样动作，下肢表现为不自主地踱步，抬起放下，伴伸舌，咬牙，面色无华，头晕目眩，多梦耳鸣，双目干涩，视物不清，月经量少或闭经，舌红少苔，脉弦细。治宜滋养肝肾。

方药：生地30克，熟地30克，女贞子30克，鸡血藤40克，白芍30克，当归20克，淮牛膝15克。水煎服。

(3) 心脾两虚，中气不足：不自主地舐舌、吸吮，甚则吞咽困难，或四肢偶而多动，伴喜卧少动，倦怠懒言，心悸健忘，少寐多梦，纳差，腹胀，乏力，消瘦，面色萎黄，舌质淡嫩，苔薄白有津，脉沉细弱。治宜养心安神，健脾益气。

方药：党参30克，白术15克，茯苓20克，生地20克，麦冬20克，夜交藤30克，焦三仙各10克。水煎服。

(4) 肝郁气滞，淤血内阻：四肢不自主地多动，咀嚼，转舌，伴情绪低落，烦躁易怒，两胁胀痛，月经不调，舌紫暗有淤斑，脉沉弦涩。治宜疏肝理气，活血化淤。

方药：柴胡20克，陈皮12克，木香10克，香附15克，桃仁10克，

红花10克，赤芍30克，川牛膝15克，鸡血藤30克，当归20克。水煎服。

47. 酒（乙醇、酒精）中毒

急性酒中毒，俗称酒醉，通常由于过量饮酒（或过量饮用酒类饮料）所引起。饮入的酒迅速由胃肠吸收，1—2小时血中乙醇浓度可达高峰。空腹饮酒吸收更快。脂肪类食物可降低乙醇的吸收。乙醇吸收后由血液均匀地渗入内脏和组织内，约90%的乙醇在组织内氧化形成二氧化碳和水，其余经呼吸、肾脏、汗腺和唾液等排泄。乙醇在体内的代谢甚慢，一般成人每小时代谢10毫升，肝功能不全者代谢更慢。

饮料含醇量愈高，吸收愈快。常见酒类饮料中的乙醇含量大致如下：啤酒3—5%，黄酒16—20%，果酒16—48%（葡萄酒18—23%），白酒40—65%（高粱曲酒40—60%，威士忌47—53%）。

乙醇吸收后，主要抑制大脑皮层功能，引起一系列精神及神经症状，对延髓呼吸中枢亦有抑制作用。中毒症状视饮酒量及各人对酒的耐受量而定，一般乙醇饮量达75—80克时即可出现中毒症状，致死量为250—500克。

如有以下情况，易致重度中毒，而且预后不良。①有心、肺、肝、肾疾病者；②昏迷超过10小时者；③血中乙醇浓度超过400毫克%者；④乙醇与巴比妥酸盐类或与吗啡同时用时，即使血中乙醇浓度较低，亦易引起呼吸中枢衰竭，造成严重后果（死亡）。

酒精中毒的表现可分为三期，各期界限不甚明确，由这

一期转为下一期的快慢，也因人而异。

(1) 兴奋期：大多面色发红，自觉身心愉快，言语增多，毫无顾虑，甚至粗鲁无礼，易感情用事，或悲或喜，有时则静寂入睡，呼吸有酒味。

(2) 共济失调期：动作逐渐笨拙，不协调，无法维持身体平衡，步履蹒跚，口齿不清，语无伦次，甚者精神错乱。

(3) 昏睡期：渐入昏睡状态，颜面苍白，皮肤湿冷，体温低于正常，口唇微紫，瞳孔散大或正常，呼吸缓慢而有鼾声，脉搏快速，可因呼吸衰竭而死亡。昏迷时间超过 10 小时，即有死亡的危险。

慢性酒中毒（慢性乙醇中毒）在我国较罕见。从开始饮酒至出现临床症状约经 10 年左右时间。其症状的轻重与酒的种类、始饮年龄、饮酒量与频度、饮酒时是否佐以食物以及与神经系统机能状况等有关。

慢性酒中毒可伴发维生素缺乏，并引起心肌、肝脏、内分泌腺和其他器官的营养不良，机体代谢紊乱，尤以脑的损害更为严重。从而引起神经精神改变。

长期饮酒，病人逐渐出现智能衰退，注意力涣散，记忆力和判断力下降，有时出现幻觉，手、舌和全身震颤。由于乙醇对分泌腺的影响，病人性欲下降，舌苔厚、口臭，晨起常有恶心、嗝气等慢性胃炎症状。部分病人可有肝硬化、营养缺乏、周围神经炎、面部毛细血管扩张和精神失常。

酒中毒属于祖国医学的“酒毒”、“酒风”、“酒悖”等范畴。祖国医学对“酒毒”的认识和治疗有着悠久的历史和丰富的经验。早在二千多年前的《内经》中就有“酒风”、“酒毒”的记载，明代李时珍在《本草纲目》中明列“酒

毒”病名，并认为“过饮不节，杀人倾刻”。

急救治疗

(1) 甜瓜蒂10克，研末，开水吞服，促吐。

(2) 生大黄15克，栀子15克，急煎口服，促泻下。

上面介绍的吐、泻两法有类似洗胃和洗肠的作用，使酒毒及早排泄，调整脏腑功能。

(3) 醒脑静肌肉注射。

(4) 安宫牛黄丸1粒用鲜竹沥磨化灌服（或灌肠）。

以上3、4两法的作用为清心醒脑。心清神灵，可早回生，而多蒙蔽一日（即昏迷时间长），则预后多一分凶险。

(5) 针刺人中、内关、神门、风池、涌泉等穴。针刺亦能起到清心开窍的作用。

单方验方治疗

(1) 鲜竹沥30毫升，冷开水兑服（频频灌服）。

(2) 葛根30克，葛花15克。水煎服。

(3) 藕节30克。水煎服（适用于酒醉伴鼻衄者）。

(4) 绿豆30克，荸荠30克。水煎服。

48. 一氧化碳中毒

一氧化碳中毒即俗称的煤气中毒。

一氧化碳是无色、无臭、无刺激性的气体，系由碳化合物燃烧不全所产生。产生一氧化碳的环境有：①冶炼、铸造及煤气制造等车间。②丙酮、甲酸、甲醛、氨的合成，在生产碳酸氢钠时可产生大量一氧化碳废气。③石灰、砖瓦、陶瓷、玻璃、水泥等窑炉。④矿井爆炸后。⑤汽车排出的废气

(约含一氧化碳7%左右)。⑥煤气灶漏气。⑦冬季在室内烧煤炭而通风不良。这是引起煤气中毒最常见的原因。

空气中含0.02%一氧化碳，吸入2—3小时即可出现症状，含0.08%时吸入只要2小时即可昏迷。

吸入一氧化碳后，在体内与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白，造成缺氧血症。如一氧化碳浓度较高时，可与细胞色素氧化酶的铁结合，而抑制组织的呼吸过程。中枢神经系统对缺氧最敏感，首先引起血管壁细胞变性与血管运动神经麻痹，致使血管先痉挛，后又舒张，渗透性增加，严重者出现脑水肿。

急性一氧化碳中毒的症状：

(1)轻度中毒：头晕，头部胀痛，颈部搏动感，耳鸣，恶心，呕吐，乏力，心悸等，经吸入新鲜空气后，症状迅速消失。

(2)中度中毒：病员虽已神志不清，但经抢救后，仍很快苏醒，常于数天内逐渐恢复。

(3)重度中毒：昏迷时间较长，虽经抢救但意识不能很快恢复。患者颜面呈樱桃红色，有明显脑水肿征，呼吸浅快，有时呈潮式呼吸。体温升高，血压逐渐下降。并发症有心肌损害、肺水肿、肺炎等。常有严重后遗症，如癫痫、肢体瘫痪、震颤麻痹、周围神经炎、皮肤营养障碍、内耳性眩晕、发作性头痛、记忆力减退、定向力丧失、性格改变、痴呆等。后遗症有时于神志恢复后半个月至1个月时才出现。血液中可查出碳氧血红蛋白。

慢性一氧化碳中毒的症状：

乏力，消化不良，全身不适，头痛，头昏，胸闷，神经痛，感觉异常，视野缩小，色觉障碍及神经衰弱等症状。

中医治疗急性一氧化碳中毒，迅速将门窗打开，通风换气。首先采用针刺疗法，其次配合按摩疗法以及“醒脑静”或“清开灵”静脉注射，刮痧疗法等。

(1) 针刺人中、合谷，强刺激，不断捻转。

(2) 按摩疗法：捏承浆、中冲、内关、外关，按太阳，推印堂。

(3) 静脉注射“醒脑静”或“清开灵”注射液。

(4) 刮痧疗法：刮扯颈项两下侧及喉结处（此为民间刮痧疗法的一种，扯痧、刮痧均可），扯痧处皮肤呈紫红色，痧眼起颗粒。

科学实验及临床报道均证明，针刺能治人事不省、昏迷、休克，针刺尚可促使一氧化碳中毒时碳氧血红蛋白的离解。文献报道，针刺家兔人中、合谷、足三里等穴发现针刺后可使（意识丧失的家兔）麻醉苏醒时间缩短。人中穴为督脉之要穴，“督”为总督，调剂周身六条阳经，故称为“阳经之海”。针刺人中另加配穴，能起到矫正机体阴阳之偏盛，恢复各部分功能的平衡。加上按摩疗法的不断刺激，激发了俞穴和经络的功能，使机体的营卫、气血全部调动起来，提高人体抗病能力。

配合扯痧疗法，扯破表浅微血管，起到通络调气的作用，从而促使机体的调节活动能力得以恢复而疾病痊愈。

“清开灵”、“醒脑静”注射液均具有醒脑开窍的作用。

49. 铅 中 毒

铅及其化合物都有毒性。除金属铅外，在工业生产中接

触较多的铅化合物，如有一氧化铅、四氧化三铅、二氧化铅、碱式碳酸铅、硝酸铅、硫化铅、硫酸铅、硅酸铅、铬酸铅、砷酸铅、乙酸铅等。铅矿的开采和冶炼工业、蓄电池业、印刷业中的铅中毒发病率较高。

急性铅中毒较少见，一般由于误服醋酸铅、铅白等化合物引起。急性铅中毒表现为口内有金属味，口腔粘膜变白，流涎，恶心，呕吐，上腹部阵发性疼痛，便秘或腹泻，有黑便。

慢性铅中毒，铅主要以蒸气、烟尘及粉末三种形式经呼吸道进入人体，完整的皮肤不吸收铅。铅对人体各组织均有毒性作用，其中以神经系统、造血系统和血管方面的病变尤为显著。

慢性铅中毒的临床表现视病情轻重而异。

(1) 铅吸收：系指体内铅含量增加，主要表现为尿铅含量增加，此时尚无铅中毒的临床表现。

(2) 轻度铅中毒：出现肢体酸痛，口内有金属味，腹胀，腹部隐痛，头晕、头痛，睡眠障碍。若症状不明显，但尿铅含量增高，尿中粪卟啉阳性，点彩红细胞增加，硷粒红细胞增加，亦可诊断为轻度铅中毒。

(3) 中度铅中毒：除上述表现外，尚有：①腹绞痛：典型者为阵发性、剧烈的脐周腹痛(用手按压，痛可减轻)，伴有出汗，呕吐，不发热。②贫血：病员面色呈灰色(铅容)，伴有心悸、气促、乏力等症状。少数病员可有轻度肝肿大，蛋白尿，血压不稳定，月经失调等。

(4) 重度铅中毒：除上述表现外，还有：①铅中毒性麻痹(桡神经麻痹为常见)，腕下垂(少数病员为足下垂)。②铅中毒性脑病：智力障碍，精神异常或脑神经受损，有时

出现癫痫样发作。

驱铅试验对诊断有帮助。

中医认为铅中毒的病因病机是外邪（铅毒）进入人体，主要分布于肝、肾二脏，最终积存于骨内。铅毒伤络劫阴，内伤肝肾。肝肾虚损则化生精血的机能减退或发生障碍，血不养肝，而出现肝阴虚的症状，肝阴不足又影响肾阴，肝肾亏损，故出现铅面容和贫血体征。肝主情志，故出现情绪改变的症状。肝与脾胃消化有关，故出现消化系统症状。肝主筋，故出现运动系统症状。肝为“罢极之本”（使人耐受疲劳），故出现疲乏无力、伸肌无力等症状。肝与疼痛有关，故出现腹绞痛等症状。肝主谋虑（与神经系统的功能活动有关），故出现神经系统的症状。

铅中毒属于祖国医学的“阳明腑证”范畴（腹痛，呕吐，便秘，口内有金属味）。治宜通腑泻热，清热解毒，利水渗湿。

方一：生大黄10克，芒硝10克（冲），枳壳10克，黄连10克，栀子10克，木通10克，竹叶10克，茯苓30克，益元散30克。水煎服。

加減：呕吐加竹茹、生姜；腹痛加玄胡；心悸失眠加琥珀。

方二：甘草105克，金钱草241克，菊花90克。加水1400毫升煎成700毫升，每次服50毫升，每日服2次，7天为一疗程。停药2天，再进行第二疗程。

一般服药2个疗程后，尿铅、尿紫质转为阴性，临床症状改善。

方三：绿豆120克，土茯苓60克，茯苓30克，金钱草30克，茵陈15克，郁金15克，甘草15克。水煎服。

50. 蜈蚣螫伤

蜈蚣螫伤在农村比较常见。蜈蚣第一对步足又称毒肢，呈钩状，钩端有毒腺口，螫人时分泌毒液注入人体。毒液中主要含有组胺样物质、溶血性蛋白及蚁酸等。

螫伤处有一对小口，局部有淤点，周围红肿，剧痛，淋巴管炎和坏死。中毒严重者有全身症状，如头痛、眩晕、呕吐、发热、谵语、全身麻木、抽搐甚至昏迷。

蜈蚣螫伤偶可引起类似蜂毒所致的过敏反应，甚至过敏性休克。

中药治疗蜈蚣螫伤宜内治外治法并用。可先用肥皂水洗伤口，忌用碘酊。

方一：病重者内服南通蛇药片，每次5片，每日3次。

方二：五灵脂15克，白芷15克，威灵仙15克，吴茱萸15克，防己15克，细辛3克，浙贝10克，半边莲25克（鲜品100克）。加水500毫升，冲入白酒50毫升，煎沸10分钟，待稍凉后，先服一半，4小时后再服余下的一半。药后宜安静休息，忌食辣椒、糯米、生冷瓜果。

方三：新鲜红薯藤的嫩尖7—10条。清水洗净，然后捣烂如泥状，敷于咬伤处，外盖纱布，用绷带或胶布固定。

方四：鲜苎麻叶适量。洗净捣烂取汁，不时地搽抹患部，肿到什么部位，搽到什么部位。如果伤势严重，肿痛特别厉害，再将捣乱的苎麻叶包扎在伤口处，至肿痛消失为止。

方五：伤口周围外搽南通蛇药。

方六：伤口周围用鱼腥草、鲜蒲公英3—60克，捣烂外敷。

方七：甘草、雄黄各等份，研末，用植物油调敷患处。

51. 蝎 螫 伤

蝎子分布在温暖而特别干燥的地区。蝎尾端有刺，与毒液腺相通。用尾刺螫人时，毒液注入人体。蝎毒素作用于神经和心脏，一般不会引起生命危险。幼儿被蝎螫伤则可能致命。

被小蝎螫伤仅引起局部灼痛与红肿。被大蝎螫伤后除局部灼痛、红肿外，尚可出现水泡、麻木感或出血，并可引起全身症状，如流涎、流泪、大汗、头痛、感觉过敏、恶心、呕吐、体温下降或发热、昏睡、舌和面部肌肉强直、不能张口说话、畏光、气喘。重者可有抽搐、血压升高、心动过缓、胃肠道出血、肺出血、肺水肿、尿少、呼吸中枢麻痹等。

治疗应立即拔出毒针，在刺伤的附近结扎止血带、冷敷，减慢毒液吸收。必要时切开伤口，用石灰水冲洗，然后用口吮出毒液，或用火罐吸出毒液。

内治法

方一：银花30克，半边莲30克，甘草10克，土茯苓30克，绿豆30克。水煎服。

方二：五灵脂10克，生蒲黄10克。共研细末，用淡醋冲服，每次服6克。

外治法

(1) 南通蛇药片6片，用冷开水溶化成糊状，在伤口

周围敷贴（勿直接涂在伤口上）。

（2）明矾粉 0.6克，研细末，米醋调敷。

（3）雄黄、枯矾各等分，共研细末，用茶水调敷。

（4）蜗牛一个，洗净带壳捣烂，外敷。

（5）大青叶、薄荷叶、鲜马齿苋各适量，捣烂外敷。

52. 蜂类螫伤

蜂类螫伤在山区农村并不罕见。蜂尾有毒刺，螫人时注入毒液。蜂毒液中含蚁酸、神经性毒素和组织胺样物质。黄蜂螫人较蜜蜂螫人病情更为严重。

受蜂螫伤，多数人仅有局部红肿和刺痛，数小时后可自行消散。如被蜂群螫伤多处者，可有头晕，恶心，发热，烦躁不安，全身震颤甚至痉挛。若螫伤眼结膜则症状严重。

蜂毒过敏与中毒不同，过敏可表现为荨麻疹、鼻塞、恶心、呕吐、气喘、口唇及眼睑水肿；严重者可因喉头水肿或过敏性休克而危及生命。

治疗时应首先拔出蜂刺。采用外治法为主。

（1）伤口周围用南通蛇药片涂敷。

（2）七叶一枝花、紫花地丁、半边莲捣烂外敷患处。

（3）若系蜜蜂螫伤，局部敷以肥皂水。黄蜂螫伤则用食醋涂敷。

53. 蛭类（蚂蝗）螫伤

蛭类（蚂蝗）螫伤在农村很常见。蛭类多在水中生活，

也有生于陆上或水陆两栖。蛭类有前后两个吸盘，口在前吸盘内，吸血时先用腭片锯成三角形伤口，同时从涎腺分泌水蛭素，水蛭素有抗凝血作用。

蛭类螫伤的伤口多在肢体部位，局部不痛，流血不易止。偶有喝带蛭的生水，以致蛭附着于食道或呼吸道，引起吐血、咯血、咳嗽、气急等。

发现蛭（蚂蝗）在皮肤上吸血时，切忌用力牵拉蛭体，以免其腭片或吸盘部分留在创口，引起不易愈合的溃疡。可用浓盐水、浓醋滴在蛭体上使其脱落，或用盐撒在蚂蝗上也能使其脱落。然后用银花水冲洗伤口，撒生大黄粉止血。

54. 毒蜘蛛螫伤

毒蜘蛛螫伤在农村时有所见。一般蜘蛛螫伤只引起局部疼痛、发炎或坏死。“黑寡妇”蜘蛛（红斑蛛）的毒液含一种神经性毒蛋白，螫伤处呈苍白、发红或有荨麻疹，局部疼痛或压痛。全身症状有软弱、头昏、恶心、呕吐、出汗、腹肌痉挛、发热、双足麻木以及特征性的足跟部烧灼感。病情严重者，血压先升后降，呈休克状态，并有呼吸窘迫，谵妄。小儿病情较重，多有惊厥。

内治法

南通蛇药片，每次服5片，每天3次，开水吞服。

外治法

伤口近心端结扎，每15分钟放松1分钟，伤口消毒后，切开，抽取毒汁，用南通蛇药片溶化成水冲洗，并作中西医结合处理。然后放松止血带。伤口周围外敷南通蛇药。

妇 产 科

55. 梅 毒 性 流 产

病毒性流产是因梅毒而导致流产。梅毒是由梅毒螺旋体引起的一种慢性全身性传染病。主要通过性交传染。

梅毒分为先天梅毒（胎传梅毒）和后天梅毒（获得性梅毒）两大类。

梅毒是慢性传染病。全部病程是活动与潜伏相交替，各个时期的临床表现与时间长短，也随着机体抵抗力的不同而有差异。在临床上，根据其传染时间、临床特点与传染性的不同，分为一、二、三期，或分为早期（感染在四年以内者）和晚期（感染在四年以上者）。由于患者的身体免疫力和治疗情况各有不同，在临床上也不一定都出现典型症状，甚至不出现临床症状。

一期梅毒

（1）潜伏期平均约 3—4 周。

（2）主要损害为局部出现硬下疳，好发于生殖器局部，冠状沟、阴茎头、大小阴唇、子宫颈等为常见部位，亦可见于肛门、腹股沟、阴阜或口唇、眼睑、乳房、舌、手指等处。初发为粟粒大小，具有浸润性丘疹或硬结（初期硬

结)，硬结迅速破坏，形成溃疡（硬下疳）。典型的硬下疳具有以下特点：①大多单发，质坚硬，不感疼痛。②多呈圆形或椭圆形，边缘整齐，境界明显，周围呈堤状隆起，绕以暗红色浸润。③基底平坦，无脓液，覆有灰白色浆液纤维性薄膜，不易除去。④皮损中含有大量梅毒螺旋体。取刺激液用暗视野显微镜可以查见。⑤硬下疳如不治疗，经过3—4周后，一般可以自愈。如经抗梅毒治疗（注射青霉素G），则迅速愈合，可遗留浅在性瘢痕。

（3）下疳出现一周后，附近淋巴结可肿胀，但不痛，不与组织粘连，表皮无炎症，不破溃，抗梅毒治疗后可迅速消退。

（4）硬下疳出现2—3周后，梅毒血清试验开始呈阳性。

（5）一期梅毒如能早期确诊，合理治疗，可彻底治愈，预后良好。

二期梅毒

为梅毒泛发期，梅毒螺旋体通过血行播散，除引起皮肤损害外，并可引起内脏多系统损害，但以皮肤损害为主。二期梅毒传染性大，如能及时给以合理治疗，亦可获得彻底治愈。二期梅毒一般在感染后9—12周发生。自硬下疳消失至二期梅毒疹发生前的时期，称为第二潜伏期。

（1）前驱症状：皮肤损害发生前有轻重不等的全身症状，如发热、头痛、神经痛、咽峡炎等，皮疹出现后即行消失。

（2）皮肤损害的一般特征：二期梅毒皮肤损害虽然类型复杂，但大抵具有以下特征：①间歇性发疹（梅毒疹）：每一疹群出现后，有一间歇期，然后出现另一批皮疹，新旧

皮疹常同时并见，分布广泛，遍及全身。皮疹一般持续数周或2—3月，不经治疗亦可消退。②皮损多呈圆形或椭圆形，境界明显，初呈鲜红色，不久变成暗红或铜红色，压之不退色。③愈后不留瘢痕。④皮损中含有大量梅毒螺旋体，传染性极大。⑤轻微瘙痒。⑥发疹期间梅毒血清试验呈强阳性，全身淋巴结肿大。

（3）皮损类型：可分为斑疹、丘疹、脓疱疹。

（4）粘膜损害：主要为粘膜白斑，可见于口腔或生殖器粘膜。为灰白色或乳白色，约为指盖大小微形隆起的斑片，周围有暗红色浸润，表面有大量梅毒螺旋体。

（5）可发生梅毒性脱发、颈部白斑，指甲损害、骨膜炎、眼部损害、中枢神经系统损害（如脑膜炎）等。

以上一、二期梅毒又合称为“早期梅毒”。

三期梅毒（晚期梅毒）

早期梅毒治疗不及时或不彻底，或身体衰弱，或嗜烟酒，均可演变成晚期梅毒。

三期梅毒过程较慢，持续较久，常可达10—30年。血清反应不稳定（查血时阴性率达30%以上）。除皮肤粘膜损害外，内脏、骨骼、神经系统等均可受侵犯。三期梅毒传染性弱，但对机体组织的破坏力强，可造成严重的器官破坏，毁形严重，常见鞍鼻（鼻陷）、硬腭穿孔等，有的甚至形成残废。重要脏器受到侵犯时，可危及生命。

梅毒性流产由于梅毒而造成流产，夫妇双方梅毒血清试验均呈阳性，诊断不难。

梅毒属于祖国医学的“疳疮”、“杨梅疮”等范畴。我国十六世纪以前还没有梅毒。如李时珍在《本草纲目》中写道：“杨梅疮古方不载，亦无病者，近时起于岭表，传及四

方”。按十六世纪初欧亚交通发展情况查考，梅毒似乎是在公元1500年后传入我国，先传至广东，然后自南而北广泛传播全国。明代《霉疮秘录》一书中对梅毒作了较详尽的记载：“一感其毒，酷烈非常，入髓沦肌，流经走络，……或攻脏腑，或巡孔窍，……眉发脱落……。”如不及早治疗，可致“形损骨枯，口鼻俱废，甚则传染妻孥，丧身绝育，移患于子女……”。梅毒性流产，中医认为系毒邪伏于胞宫，精血逆乱，失去摄纳、濡养胎儿之功能。治宜清热利湿解毒。

方药：土茯苓30克，银花30克，生甘草15克。水煎服。夫妇双方须同时服药。每日1剂，连服半年。经梅毒血清试验呈阴性后，再次怀孕，可免流产。

56. 梅毒性不孕

梅毒性不孕是由于患有梅毒而导致不孕。患者妇科检查往往正常，男方精液检查，精子数量、活动度均正常。但夫妇双方梅毒血清试验均呈阳性。

梅毒的症状及诊断详见上文《梅毒性流产》。中医认为梅毒性不孕属肾阴不足，湿热毒邪内阻胞宫所致之不孕症。治宜清热除毒，益肾调经。

方药：土茯苓30克，银花30克，巴戟天15克，益母草15克，生甘草15克。水煎服。每日一剂。患者的丈夫亦应每日用土茯苓50克，银花30克，加水煎服。双方均应连续治疗半年，梅毒血清试验复查为阴性，始能受孕。

57. 胎 盘 滞 留

在正常情况下，当胎儿娩出后，子宫肌的有力收缩，能使整个子宫腔迅速缩小，并在腹部压力稍有增加的协同动作下，胎盘能顺利娩出。若子宫肌收缩无力，或其他因素使胎盘不能顺利娩出，称为胎盘滞留。

胎盘滞留常大量流血，流血多者可出现休克症状。如处理迟缓或处理不当，可直接危及产妇的生命。

对胎盘滞留，一般医院多采取注射子宫收缩剂或手术剥离胎盘法。在没有上述条件的情况下，用中药治疗还是必要的。

胎盘滞留属于祖国医学“胞衣不下”、“息胞”等范畴。中医认为导致胞衣不下的因素有：①气虚：妇人素体虚弱，元气不足，或产程过长，用力过度，疲惫不堪，以致子宫收缩不良，因而胞衣不能顺利排出。②血淤：淤血阻滞胞脉，影响胞宫功能，以致胞衣不能顺利排出。

辨证分型治疗

（1）气虚型：胞衣不下，阴道流血，血色淡，心悸，气短懒言，面色晄白，舌淡苔白，脉细弱无力。治宜补气养血。

方药：黄芪60克，当归30克，党参30克，桃仁12克，川芎12克，益母草30克，红参10克（嚼服），炙甘草10克。水煎服。

（2）血淤型：分娩之后，胞衣不下，阴道流血，血色暗红，少腹痛而拒按。舌紫暗，脉弦涩。治宜活血化淤。

方药：炒蒲黄15克，五灵脂15克。水煎服。服时兑入童便1杯，黄酒15毫升。

针灸治疗

取穴：关元，中极，三阴交，至阴。

方法：先针后灸（针时强刺激，后行温和灸）。

58. 产后子宫收缩痛

产后子宫收缩痛多见于经产妇，特别在急产以后。一般发生在产后1—2天内。患者下腹疼痛，哺乳时特别明显。这种腹痛多由子宫收缩引起。

产后子宫收缩痛属于祖国医学的“儿枕痛”范畴。中医认为由气血运行不畅所致。

辨证分型治疗

（1）血虚型：产后下腹隐痛，腹软喜按，头晕，耳鸣，大便燥结，舌淡红，苔薄，脉虚细，治宜补血益气。

方药：黄芪30克，当归30克，党参60克，熟地20克，炙甘草10克，续断30克，山药30克，阿胶12克，制首乌15克，龙眼肉12克。水煎服。

（2）寒凝型：产后小腹冷痛拒按，得热痛减，面色青白，四肢不温，痛甚欲呕，舌淡苔白，脉沉紧。治宜温经散寒，行瘀活血。

方药：当归10克，川芎10克，木香10克，炮姜10克，吴萸10克，肉桂6克，焦山楂30克，炙甘草6克。水煎服。

单方治疗

莲蓬壳8—12只，以清水3大碗，用文火煎至一大碗左右，睡前温服。每日1次，严重者连服2次。

针灸治疗

取穴：①中极、三阴交；②关元、足三里；③中极、足三里。

操作：中极穴针8分—1寸5分深，用强刺激抑制手法，针20—30分钟，针时子宫部位有胀感。三阴交穴针4—6分深，灸20—30分钟，用强刺激抑制手法，针时酸胀麻向腿及足趾处放射。关元穴针8分—1.5寸深，灸20—30分钟。针时下腹部有酸胀感觉。以上穴位可同时取2—4个穴位，亦可单独取1个穴位。疼痛剧烈者留针时间可以延长达1—2小时以上，留针过程中如发生子宫收缩痛时，将针再行捻转加强刺激，疼痛即可停止。

儿 科

59. 风 疹

风疹是由风疹病毒引起的一种症状较轻的急性传染病，5岁以下小儿多见。症状表现为上呼吸道轻度炎症，低热，皮肤起红色斑丘疹，耳后、枕部淋巴结肿大。如果孕妇早期患风疹，风疹病毒可传给胎儿，产生严重的全身感染，引起多种畸胎，称为“先天性风疹综合征”。

临床表现

(1) 潜伏期：平均为18天。

(2) 前驱期：约半天至1天。症状多不严重，一般为低热、喷嚏、流涕、咽痛、纳呆、咳嗽等，偶尔伴有呕吐、腹泻。这些症状在出疹后1天即消失。

(3) 出疹期：通常于发热的第一、二天即出现皮疹。最早见于面颈部，迅速延至躯干和四肢，1天内可满布全身。呈浅红色斑疹、斑丘疹或丘疹。大小形态不一，茂密者可融合成片，多伴痒感。出疹期一般持续3天，故又有“三日疹”之称，也有持续4—5天者。疹退后无色素沉着，有细小的脱屑。出疹期常伴有淋巴结肿大，有压痛，但不化脓。持续5—7天自行消退。风疹可通过血清学检查而确诊。

风疹属于祖国医学的“风痧”范畴。是由风热时邪入腠理，郁于肌表，与气血相搏发于皮肤所致。一般只伤及肺卫，病位浅表，病势较轻。

辨证论治

(1) 轻症：发热恶寒，喷嚏，流涕1—2天内全身出现疹点，疹色淡红或鲜红，并有痒感。苔薄白，脉浮。治宜疏风清热。

方药：荆芥10克，防风10克，蝉蜕6克，牛蒡子10克，紫草10克，银花10克，连翘10克，赤芍10克，夏枯草10克，甘草5克。水煎服。

(2) 重症：发热较高，疹色鲜红，疹点较密，小便短黄，唇舌较红，脉浮数。治宜清热凉血。

方药：黄连10克，栀子10克，银花10克，连翘10克，丹皮10克，赤芍10克，紫花地丁10克，生地10克，茅根10克，牛蒡子10克。水煎服。

验方治疗

大黄5克，蝉蜕5克，板蓝根10克，紫草10克，银花10克，连翘10克。水煎服。

针刺治疗

取穴：大椎、曲池、合谷、血海、三阴交、太冲，强刺激不留针。

注：因小儿一般不易合作，故多采取强刺激不留针手法。

60. 水 痘

水痘是由病毒所引起的急性传染病。以较轻的全身症状和皮肤粘膜上分批出现斑疹、丘疹、水疱和痂疹为特征。本

病多见于少年儿童。

临床表现

(1) 潜伏期：约 10—24 日，一般为 13—17 天。

(2) 前驱期：成人于皮疹出现前 1—2 日可先有发热、头痛、咽痛、四肢酸痛等，或有恶心、呕吐、腹痛。少儿则多无前驱期症状表现。

(3) 发疹期：皮疹先见于躯干、头部，逐渐蔓延及面部，最后达四肢。皮疹分布以躯干为多，面部及四肢较少，呈向心性分布。皮疹开始为粉红色针头大的斑疹，数小时内变为丘疹，再经数小时变为水疱。从斑疹→丘疹→水疱→开始干痂，快则仅 6—8 小时。皮疹发展快是水痘的特征之一。水疱基部有一圈红晕，稍呈椭圆形 2—5 毫米大小，当水疱开始干痂时红晕亦消退。水痘初呈清澈水珠状，以后稍呈混浊，疱疹壁较薄易破。水痘皮损浅表，按之无坚实感，数日后从水疱中心开始干结，最后成痂，经 1—2 周脱落。无继发感染者和自然脱痂者痂脱后不留疤痕，痂刚脱落时留有浅粉色凹陷，而后成为白色。因皮疹分批出现，故在病程中可见各期皮疹同时存在。

口腔、咽部或外阴等粘膜也常见丘疹，早期为红色小丘疹，迅速变为水疱，随之破裂成小溃疡。有时眼结膜、喉部亦有同样粘膜疹。

典型水痘，患者皮疹不多，全身症状亦轻。如重症则皮疹密布全身 甚至累及内脏（如肺部等），全身症状亦重，体温高，热度长。成人患水痘常属重型。

水痘可通过病毒分离、血清学试验等确诊。

水痘属于祖国医学的“水疱”范畴。是由外感风热时邪，内有湿浊蕴郁所致。主要与肺脾两经有关。肺主卫表，

时邪由口鼻而入，口鼻为肺系通道，邪伤肺卫，故初起出现发热，恶寒，咳嗽等症。脾主肌肉，时邪病毒与内蕴湿热相搏，发于肌表，故见皮肤疱疹。若病邪日深，可见气分壮热，谵语。

辨证分型治疗

(1) 风毒夹湿：发热头痛，鼻塞流涕，咳嗽，喷嚏，疹色红润，疱浆清亮，舌苔白薄，脉浮数。治宜疏风清热，解毒除湿。

方药：银花12克，连翘12克，赤芍10克，蝉蜕6克，车前草12克，荆芥10克，葛根10克，丹皮10克。水煎服。

(2) 热毒炽盛：高热烦躁，唇红面赤，痘形大而密，痘浆浑浊，尿短赤，苔干黄，脉洪数。治宜清热解毒，生津。

方药：银花12克，生地12克，连翘12克，芦根15克，竹叶12克，生石膏30克，知母10克，板蓝根12克，蒲公英12克，葛根10克。水煎服。

验方治疗

野菊花15克，银花12克，板蓝根15克，栀子10克。水煎服。

针刺疗法

取穴大椎、曲池、血海、足三里、太冲，强刺激不留针。

61. 脊髓灰质炎

脊髓灰质炎是一种由病毒引起的急性传染病，常有发热、咽痛和肢体疼痛。多见于小儿，且部分病人可发生弛缓性麻痹，故又名小儿麻痹症。本病多散发，易流行。由于减毒活疫苗的普遍服用，本病的发病率已大大下降。

临床表现

(1) 前驱期：低热或中度发热，乏力不适，咽痛，咳

嗽，或有纳呆，恶心，呕吐，腹泻，便秘，腹痛等消化道症状。

(2) 瘫痪前期：体温降至正常后又再次上升。此时除发热、上呼吸道症状、消化道症状外，尚有头痛，全身肌肉痛，尤以颈、背、四肢肌痛为甚，伴有感觉过敏或感觉异常，婴儿不愿人抱，动之即哭。儿童坐起时因颈背强直不能屈曲，用上肢向后支撑，呈特殊体态。面颊潮红多汗，哭吵不安，偶尔萎靡、嗜睡。

(3) 瘫痪期：一般常在起病后3—4天出现肢体瘫痪，5—10天内相继出现不同部位的瘫痪，并逐渐加重。瘫痪早期可有发热和肌痛，体温下降后瘫痪就不再发展。瘫痪肌群大部分可在6—12个月内恢复，少数形成肌体萎缩、畸形等后遗症。

脑脊液检查、肌电图检查、病毒分离、血清学检查等有助于确诊。

脊髓灰质炎属于祖国医学的“痿证”、“痿痹”范畴。是由感受湿热疫疔之邪所致。湿热疫疔之邪由口鼻而入，首犯肺胃，进而湿热蕴结，缠绵不解，外着肌腠，内蒙清阳，终因湿热浸淫筋脉，筋脉弛缓阻滞气血，遂成瘫痪，若迁延日久，气血耗伤，肝肾受损，筋脉枯痿，肢体萎废而成后遗症。

辨证论治

(1) 初热期：发热，多汗，头痛，身痛，舌红苔薄，脉濡数。治宜清暑渗湿，化浊解毒。

方药：葛根10克，黄芩10克，苡仁20克，杏仁10克，白蔻6克，连翘15克，银花12克，滑石12克。水煎服。

(2) 痹痛期：发热，汗多，嗜睡或烦躁，全身肌肉疼

痛，感觉过敏，拒绝抚抱，苔腻，脉滑数。治宜清热除湿，宣痹通络。

方药：防己12克，杏仁10克，滑石12克，连翘15克，山梔10克，苡仁15克，半夏10克，独活12克，桑寄生15克。水煎服。

（3）痿躄期：痿躄部位不一，多见于四肢，表现为下肢一侧肢体筋脉弛缓，软弱无力，不能随意运动。舌质红，苔腻，脉数。治宜清热燥湿，活血通络。

方药：苍术10克，黄柏10克，川牛膝12克，鸡血藤12克，海风藤10克，川芎6克，红花6克，丹参15克。水煎服。

（4）枯萎期：痿躄较久，患部筋肉逐渐萎缩，肢体变形，丧失活动能力。治宜滋补肝肾。

方药：黄芪15克，党参15克，熟地12克，当归12克，川牛膝12克，淫羊藿12克，巴戟天10克，补骨脂10克。水煎服。

针刺治疗

（1）上肢瘫痪：取曲池、臂中、臑上、肩髃、合谷、外关等穴。

（2）腕下垂：取穴曲池、手三里、合谷、支沟、鱼际等穴。

（3）下肢瘫痪：取环跳、足三里、伏兔、风市、绝骨、昆仑、太溪、阳陵泉等穴。

（4）足外翻：取商丘、太溪、三阴交穴。

（5）足内翻：取丘墟、悬钟、足三里穴。

62. 小儿迁延性肺炎

小儿迁延性肺炎常见于体质较弱的婴幼儿，凡早期有发

热、咳嗽、哮喘，肺部听诊可闻细小湿罗音或胸部透视显示有炎症改变，病程在一个月以上，虽经治疗，仍具备上述一项症状加一项体征者，即可诊断为小儿迁延性肺炎。

小儿迁延性肺炎属于祖国医学的“温病”、“肺炎喘咳”等范畴。小儿乃稚阴稚阳之体，抗病能力低下，易虚易实，加之寒温失调，饮食不节，导致机体正气不足，卫表不固，继而邪传气分，热邪壅肺，痰热阻肺，清肃失职。多见咳嗽、哮喘缠绵难愈，或面色晄白，气虚神疲，或郁久化热，发为虚热，或引动痰湿，经久不愈。

辨证分型治疗

（1）气虚型：咳声无力，面色晄白，消瘦神疲，四肢欠温，纳差便溏，低热，舌质淡，脉弱。治宜益气止咳。

方药：白参7.5克，杏仁7.5克，乌梅5克，生姜3克，砂仁5克，罂粟壳5克，鱼腥草10克，白花蛇舌草10克。水煎服。

（2）虚热型：干咳少痰，面赤颧红，咽干口燥，自汗低热，舌红少津，脉细数。治宜清热养阴止咳。

方药：马兜铃10克，白参5克，款冬花10克，苏子7.5克，木香5克，杏仁5克，地骨皮10克，鱼腥草10克，白花蛇舌草10克。水煎服。

（3）痰湿型：咳嗽痰多，胸闷纳差，四肢倦怠，舌苔白腻，脉濡滑。治宜止咳化痰祛湿。

方药：茯苓15克，人参7.5克，法夏10克，白术10克，胆南星5克，薄荷5克，桔矾5克，甘草5克，鱼腥草10克，白花蛇舌草10克。水煎服。

以上三方均用人参，是针对患儿体质虚弱，肺炎迁延难愈的临床实际情况而采取的措施。患儿正虚邪实，气从中馁，使初伤之邪不得从表解，从而内害于肺，肺失清肃，引

动痰湿，或郁久发热，酿成本病。采用辨证分型治疗，针对性强，且易于掌握。

专方治疗

丹参素静脉滴注，每次 40—60 毫克，每日 2 次，疗程 5—9 天（每支 2 毫升含 20 毫克），总量可用至 700 毫克。

据临床报道，对某些迁延性肺炎患儿，用多种抗菌素、丙种球蛋白、输血等均未见明显效果，加用丹参素后，则疗效明显提高。

63. 小儿情感性交叉擦腿症

小儿情感性交叉擦腿症，又称儿童习惯性阴部摩擦。多数患儿是因外阴瘙痒，用手长时间搔抓，这种快感被记忆下来，此后常有意识地进行阴部摩擦来寻求这种感觉。久之而成习惯。这种情况属于病态，大都在入睡或刚醒时进行，持续数分钟，甚至为避免家长的干涉而暗自进行。女孩有时两腿交叉上下移擦，年龄较大的女孩可在突出的家具角上或骑在自行车上或骑在某种物体上活动身体进行摩擦，发作时还可出现颜面潮红、握拳、出汗、两腿挺直、唤之不采，发作时少则 1—2 分钟，多则更长。严重时患儿每天可发作 7—8 次以上。中医辨证认为系湿热下注，虚火妄动所致。小儿脏腑娇嫩，如饮食无节，伤及脾胃，脾伤则运化失职，水湿不得输布，停聚于内，郁而化热，侵犯肝肾，循经下注而致阴痒，湿热蕴久，阴伤助火，常可导致阴部摩擦症出现。治宜清热利湿泻火。

方药：龙胆草3克，苍术3—6克，黄柏6克，丹皮3克，泽泻6克。水煎服，每日一剂。

患儿平时宜常吃黄瓜、芹菜、苦瓜等新鲜蔬菜，配合服药，则清热利湿的作用更好。

针刺疗法

取穴：曲池、血海、足三里、三阴交、太冲、昆仑、坵墟，强刺激不留针。

64. 婴儿蒙被缺氧综合征

婴儿蒙被缺氧综合征，系指在冬季婴儿蒙被睡觉，衣被过暖，包扎过紧，以致引起高热惊厥、呼吸困难的一种综合征。这种病征若抢救不及时，可出现昏迷，甚至死亡。有的家长缺乏科学育儿知识，唯恐婴儿受寒，冬季，婴儿在摇篮内睡觉，外围厚棉被，内加热水袋，头上再盖小包被，这样，就造成婴儿缺氧，可出现大汗淋漓，面色萎黄，呼吸困难，神志恍惚，嗜睡，高热，口唇干裂，两眼上翻，抽搐。出现这种情况，应将婴儿急送医院作中西医结合抢救，给氧，输液等等。

婴儿蒙被缺氧综合征属于祖国医学“小儿惊风”范畴。中医虽无此病名，但关于本病的论述却早有记载，《太平圣惠方》说：“凡小儿一期（一岁）之内，……不得以棉被盖于头面，……及用新棉，令儿壮热，感即发痫。特宜慎之也”。婴儿蒙被睡觉，密不通风，氧气缺少，被内热气熏蒸，致使体内蕴热。小儿脏腑娇嫩，经脉未盛，肝常有余，热甚则引动肝风，神气怯弱，则易于内陷心营，故临床表现

高热、惊厥、昏迷互见，肝风心火交相煽动，真阴亏损，口唇干裂。治宜清热熄风。

方药：先服紫雪散（五分装）3支，每次服0.5—1支，1日3次，并服下列汤剂：生地10克，生石膏15克，知母3克，玄参6克，麦冬10克，青蒿6克（后下），银花10克，鲜竹叶10片，甘草3克。水煎服。

针刺疗法

取穴：人中、合谷、足三里、太溪、太冲，强刺激不留针，可出针后连续针刺。

65. 小儿肌性斜颈

小儿肌性斜颈是指小儿的头向患侧倾斜，颜面旋向健侧。如果家长勉强地将其拨正，则引起患儿啼哭不止，又迅速转回原位。有的婴儿早期症状不太明显，容易被忽视，到4—5个月时家长才发现上述症状。这种“歪脖子”婴儿在其单侧的胸锁乳突肌上还可摸到棱形肿物。

小儿肌性斜颈的病因，多系在分娩时一侧的胸锁乳突肌因产道挤压或产钳挤压牵拉，使局部受伤出血，血肿机化造成挛缩；或因分娩时胎儿头位不正，阻碍一侧胸锁乳突肌的供血，引起缺血性改变；或因胎儿在子宫内，头部向一侧偏斜，均可导致本病。临床上产伤引起者多见。

中药治疗

方药：威灵仙10克，伸筋草10克，王不留行6克，桂枝3克，防风3克，丹参6克，茯苓6克，炙甘草3克。用水250毫升煎至70毫升，分1—2次服完，每3天1剂。上述剂量为4

周岁量。婴幼儿剂量可酌减。

本方具有宣通散结，舒筋活络的作用，配合推拿按摩疗法可提高疗效。

推拿治疗

(1) 患儿取仰卧位，医生用拇指在患侧胸锁乳突肌施以推擦法，以促进局部血液循环。为防止擦破皮肤可先涂润滑剂（凡士林、植物油均可）。

(2) 医生用拇指按揉患侧以放松局部，再用中指、食指在患处自上而下地左右揉动，以舒筋活血、缓解痉挛。

(3) 医生用拇指、食指于患处两侧进行左右捏拿、弹拨，以消散结块，增加血液循环。

(4) 医生一手扶住患侧肩部，另一手扶住患儿头顶，使患儿头部渐渐向健侧部倾斜，逐渐拉长患侧的胸锁乳突肌（切忌用暴力），使之舒通气血，分离粘连。

(5) 医生右手托扶患儿前下颌处，另手抱住头枕部，把头略往上牵拉，然后向左右方向旋转，在旋转法施行完毕后，将头部做顺时针方向和逆时针方向摇晃。用力不宜过猛，操作要柔和，速度不宜太快。

推拿疗法治疗小儿肌性斜颈方法简单，安全有效，患儿痛苦少，家长也乐于接受。关键是要及早发现，及时治疗。家长在患儿进行推拿治疗期间，可经常在患侧胸锁乳突肌作被动牵拉的动作，在日常生活中采用与头面畸形相反方向的动作加以矫正。如患儿睡觉时，可用较硬的枕头或沙袋等物品固定该部，令其向相反方向偏斜。患儿清醒时，尽量使用各种手段逗引孩子，使头向畸形相反的方向倾斜。这些措施，都有利于小儿肌性斜颈的康复。

外科

66. 肛管直肠周围脓肿

肛管直肠周围间隙因发生急慢性化脓性感染所形成的脓肿，称为肛管直肠周围脓肿。肛门直肠周围有许多蜂窝组织，容易感染化脓。这种脓肿，多由隐窝经肛腺管、肛腺及其分支直接蔓延，或经淋巴管向外周扩散而致。肛裂、直肠炎、克隆氏病、内外痔、肛门直肠损伤等都能引起脓肿。而营养不良、贫血、糖尿病、结核、痢疾等使身体虚弱，抵抗力减低，又都是致病的诱因。

肛管直肠周围脓肿属于祖国医学“肛门痈疽”范畴。中医称为肛痈、盘肛痈、悬痈、坐马痈、跨马痈、鹳口疽等。任何年龄组的人均可发病，但以20—40岁的青壮年发病较多见。

肛门为足太阳膀胱经所主，湿热容易聚于膀胱。故此处生痈，多由湿热下注而成，或因肛裂、内痔感染毒邪而发。本病早期多为实证和热证，治宜清热解毒，凉血祛瘀，软坚散结；中期脓成邪留，治宜扶正托毒；后期毒尽体虚，治宜补养气血，健脾渗湿，滋补肝肾。

辨证论治

(1) 实证

① 肛门热毒：肛门周围局部红肿热痛，坐卧不安，受压或咳嗽时疼痛加重，溃后脓液黄浊、稠厚而带粪臭味，常伴有全身不适，恶寒发烧，口渴喜冷饮，便秘尿赤，舌质红，苔黄，脉弦数。治宜清热解毒，凉血祛瘀，软坚散结。

方药：当归30克，穿山甲片15克，皂角刺12克，银花30克，赤芍30克，乳香10克，没药10克，陈皮10克，防风10克，白芷10克，浙贝12克。水煎服。

② 湿热下注：肛门周围红肿较重，肛门坠胀疼痛，身软倦怠，食欲不振，渴不多饮，大便燥结或稀溏，舌质红，苔黄腻，脉濡数。治宜清热解毒，利湿。

方药：银花30克，连翘15克，板蓝根30克，赤芍30克，丹皮12克，黄柏12克，川牛膝30克，泽泻30克，紫花地丁20克，车前草30克。水煎服。

③ 火毒内陷：肛门周围红肿热痛，高烧，烦渴身痛，神昏谵语，腹胀便秘，脓肿逐渐扩散，舌质红绛，苔黄燥，脉数有力。治宜清热解毒。

方药：水牛角30克，生地30克，玄参30克，竹叶心12克，麦冬15克，丹参30克，黄连10克，银花30克，连翘30克。水煎服，并吞服安宫牛黄丸1粒或紫雪丹3克。

(2) 虚证

① 阴寒凝滞：肛门周围有肿块，不红不热，坚硬不痛或有隐痛，畏寒肢冷，舌淡，苔白滑，脉迟缓。治宜温经散寒，和阳散结。

方药：熟地30克，白芥子12克，生姜炭10克，麻黄10克，甘草10克，肉桂6克，鹿角胶12克。水煎服。

② 阴虛濕熱：肛門周圍結腫平塌，皮色暗紅或不紅，按之不熱，疼痛輕微或如錐刺痛，小便淋瀝，大便虛秘。肛周腫塊成膿較慢，潰後膿液淡白，稀薄不臭，潰口內陷，呈空壳狀，全身不發熱或略有虛熱，或寒熱往來（夜間發熱尤甚）。脈細數。治宜滋陰清熱，除濕軟堅。

方藥：生地30克，地骨皮30克，當歸30克，白芍30克，知母12克，黃芩15克，川芎10克，柴胡15克，陳皮12克，澤瀉30克，浙貝12克，干姜10克，甘草6克。水煎服。

③ 氣血兩虛：平素體虛，少氣懶言，面色蒼白，肛門周圍感染腫痛，墜脹，潰後久不收口，膿水清稀，舌淡，苔薄黃少津，脈細弱而數。治宜補益氣血，清熱解毒。

方藥：黃芪30克，黃連10克，黃芩15克，丹皮12克，梔子12克，當歸30克，黨參30克，白朮12克，茯苓15克，生地30克，赤芍30克，川芎10克。水煎服。

肛管直腸周圍膿腫病人，應適當休息。心情應舒暢，避免憂郁或大怒，忌吃辛辣食物。

67. 肛門周圍化膿性汗腺炎

肛門周圍皮膚內大汗腺感染後在皮內和皮下組織反復發作成為慢性炎症，廣泛蔓延，形成很多小膿腫、竇道和瘻管，稱為肛門周圍化膿性汗腺炎。體胖汗多的中年人易患本病。

由於在青春期中後皮膚油脂過多。本病初起時肛門周圍一小塊皮膚變硬，皮膚深部有硬結和壓痛，有的數周後即可消散，但常反復發作。最常見的是有很多小的硬結，連成斑塊，逐漸擴大成較大的硬結，高出皮面，紅腫明顯，有癢痛感。

有时肛周皮肤上有数个表浅脓疱，然后化脓破溃，形成大小不同的瘻口和窦道，部位较浅。多互相交通，向外蔓延。皮肤呈暗紫色，变厚变硬。由瘻口经常流出少量有臭味的脓液，晚期可出现消瘦、贫血。

肛门周围化脓性汗腺炎属于祖国医学的“串臀漏”。“蜂窝漏”的范畴。多由湿热蕴结，热结肛周，或心脾两虚，痰湿结聚所致。

内治法

(1) 实热型：肛门周围皮肤红肿疼痛明显，分泌物多，大便燥结，小便短赤，舌质红，苔黄燥，脉洪数。治宜清热解毒。消肿散结。

方药：皂角刺12克，银花30克，穿山甲片15克，当归30克，赤芍30克，乳香10克，没药10克，陈皮10克，防风10克，浙贝10克，白芷12克。水煎服。

(2) 痰湿型：体胖，咳嗽多痰，肛门周围分泌物多而湿烂，舌淡胖，苔白，脉濡。治宜燥湿祛痰。

方药：苡仁30克，杏仁12克，白蔻仁10克，木通10克，陈皮10克，法半夏10克，茯苓30克，黄连10克，甘草10克。水煎服。

(3) 心脾两虚型：面色苍白，久病体弱，心悸气短，体倦无力，少气懒言，食欲不振，便溏，肛周局部皮色晦暗，肉芽不鲜，脓水时多时少，舌质淡，苔薄白，脉弱。治宜补养心脾，解毒除湿。

方药：苍术20克，土茯苓30克，连翘15克，黄柏12克，白术12克，当归30克，黄芪30克，党参30克，酸枣仁12克，木香10克，远志10克，茯苓30克。水煎服。

外治法

炎症初起，局部可用热敷，用酒精涂擦皮肤，用苦参60克，

银花30克，黄柏30克。煎水坐浴，避免搔抓，以保持卫生。如硬结不散，可用手术治疗。

68. 肛门直肠神经官能症

肛门直肠神经官能症，是以肛门直肠疾病的幻觉症状为主诉的一种癔病性表现。一般将检查无器质性改变而又自觉肛门直肠功能异常的肛门直肠疾病，统称为肛门直肠神经官能症。

患者自己感觉肛门直肠有很多症状（幻觉症状），这些症状常随情绪的变化而变化，意念集中患处时症状加重，反之则减轻。如有的病人自诉能听到肛门内有特殊的风响声（霍霍有声），或闻到肛门内有异常气味，自觉肛门直肠有异物感（实际并无异物），流水潮湿感（实际上肛门并不潮湿），蚁走感，跳动瘙痒感，并感到难以忍受的疼痛、坠胀和麻木，并感觉这些症状都在加重和发展。部分病人有不同程度的心悸、失眠、悲观、忧虑、疲乏、精神萎靡、食欲减退、腹痛、腹泻、腹胀、便秘等症状，但临床检查，却无任何器质性病变，找不到客观异常病变的依据，这些都是肛门直肠神经官能症的表现。根据主诉病史和检查，可以作出诊断。但在未确定排除器质性病变以前，不要轻易下诊断，以免延误治疗，而增加病人的痛苦。

对肛门直肠神经官能症采取暗示疗法，可使症状暂时消退。

现代医学对肛门直肠神经官能症的发病机理尚未阐明，但认为精神因素在发病上起着重要的作用，精神创伤，疑病

恐癌，局部疼痛刺激，医源性因素（诊断治疗方面有失误）等等，均可引起大脑功能暂时失去平衡，植物神经功能紊乱，周围神经反射受到阻碍，肛门直肠神经活动失调而发病。

肛门直肠神经官能症属于祖国医学的“郁证”范畴。中医认为本病多由情志怫郁所致。《类证治裁》说：“经言怵惕思虑则伤神，忧愁不解则伤意，悲哀动中则伤魂，喜乐无度则伤魄，盛怒不止则伤志，恐惧不解则伤精。……”《灵枢·口问篇》说：“悲哀忧愁则心动，心动则五脏六腑皆摇”。阐述了本病病机是情志过极，损伤及心，故而引起心气不足、心血亏虚，心神不宁、神不守舍的心神疾患。

辨证分型治疗

（1）心神不宁：除肛门直肠神经官能症症状外，还伴心悸，失眠，多梦，易惊，舌淡，苔白，脉细数。治宜养心安神。

方药：当归30克，熟地30克，酸枣仁20克，五味子20克，柏子仁15克，远志10克，党参30克，天冬12克，麦冬12克，茯苓30克，玄参15克，炙甘草10克。水煎服。

（2）肝郁燥火：性情急躁，胸闷腹痛，便秘尿少，肛门灼热，有针刺样感，舌苔黄燥，脉弦数。治宜清热润燥，疏肝解郁。

方药：生石膏30克，熟地20克，麦冬20克，知母12克，淮牛膝30克，玄胡12克，川楝子12克，当归30克，柴胡12克。水煎服。

（3）肝经湿热：肛门直肠发胀，有沉重感、灼痛感或瘙痒，心烦易怒，口苦，便秘，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦滑。治宜清热利湿。

方药：龙胆草10克，木通10克，泽泻30克，柴胡15克，车前

草30克，生地30克，当归30克，黄芩15克，栀子10克。水煎服。

(4) 心胆气虚：除肛门直肠神经官能症症状外，还伴胆怯，不眠，心悸，胸闷，口苦，呕吐痰涎，舌苔薄白，脉弦。治宜清胆和胃，除痰止呕。

方药：陈皮10克，法夏10克，茯苓30克，竹茹12克，枳实10克，生姜10克，甘草10克。水煎服。

穴位注射治疗

取穴：腰俞，长强。

穴位注射当归注射液或维生素B₁注射液4毫升，每穴2毫升，每日1次。

耳针治疗

取穴：神门，交感，心，直肠下段，内分泌。

体针治疗

取穴：内关，心俞。留针30分钟。

除以上治疗外，还要注意患者的精神因素。不要批评病人，而应耐心地安慰病人，解除病人的顾虑和紧张情绪，树立治愈的信心。同时，鼓励病人加强锻炼，可练气功，打太极拳，以增强体质，保持大脑皮层功能稳定，有时可给以暗示疗法。

护理方面，对腹痛、腹胀、肛门下坠、肛门疼痛的病人，可在腹部或肛门作热敷或冷敷，可减轻症状。在饮食方面，避免进食辛辣等刺激性大的食物，保持大便通畅，多吃新鲜蔬菜和水果。

69. 肛门失禁

肛门失禁可以分为完全性失禁、不完全性失禁和感觉性

失禁。

肛门完全失禁：症状严重，不能随意控制排便，排便无次数，肠蠕动时，粪便即由肛门排出。咳嗽，下蹲，走路，睡觉都可有粪便或肠液流出，污染衣裤和被褥。肛门周围潮湿、糜烂、瘙痒，或肛门皮肤呈湿疹样改变。

肛门不完全失禁：粪干时无失禁现象，粪稀时则不能控制。

肛门感觉性失禁：不流出大量粪便，而是当粪便稀溏时，在排便前动作稍慢或不自觉有少量粪便溢出，污染衣裤，腹泻时更为显著，常有粘液刺激皮肤。

现代医学认为，完整的排便控制机能，包括三个因素：大便的贮存机能，直肠反射弧的完整，灵活的括约机能。这三个因素中，任何一个发生障碍，都能引起不同程度的肛门失禁。而手术损伤则为肛门失禁的主要原因。

祖国医学认为，肛门失禁是由于气血衰退，中气不足，气虚下陷，肛门不能收摄或损伤失治而造成的。《诸病源候论》说：“大便失禁者，由大肠与肛门虚冷滑故也。肛门大肠之候也，俱主糟粕，既虚弱冷滑，气不能温制，故使失禁”。其治疗，宜补中益气，健脾固摄。

内治法

（1）中气不足，气虚下陷：肛门失禁，气短懒言，面色㿔白，神疲乏力，脉弱，舌淡苔白。治宜补益中气。

方药：黄芪60克，枳实30克，升麻10克，柴胡10克，当归10克，党参30克，陈皮10克，炙甘草10克。水煎服。

（2）脾虚肠滑：肛门失禁，纳差，乏力，舌淡苔白，脉细弱。治宜健脾固涩。

方药：党参60克，干姜10克，白术12克，山药30克，诃子15克，

茯苓15克，炙甘草10克。水煎服。

外治法

(1) 针刺治疗

取穴：八髎，腰俞，百会，承山。强刺激，不留针。呃门、风池中强刺激，留针20—30分钟。还可用于头皮针、取顶中线、枕下旁线，以150—200转/分捻转，得气后留针20—30分钟。

(2) 按摩治疗

① 患者侧卧，左或右下肢屈曲，医生以两手拇指掌侧对置于臀部环跳穴处，其余4指分置臀部的两侧处，着力长按3—5分钟。操作时，应嘱患者臀部肌肉放松。

② 患者直立或直坐，医生以两手分置腰部两侧，拇指置季肋下京门穴处，其余4指置腰后章门穴处，着力拿提腰部肌肉2—3分钟。拿提频率以每分钟10—15次为宜。

70. 肛门部下疳

肛门部下疳是梅毒原发损害，属于肛直肠性病的一种，是由梅毒螺旋体引起的慢性传染病，主要通过性交感染。

肛门部下疳属第一期梅毒，常见于女性。感染后2—6周发病，多生在肛门边缘。初起为一小块糜烂，以后生成溃疡。呈圆形，如生在肛门皱襞内，则成棱形，质硬，边缘突起，红色，不痛，底灰色，常有少量脓性分泌物。因下疳分泌物刺激，肛门口皮肤常有裂口。3—5周后，两侧腹股沟部，可有数个不相联合的坚硬淋巴结。

肛门部下疳初起时，肛门部发痒，抓破脱痂后，生成溃疡。此种溃疡不痛，但如有继发感染或溃疡累及括约肌，则感疼痛，常有少量分泌物粘于溃疡面上。这种分泌物放在显微镜下检查，可找到梅毒螺旋体。3—4周后检查血液，有阳性梅毒反应。

肛门部下疳属于祖国医学的“下疳”、“猴子疳”等范畴。《外科证治全书》说：“下疳一证，属肝、肾、督三经之病，……内因者，由欲火猖动，……致败精湿热留滞为患。外因者，由娼妇阴器淤浊未净，辄与交媾，致淫精邪毒，感触精宫为患，最不易愈”。由此可见肛门部下疳是由于不洁性交，感触淫毒，湿与热结，流注下焦而致。其治疗，宜渗湿通淋，泻火解毒。

内治法

（1）肝经湿热：下疳初起，皮肿红亮，甚如水晶，破流腥水，麻痒时发，肿痛日增，进而肛门皮肤糜烂裂口，发热，小便涩滞，大便不畅，肛门潮湿腥臭。舌红苔黄腻，脉弦数。治宜泻肝渗湿。

方药：龙胆草10克，木通10克，泽泻30克，柴胡20克，生地30克，车前草30克，当归15克，丹皮12克，栀子12克，生大黄6克。水煎服。

（2）下焦湿热：肛门内灼痛，排便时灼痛加重，里急后重。常有大量黄白色分泌物从肛门流出，腥臭；或小便涩淋、溺痛，流黄浊败精，前阴部肿痛糜烂。舌红苔黄腻，脉数。治宜泻火通淋。

方药：生大黄12克，扁蓄12克，木通10克，车前草30克，瞿麦12克，栀子12克，黄连10克。水煎服。

（3）下焦热毒：初起肛门痒痛，渐生疮瘡，色紫糜烂，

渐成溃疡，表面有灰色坏死薄膜，口燥咽干，大便秘结或里急后重，舌红苔黄，脉数。治宜泻火解毒。

方药：黄连12克，黄柏12克，黄芩30克，栀子12克，生大黄10克。水煎服。

（4）阴虚火旺：肛门痔疮溃破肿痛，疼痛昼轻夜重，小便赤涩淋漓，头目眩晕，腰酸腿软，自汗盗汗，发热口干，憔悴瘦弱，神疲乏力，或前阴作痛，时出白浊。舌红苔少，脉细数。治宜滋阴泻火。

方药：生地30克，熟地30克，山萸15克，山药30克，丹皮12克，茯苓20克，泽泻30克。水煎服。

外治法

（1）黑豆500克，甘草30克，赤皮葱3根，槐条200厘米。煎汤外洗患处。

（2）蛇床子30克，地骨皮30克，桑枝30克，槐枝30克。煎汤外洗患处。

71. 糖尿病并发疔肿

糖尿病是全身性疾病（见《百病良方》第一集），由于机体抵抗力低，组织修补能力差，易于并发皮肤感染而患疔疮肿痛。疮疖又可使糖尿病病情加重，且不易控制，严重者会发生糖尿病酮症。糖尿病病情加重又能促使疔肿恶化。二者形成恶性循环。如不采取积极有效的治疗，很容易发展成为酮症酸中毒及败血症而死亡。因此，及时有效地治疗疔肿痛，可减少、阻止酸中毒及败血症的出现。

糖尿病并发疔肿，患者患糖尿病往往病程较长，反复发

作，其疔肿可发于颈部、面颊、背部等处。局部红肿热痛，全身症状有恶寒发热（有的高烧可达40℃），烦躁不安，或口渴多饮，咽干口臭，尿频便干。

糖尿病并发疔肿，身若燔炭。乃久病气阴耗损，热毒蕴聚血分，化毒生疔。热毒蕴结为标，气阴两亏为本。其治疗，宜标本兼顾，“急则治其标”，“缓则治其本”。

内治法

方一：黄芩30克，黄连15克，蒲公英30克，连翘15克，银花30克，玄参30克，苍术30克，黄芪45克，山药30克，丹参30克，生地30克。水煎服。

加减：烦渴多饮加生石膏、知母、人参叶。不思饮食加乌梅、鸡内金。胸脘痞闷、苔厚腻加藿香、佩兰。恶心呕吐加陈皮、竹茹、半夏。大便干结加大黄、芒硝（冲服）。高热不退加羚羊角粉2克（冲服）。

方二：板蓝根30克，牛蒡子15克，玄参45克，苍术30克，马勃10克，大黄15克（后下），桃仁10克，红花10克，僵蚕10克，羚羊角粉5克（冲服），银花30克，连翘15克。水煎服。

外治法

方药：蒲公英30克，紫花地丁30克，野菊花30克，玄参30克，丹皮15克，黄芩30克，黄连10克。水煎。用纱布浸药水，敷于患处。

注：因糖尿病易感染，故不宜针刺。

72. 变形性膝关节炎

变形性膝关节炎，又称肥大性膝关节炎或膝关节增生性

骨关节炎，是人到中年以后发生的一种常见病、多发病。膝关节是人体操作多、负荷量大的关节之一，人到老年，组织退变，加上慢性损伤（负荷过重等），易致本病。

变形性膝关节炎起病缓慢，有时因轻度外伤、着凉、负荷过重而诱发。初起膝关节酸痛和活动不灵活，早晨起床或长期坐后起立时最明显，髌骨周围轻度压痛，经活动片刻即行消失。但活动过多或站立负荷时间过长又觉膝关节不适，关节肿胀，内外膝眼明显压痛，活动时膝关节有轻度的摩擦音，如进一步发展，股四头肌也会萎缩。中老年人，骨质疏松，在站立和行动时（尤其是肥胖者），重力通过股骨髁，力点完全集中于胫骨髁的髁间棘上，形成骨刺，对肥厚的滑膜产生刺激，如关节面变形和狭窄，关节活动将显著受限，疼痛加剧，此时关节局部肿胀，也可出现畸形，一般呈内翻改变，关节不强直。而这些特点往往不是固定不变的，症状的变化大多数和天气骤寒骤暖以及负荷过重直接有关。

步行过久则患处疼痛加剧，上下楼梯困难，下楼或下蹲时膝关节疼痛更明显。

膝关节内侧有压痛，并可触及痛性结节或条索状物，按之酸痛。

膝关节内翻畸形者，加上形体肥胖，行动更困难，甚至跛行。

变形性膝关节炎可通过X线摄片检查、关节镜检查而确诊。

变形性膝关节炎属于祖国医学的“骨痹”、“痿证”等范畴。中医认为肾主骨生髓，肾气虚，久则髓减骨枯，骨枯发展为骨痿。肝肾阴虚，虚则易受风寒湿气侵袭，治当以祛湿为主；久卧湿地，寒湿流入脚膝，痹弱重痛，治当散寒祛

湿并重。如因淤血留滞，治当活血化淤。

中药治疗

(1) 骨刺片(成药)，每次3片，每日3次。

(2) 三七片，每次5片，每日2次。

(3) 六味地黄丸，每次10克，每日3次。

针刺治疗

取穴及手法：

(1) 内膝疾穴(膝内粗隆直上4—6横指，血海穴旁开)，平卧，膝关节微屈，针2—3寸，留针30分钟。

(2) 外膝疾穴(膝外粗隆直上4—6横指，梁丘穴旁开半寸)，平卧取穴，膝微屈，针2—3寸，留针30分钟。

(3) 阳陵泉(腓骨小头前下方凹陷处)，针2—3寸，强刺激。

(4) 阴陵泉(胫骨内髁下缘，在胫骨内侧缘和腓肠肌之间的凹陷处)，针2—3寸。

以上穴位均每日针刺1次，10次为一疗程。

外敷膏药治疗

(1) 麝香虎骨膏，外贴患处。

(2) 活血镇痛膏，外贴患处。

股四头肌锻炼法

股四头肌的肌力锻炼是很重要的。方法：患者平卧，足髁部垂一个1—2公斤的沙袋，膝伸展抬高105°，每次保持10秒钟，每日连续锻炼20次。

锻炼不得法会适得其反，会增加痛苦。变形性膝关节炎患者不宜长跑及作站桩功、下蹲等功能锻炼。

73. 胸部迸伤

胸部迸伤，是指平时无其他病症，而在用力举重、攀高、搬重物等活动中，为了完成动作而进气用力，或骤然用力过猛而发生的胸胁部或背肩部疼痛。也即是胸壁软组织及呼吸道在外力作用下所引起的一种损伤。多见于重体力劳动者在从事提、举、推、挑、扛重物的过程中，用力不匀或负重过大，使气聚结于胸内而不得消散，从而引起胸部迸伤。

胸部迸伤的症候：胸闷不适，叹息，范围较广的隐隐窜痛或刺痛，作深呼吸则疼痛，不敢俯仰转身。检查无外伤，无骨折，X线检查无异常。

胸部迸伤属于祖国医学的“岔气”范畴。轻者仅胸部疼痛（隐痛），重者支气管破裂可引起咯血、痰中带血。出血症状可在受伤后立即出现，也可在受伤后的次日发现。中医认为，“气为血之帅”，“气行则血行，气滞则血滞”，严重伤气必导致伤血。

辨证分型治疗

（1）伤气型：胸闷不适，隐隐窜痛，作深呼吸疼痛。治宜理气通络，活血止痛。

方一：穿山甲片10克，青皮10克，茴香10克，浙贝母10克，漏芦10克，白芷10克，木香10克，陈皮6克，甘草6克。水煎服。每日1剂。

方二：郁金15克，穿山甲片15克，降香10克，青皮6克，香附15克，木香10克，赤芍30克，苏子10克。上药共研细末，每次服6克，每日服2次，用酒或葱汤送服。

(2) 伤血型：胸中刺痛，胀闷，气急，痰中带血，以手护胸，不敢俯仰转身，治宜活血化淤，理气止痛。

方一：穿山甲片15克，桃仁12克，当归30克，大黄、红花各10克，天花粉10克，柴胡15克，赤芍30克。水煎服。

方二：大黄10克，芒硝10克，枳壳6克，厚朴10克，当归30克，桃仁10克，红花10克，三棱10克，姜黄10克。水煎服。此方为攻淤逐滞之峻剂，病退即停用，不宜久服。

方三：制草乌3克，当归12克，丹参30克，三棱10克，香椽皮10克，佛手10克，陈皮10克。水煎服。此方适用于胸部进伤经久不愈者。

针灸治疗

(1) 体针：取穴内关、膻中、乳根、周荣、中府、云门、期门、神藏。以上穴位每次选用2—3穴，中等刺激，留针10—15分钟。

(2) 耳针：取穴神门、胸、交感、皮质下。强刺激。留针15—20分钟。

推拿治疗

(1) 束胸法

患者仰卧，两下肢平伸，胸部微向上挺起，医生用两手四指分置脊柱正中之至阳穴两侧，拇指食指分开，抱定胸部，自背后向前胸斜摩至期门穴止。反复操作3—5分钟。

(2) 分肋法

患者仰卧，医生用两手拇指分置胸骨旁两侧俞府穴处，其余两手四指抱定胸部两侧，沿肋间隙自内向外分推至腋中线止，由上向下至乳根穴处肋间隙止，反复操作3—5分钟。推拿过程中，患者应自由呼吸，医生推拿用力应均匀，手法宜轻柔缓慢。

（3）按中府云门法

患者仰卧，医生用两手四指并置于左或右侧胸大肌外缘处，将手指微微分开，自内向外沿肋间隙向中府、云门呈梳状摩动，反复操作1—2分钟，再以两手四指并置于中府、云门穴处，着力长按，反复操作3—5分钟。

（4）拿肩井法

患者直坐，医生用两手四指置肩后或两手四指掌侧置肩后，拇指掌侧置肩井穴处，着力向上拿提2—3分钟。操作时用力大小，以患者能耐受为度。拿提后，可用指柔手法轻柔，以消除拿提后之不适。

（5）内外关按法

患者直坐或仰卧床上，前臂伸直，医生先用拇指掌侧置腕掌侧大陵穴处，其余四指置腕背侧阳池穴处，自上向下逐渐揉动经内、外劳宫穴至中指端止，反复操作1—2分钟。再以拇指、食指分别置于前臂屈侧内关穴及伸侧外关穴处，对过合按3—5分钟。揉动自腕至指端时，动作应轻柔，合按后可配合指揉法，以消除按后之不适。

74. 胸部挫伤

在日常生活和生产劳动中，胸壁软组织受外力撞击、挤压后引起胸痛者，称为胸部挫伤。

胸部挫伤，由于胸壁肌肉出血、血肿或骨膜下出血，咳嗽或呼吸时会使胸痛加剧，有的患者疼痛可沿肋间神经放射。检查时，挫伤处可见有表皮损伤或皮下溢血、肿胀，压痛明显，压痛的位置比较固定，肋骨无压痛。

胸部挫伤如果在早期处理不当，血肿没有很好吸收，可引起胸壁肌肉的互相粘连，以致后期在用力呼吸时，常常有隐痛、胸闷等症状，影响上肢的正常功能活动，祖国医学称之为“陈伤”。

肋骨或肋软骨的骨膜挫伤时，损伤的肋骨、软骨处往往明显压痛。如骨膜下血肿肌化，在晚期可使肋骨局部有轻度隆起与增宽。

中药治疗

（1）内治法

方一：当归30克，赤芍30克，丹参30克，玄胡12克，郁金15克，三七粉3克（冲服），陈皮10克。水煎服。

方二：佛手10克，三棱12克，香橼皮10克，当归30克，柴胡15克，炮甲珠15克，制草乌3克。水煎服。

（2）外治法

方一：红花、樟脑、生栀子、面粉各等份，共研细末，再用葱头煎汤调敷患处。

方二：韭菜连根捣烂加醋炒热，用纱布包裹，乘热敷患处。

针灸治疗

常用穴：行间，乳根，膻中，周荣，曲池。

方法：用轻刺激法，至病人有酸、麻、沉、胀感为止。留针半小时，隔天治疗1次。

推拿治疗

表皮有破损的胸壁挫伤病员，应先清洗创面后予以包扎，以免引起局部皮肤感染，可待伤口愈合后再行推拿治疗。如无表皮外伤，可以采取以下治法，同时配合局部热敷，以促进恢复。

(1) 束胸法(见《胸部迸伤》的推拿治疗,本书第118页)。

(2) 分肋法(同上,见本书第118页)。

(3) 扩胸法。患者直坐,上肢屈肘,两手交叉置于枕后,医生站在患者身后,先用两手拿定患者两肘部,再以膝关节置其胸椎陶道穴上,嘱患者向前挺胸进行深呼吸,然后将两肘紧拉向后的同时,在背部用膝推按向前,反复推按3—5分钟。

75. 梨状肌损伤综合征

腰臀部软组织损伤中,因臀部深层肌肉梨状肌的损伤而招致急、慢性坐骨神经痛、臀部困痛、下肢功能障碍,这叫梨状肌损伤综合征。

梨状肌是处于臀部深层的一块小肌肉,许多血管、神经由其上、下缘通过。梨状肌与其他肌肉配合使大腿外旋,但由于所处解剖位置的特点,往往为完成某种动作(如下肢外展、外旋,或由蹲位变换为直立)时,使梨状肌急剧而不协调地收缩,或突然牵拉梨状肌,或肌肉组织原有病变又遇到不适宜的外力等,均可使梨状肌损伤。如损伤严重,或损伤持续时间较长,就会因局部肌肉营养障碍使梨状肌弥漫性肿胀,直接影响从其上、下孔通过的神经、血管受压而产生各种临床症状,如腰臀部困痛,或一侧臀部深在性酸胀,伴随一侧下肢沿大腿后面直至小腿外侧的放射性疼痛。有时,疼痛亦向小腹部及会阴部放射。在大小便或大声咳嗽增加腹压时,下肢串痛可以加剧。

检查时，可见患者跛行，腰部无明显异常，患侧臀肌轻度萎缩。双拇指触诊，在梨状肌上可触到条索状肌束隆起，有明显压痛。直腿抬高 60° 角疼痛明显，超过 60° 角以上时疼痛反而减轻。

中药治疗

方一：续断30克，川牛膝30克，杜仲15克，桑寄生30克，狗脊30克。水煎服（孕妇忌服）。

方二：吴茱萸末15克，黄酒适量。吴茱萸末炒热，用黄酒调匀，敷贴患处。外用油纸、纱布包扎。

针灸治疗

取穴：肾俞、大肠俞、下髎、环跳、秩边、殷门、委中、阳陵泉。

方法：每次选2—3穴，每日1次，留针30分钟。10次为一疗程。也可加用温针灸或艾灸。

推拿治疗

整个手法分为三步。第一步，舒筋活络，以推为主。医生手掌放置患处，以掌根为力点，作上下或左右节律性推动。病情有轻重、虚实之分，推拿时也相应采用轻重、快慢动作。第二步，缓解痉挛，以滚法为主，滚揉相济。这是推拿治疗的重要环节。医生手握空拳，以手背和小指、无名指、中指本节或指掌关节的背面放置在患处敏感点，逐渐用力由轻到重不断滚动，使力渗透至病处。然后换用大拇指，放在梨状肌上，朝肌纤维交叉方向弹拨数次，疏理肌筋。对肥胖患者，可用尺骨之鹰嘴部分，按揉结合施术。第三步，调和气血，以拍击为主。医生用单掌或双掌拍击患部，先轻后重，举止分明，达到调和的目的。最后在患肢“承山”、“委中”二穴提弹两遍。

76. 肩部软组织扭挫伤

肩关节是人体活动范围最大的部位之一。肩部在日常生产劳动中担负繁重的工作，故扭伤、挫伤的机会也较多。常因跌仆、闪扭、过度用力高举或提重、用力支撑等致肩部软组织扭伤、挫伤。或长期肩部负重，肌肉劳损，复受寒邪侵袭肌腠，流注经络关节，致使肩部损伤长久不愈。

肩部软组织扭挫伤有急性型和慢性型。急性型表现为局部疼痛，不能活动，肌肉压痛，或局部红肿。慢性型（病程较久）为局部微痛，红肿不明显，但活动受限，甚至肩关节僵硬。

肩部软组织扭挫伤属于祖国医学“跌仆损伤”范畴。用力过度，外邪侵袭，致气滞血淤，关节不利。治宜活血祛淤，通经活络。

中药治疗

方一：归尾15克，川芎10克，红花10克，赤芍30克，泽兰15克，香附15克，田七粉3克（冲服），乳香10克，没药10克，甘草6克。水煎服。

方二：黄栀子4份，乳香2份，黄连1份，细辛1份，三七1份，樟脑1份。将各药分别碾粉后混合，装瓶密封。用药前先将患部洗净，再将药粉加食醋调成糊状，敷于患处，盖上油纸，用纱布包裹，胶布固定。药干后再换，或将干药块取下再用醋调成糊状，重新敷上。

敷药后6小时内疼痛可减轻，12小时后疼痛基本消失，但活动时仍痛。2—3天疼痛、肿胀消失。

注：①本方适用于软组织扭挫伤以及风湿性关节炎、类风湿性关节炎的局部肿胀疼痛。②如有骨折，应以治疗骨折为主，待骨折固定后再用此方止痛、消肿为辅。③皮肤有伤口者，不宜用本方治疗。

方三：生栀子、生韭菜各等量。混合捣烂后，用鸡蛋清调成糊状，敷于患处，要将红肿面盖完，厚度约2—4毫米（如有骨折，固定后再敷），外用纱布固定，每日1次，一般敷3—5次即愈。

方四：黄柏、生半夏、五倍子、面粉等量，食用醋适量。用法：先将面粉与五倍子共炒至熟，置冷后与余药共研成细末，过筛后贮瓶备用。使用时加入适量食用醋，调成糊状，以武火煮熟成泥膏，将这种泥膏涂敷于损伤部位，并盖以白麻纸4—5层，再用胶布固定，1—2天换药1次。

针灸治疗

取穴：肩贞、养老、肩三针、条口。

方法：肩贞透极泉，养老透内关，条口透承山，中强度刮针。每日1次，10次为一疗程。

推拿治疗

（1）肩周围按法

患者侧卧，左或右上肢平置于侧胸部，医生用两手拇指对置于肩下三角肌下缘之臂臑穴处按压，再逐步移动至臑会穴，再依次移至肩部后方之肩贞穴，腋窝下之极泉穴及肩内侧下方之中府、玄门穴处长按，反复操作3—5分钟。按压时，两手拇指用力应均匀，待上肢有麻胀感时，再向左或右侧移动。

（2）摩按肩周法

患者直坐，医者双手自病侧颈项部沿肩峰与肩胛区反复

摩按 5—10 分钟，再自患侧肩峰、三角肌处向肘部、腕部顺序向下，反复摩按 5—10 分钟。摩按肩部时应摩按肌肉，不应限于摩擦皮肤，且摩按用力应均匀而有节律，用力大小以皮肤微红为度。

（3）摇肩法

患者直立或侧卧，医生用一手稳定患者肩部，另一手紧握患肢手指，作顺时针方向或逆时针方向旋转摇动 2—3 分钟。操作时，嘱患者肌肉放松，摇动的幅度应根据患肩恢复情况逐渐增加，忌用暴力，以防止肩部肌肉撕裂伤。

（4）拿肩井法

患者直坐，医生用手四指置肩后或两手四指掌侧置肩后，拇指掌侧置肩井穴处，着力向上拿提 2—3 分钟。操作时用力大小以患者能耐受为度。拿提后，可用较轻柔的指揉手法，以消除拿提后之不适。

77. 肘部软组织扭挫伤

肘部软组织扭挫伤多因运动失慎、跌仆闪挫、气血壅滞等而周流不畅，或外伤之后失治、误治，以致肘部损伤迁延不愈。

根据肘部软组织损伤症状的不同特点，临床上分为以下两种类型：

（1）急性型：初伤之后，局部酸痛，红肿明显，活动痛剧。

（2）慢性型：肿胀虽消，疼痛久久不消，活动乏力，甚则关节挛缩，屈伸不便。

肘部软组织扭挫伤属于祖国医学的“跌仆闪挫”范畴。
治疗宜活血祛瘀，消肿止痛。

中药治疗

方一：桑寄生、威灵仙各30克，猪骨或羊骨60克，水煎服。

方二：川芎180克，制乳香180克，制没药180克，桃仁180克，红花180克，地鳖虫180克，公丁香180克，当归240克，肉桂240克，血竭240克，广木香240克，制川乌300克，制草乌300克。共研细末，水泛为丸，成人每次服3克，15岁以内1—1.5克，日服2次。

方三：木瓜60克，蒲公英60克，黄柏30克，地龙30克，炙乳香30克，炙没药30克，炙自然铜30克，丹参30克，大黄150克，红花20克。共研细末，过筛，取凡士林适量入铜锅或瓦钵内，置文火上加温熔化，再将药末徐徐加入，用棒不断地搅成糊状，去火冷却，放入盛器中备用。用时取药膏外敷损伤处。

方四：红花30克，赤芍30克，白芷30克，栀子30克，桃仁30克，乳香30克，没药30克，大黄60克。共研细末，用酒调成糊状，外敷患处，为防止药物脱落，减少蒸发，外用塑料纸包扎。如干燥后，可取下再加酒调敷，连续敷用3—4次后去除。若尚未治愈，可用第二剂重新调敷。皮肤有破损者勿用。

方五：生大黄100克，丹参60克，红花60克，延胡索40克，冰片10克。共研细末，取药末适量用蜂蜜与75%酒精各半调成糊状，均匀地敷于患处，再以绷带包扎固定，每日换药1次。

方六：当归尾30克，合欢皮30克，紫荆皮30克，白芷30克，乌药30克，青木香30克，山栀50克，生大黄50克，乳香10克，没

药10克，生蒲黄20克，冰片5克。共研细末，过120目筛，用熟蜂蜜调成膏状外敷患处，固定3—5天，肿胀即可消退。

方七：麻黄12克，伸筋草12克，红花12克，桑枝12克，肉桂10克。腕关节以下扭挫伤加桂枝，局部淤肿加血竭，疼痛剧烈加乳香、没药。

用法：每2天1剂，水煎，先熏后洗患处。每日2次，6次为1疗程。血肿者需先作冷敷，24小时后再行本法。

针灸治疗

常用穴：曲池、冲阳、手三里、天井、尺泽、压痛点。

方法：每次选2—3穴，每日1次，10次为1疗程。在压痛点可用艾条灸10—15分钟。

推拿治疗

（1）推上臂三阳法

患者侧卧，左或右上肢平放于胸侧，操作分以下三个步骤进行。

① 用两手拇指对置于肩关节上方肩髃穴处，其余两手指扶定上肢，自上向下沿上肢伸侧经臑会至肘尖上方天井穴止，反复操作2—3分钟。

② 使患者肩部微向内收，前臂微向内侧旋转，以两手拇指对置，自腋后由上向下沿上臂侧推至肘尖后方小海穴止，反复操作3—5分钟。

③ 使患者肩部微向外展，前臂微向外侧旋动，以两手拇指对置，自肩关节上方肩髃穴起，自上向下经臂臑、五里至曲池穴止，反复推动2—3分钟。推动时，在沿经起止点穴位上可配合按。

（2）推上臂三阴法

患者仰卧，左或右上肢平放于床上，手掌向上，医生坐

其侧。操作分以下三个步骤进行。

① 医生以两手拇指掌侧对置于腋前天泉穴处，两手其余四指扶定上肢，自上向下推动至曲泽穴止，反复操作2—3分钟。

② 以两手拇指对置于天府穴处，自上向下推动，经侠白至尺泽穴止，反复操作2—3分钟。

③ 两拇指对置于极泉穴下，自上向下推动，自青灵至少海穴止，反复操作2—3分钟。

推动时，如患者皮肤干燥，可蘸酒以润滑。

（3）捏上臂法

患者仰卧，左或右上肢稍外展，医生以手拇指掌侧置患者上臂外侧，其余四指置上臂内侧青灵穴处着力捏压，反复操作1—2分钟，再以拇指置上臂外侧，其余四指掌侧置极泉下方，自上向下沿肱骨内缘逐步下移，经青灵至少海穴止，反复操作2—3分钟。捏压下移时，应均匀、缓慢而着力。

（4）推前臂三阳法

患者仰卧或直坐，前臂平放于床上或桌上，手法操作分以下三个步骤。

① 医生以两手拇指对置于肘尖下方，其余四指扶定前臂，自上向下沿前臂伸侧正中线推动，经外关至阳池穴止，反复操作2—3分钟。

② 使患者前臂微向尺侧倾斜，医生以两拇指对置肘部桡侧曲池穴处，自上向下推动，经温溜至阳溪穴止，反复操作2—3分钟。

③ 患者前臂微向尺侧倾斜，医生以两拇指对置肘尖尺侧小海穴处，自上向下推动，经支正至阳谷穴止，反复操作

2—3 分钟。

(5) 推前臂三阴法

患者直坐或仰卧，左或右上臂平放于床上或桌上，操作分以下三个步骤进行。

① 医生以两手拇指掌侧对置于肘内尺泽穴处，其余四指扶定前臂，自上向下推动，经内关至大陵穴，反复操作 2—3 分钟。

② 使患者前臂微向桡侧倾斜，以两拇指掌侧对置肘内尺泽穴处，由上向下推动，沿桡侧外缘，经孔最至太渊穴止，反复操作 2—3 分钟。

③ 使患者前臂微向尺侧倾斜，以两拇指掌侧对置肘内尺侧少海穴处，由上向下推动沿尺侧缘至神门穴止，反复操作 2—3 分钟。

78. 腕关节劳损

腕关节由于受直接或间接暴力造成软组织损伤，或因工作性质（如腕关节活动过量）引起长期疼痛而无骨折者，称为腕关节慢性劳损。

腕关节急性或慢性损伤后，常引起关节附近的韧带扭伤、撕裂或劳损。个别可出现创伤性肌腱滑膜炎。局部软组织损伤以后，由于出血淤积，久之可以机化粘连，造成腕关节长期疼痛。

临床上，腕关节损伤常有典型的外伤史。一些虽无外伤而经常出现腕部疼痛（疼痛部位与其所在处软组织损伤位置一致）、肿胀与活动受限，也属腕关节劳损。其治疗，宜理

筋通络，活血止痛。

中药治疗

方一：芙蓉叶60克，紫荆皮15克，生南星15克，独活15克，白芷15克，鲜马齿苋30克，生葱汁、黄酒各适量。

用法：上药共研细末，加马齿苋捣烂、和匀，药末加生葱汁、黄酒同炒，待热（以不烫伤皮肤为度）外敷患处，每日换药1次。

方二：三七粉6克。

用法：三七粉调酒，揉擦患处，每日揉擦多次（不拘次数）。

针灸治疗

常用穴：外关、合谷、阳溪、手三里、外劳宫、阳池、阳谷，以1—1.5寸毫针行腕针治疗。

方法：每次选2—3穴，每日1次，针后可配用局部温灸法。

推拿治疗

（1）梳手背法

患者直坐或仰卧，前臂放于桌上或床上，手掌向下，手指伸直。医生以手四指掌侧置腕关节阳池处，摩动时再将四指分置于1—2指、2—3指、3—4指、4—5指之间的掌关节间隙，自上向下呈梳状摩动至液门穴平高处止，反复操作2—5分钟。操作时，患者掌心应尽量放平，梳状摩动之动作应缓慢而着力。

（2）内外关按法

患者直坐或仰卧床上，前臂伸直，医生先以手拇指掌侧置腕掌侧大陵穴处，其余四指置腕背侧阳池穴处，自上向下逐渐揉动，经内、外劳宫穴至中指端止，反复操作1—2分钟，再以拇指、食指分别置于前臂屈侧内关穴及伸侧外关穴

处，对过合按3—5分钟。揉动自腕至指端时，动作应轻柔，合按后可配合指揉，以清除按后之不适。

（3）腕屈伸法

患者仰卧，上肢伸直，手掌向上，医生以两手拇指掌侧对置于肘窝之曲泽穴处，自上向下推动，经大陵至劳宫穴止，反复操作2—3分钟。再使患者屈肘，医生以一手拇指置肘部小海穴处，其余四指置曲池穴处按压。最后，用手握住患者手指，再按压手掌，使腕部背屈数次后，继以背伸，反复操作3—5分钟。

（4）分掌法

患者直坐，手掌向上，医生先用拇指置腕关节掌侧大陵穴处轻轻指揉，再用拇指掌侧自上向下经劳宫推动至中指端止，反复操作2—3分钟。然后，将两手拇指对置大陵穴处，其余四指置患者手背之两侧扶定，以两手拇指掌侧沿大、小鱼际分摩至拇指少商穴及小指少泽穴处止，反复分摩3—5分钟。推动及分摩时，着力应轻缓而有节律。

（5）捏合谷法

患者直坐，手指微弯曲，医生以手拇指置腕部桡侧之阳溪穴处，其余四指置其外侧，自阳溪穴起向下沿1—2掌关节间隙经合谷穴沿食指桡侧缘向下指摩至商阳穴止，反复摩动2—3分钟，再以手拇指端置合谷处捏陷3—5分钟。

79. 腕管综合征

腕管综合征又称腕管症候群，是指正中神经在腕管内受压而引起手指麻木、疼痛或鱼际肌麻痹等神经症状的一种病

症。女性多于男性，大多数发生在右手，常见于40—50岁的体力劳动者。劳动后症状可加剧，休息后则症状减轻。有的患者生气后症状可加重。

腕管综合征的病因不明，可能与内分泌有关（如妇女停经、妊娠或哺乳期发病）。此外，腕部的慢性劳损，腕管内腱鞘囊肿、脂肪瘤、腕骨骨折、脱位，腕横韧带增厚而使腕管狭窄，都可引起腕管综合征。

临床表现

最先出现手指麻木，多限于桡侧三个手指，可向肘肩部放射，尤以夜间为重，影响睡眠。连续挥动患手或将患侧腕关节处于轻度弯曲位时，症状可减轻或缓解，桡侧三指远端皮肤刺痛觉减退或消失，但腕部以上感觉无任何改变。

检查时，轻叩腕管部位正中神经（内关穴处）时，患者正中神经分布之手指有放射性触电样刺痛感，腕关节掌屈90°角。40秒钟后可见症状加剧。一般除麻木、刺痛外，到天冷时常见患指发冷、发绀，活动不利。严重者，拇指外展肌力差。病程长者，可见鱼际肌萎缩。

腕管综合征属于祖国医学的“筋痹”范畴。中医认为本病的主因多为寒湿浸淫、风邪侵袭，血淤经络，气血流通受阻。或肝阳上亢，久则内耗肝血肾阴。治宜通经活络，滋养肝肾。

中药治疗

方一：鲜华沸草60克（华沸草又名酸芝草、接气草、盐酸草，系酢浆草科的酢浆草）。捣烂，取汁炖服，1日2次。

方二：天麻12克，钩藤30克，生石决明30克，茯神10克，夜交藤30克，熟地30克，枸杞15克，山萸15克，当归15克。水煎服。

方三：鲜万年青根适量，加白糖捣烂敷患处，1日1次。不可内服。

方四：川椒15克，盐9克，醋适量。川椒、盐研末，醋调敷患处。

针灸治疗

常用穴：大陵、上八邪、内关、外关。

方法：以大陵为主，针尖向腕管内刺入，中强刺激，不留针。必要时加上八邪、内关或外关。针刺后，在患处用艾条熏灸10—20分钟，1日2次。

推拿治疗

本病患者如症状严重，可先用纸板固定腕部1—2周，再逐步给以推拿治疗。在治疗期间，如果改变手的劳动姿势可以解除麻木症状，即按新的劳动姿势参加劳动。

（1）按极泉法

患者仰卧，左或右上肢上举，屈肘，医生以手四指自腋下渊腋穴处向上摩动至腋部极泉穴处止，再自上臂青灵穴处向上摩动至极泉穴止，反复操作2—3分钟。然后以拇指置极泉穴处长按，其余四指置肩关节后方扶定，按压2—3分钟。摩动时，用力宜轻，按压则应逐渐加重压力，以患者能耐受为度。

（2）腕屈伸法

患者仰卧，上肢伸直，手掌向上，医生以两手拇指掌侧对置于腋窝之曲泽穴处，自上向下推动，经大陵至劳宫穴止，反复操作2—3分钟。再使患者屈肘，医生以一手拇指置肘部小海穴处，其余四指置曲池穴处按压。最后，以手握往患者手指再按压手掌，使腕部背屈数次后，继以背伸，反复操作3—5分钟。

(3) 摩指法

患者直坐，左或右手平伸，掌心向下，医生以拇指掌侧置外关穴处，自上向下指推至阳池穴止，操作1—2分钟。再使患者掌心向上，医生以拇指掌侧置内关穴处，自上向下经太陵指推至劳宫穴止，反复操作2—3分钟。最后，医生以两手拇指、食指掐定患者手指两侧，逐步自上向下摩动，自指掌关节起摩动至指端止，反复摩动2—3分钟。摩动手指两侧时，可边摩边弯曲指关节。自前臂下端向手掌或手背部推动，沿经穴位处可配合按法。

(4) 揉劳宫法

患者直坐或仰卧，左或右前臂放于桌上或床上，手掌向上，手指微屈。医生用拇指掌侧置患者腕部掌侧太陵穴处，自上向下经劳宫至指关节第一节上，指推2—3分钟，再以拇指掌侧置掌心劳宫穴处，食指置于与手心相对之外劳宫穴处。然后作顺时针及逆时针方向合揉2—3分钟。掌心揉动时，用力应比揉外劳宫为重。对恶寒发热有外感症状者，揉动时可蘸酒。

(5) 捏合谷法

(见腕关节劳损的推拿治疗，本书第131页)

80. 跖管综合征

跖管综合征是指胫后神经受压而引起足跟内侧及足底麻木等症状的一种病症。

胫后神经受压是由于跖管的相对狭窄。

跖管亦称踝管，位于踝关节内侧，是小腿后区和足底深

部蜂窝组织间隙的骨纤维形成的一条通道。它的浅面为跨于胫骨内踝和跟骨结节间的分裂韧带，深部为跟骨、距骨和关节囊。跗管内，有肌腱、血管和胫后神经通过。胫后神经在出跗管时分出支配足底和足内侧的终末支——跗内、外侧神经，前者为感觉支，后者为运动支。

足部运动之突然增加或踝关节反复扭伤，可以使跗管内肌腱因摩擦而发生腱鞘炎，腱鞘肿胀，跗管内容物体积因此增加。由于跗管为骨纤维管，缺乏伸缩性，不能随之膨胀，因而形成跗管的相对狭窄，于是管内压力增高，产生胫后神经受压症状。

临床表现

患者早期在行走、站立过久或劳累后出现内踝部不适感。休息后这种不适感可得到改善。如上述症状反复出现，持续时间长久，病人有跟骨内侧及足底麻木感，或如蚁爬痒之特殊感觉。严重者可出现足趾皮肤干燥、发亮、汗毛脱落及足部内在肌的萎缩。检查时，轻叩内踝后方，足部针刺感可加剧。足作极度背伸时，症状亦可加剧。

跗管综合征属于祖国医学之“筋痹”范畴。中医认为，风寒湿三气杂至，合而为痹，气血不畅，壅滞经络，日久而成痹证。治宜通经活络。

中药治疗

方药：木瓜30克，威灵仙12克，丹参30克，独活12克，赤芍30克，生地30克，黄芪30克，当归20克。水煎服。

针灸治疗

常用穴：飞扬、三阴交、解溪、复溜、太溪、合谷、昆仑、跟腱穴（跟腱上，内外踝尖连线上3寸）

方法：每次选2—3穴，每日针刺1次，针刺后可再施

以局部温灸。跟腱穴可行鸡足刺法。

推拿治疗

推拿治疗本病，目的在于促进炎症的吸收，降低跖管内压力。

（1）推足外侧法

患者侧卧，左或右下肢弯屈，医生以拇指置踝关节外下方之仆参穴处，其余四指置足背上以扶定左或右足，沿足外侧经金门、京骨、束骨、通谷推动至至阴穴处后，再用拇指将足小趾末节向下方按压，反复推动并按压3—5分钟。在足外侧推动，沿经穴位可配合施行点按法。

（2）内外旋踝法

患者俯卧，左或右下肢弯屈。医生用一手置跟骨处。拇指按水泉穴，食指按仆参穴，另一手握足趾，固定后分别向内或向外旋转踝关节并牵动膝关节旋动，反复操作2—5分钟。旋转时，并将跟骨及足趾握紧固定，旋转动作应和缓，逐渐增加旋转角度，忌用蛮力。

（3）按跟腱法

患者俯卧，两下肢伸直，医生用两手拇指分置小腿下方跟腱两侧，左手拇指置小腿合阳穴处向下经昆仑至仆参穴止，反复按压2—3分钟，再以两手拇指并置于承山穴处，自上向下经足跟转向足底部推动至涌泉穴止，反复操作2—3分钟。两拇指置跟腱两侧推动时，用力应均匀一致，推动沿经穴位及跟腱处均应着力，但在承山穴处着力应稍轻。

（4）揉承山法

患者俯卧，下肢伸直，医生以手拇指顶或食指背曲置小腿后正中线中部之承山穴处，指揉2—3分钟。对年老体弱者，可改指揉为掌根揉。

(5) 按水泉法

患者侧卧，左或右下肢弯屈，医生以手四指自三阴交穴起向下抚摩，经水泉至然谷穴止，反复操作2—3分钟。再用拇指置足内踝下之水泉穴处点按3—5分钟。每次点按着力应逐渐加重压力。按压后可配合施行指揉法。

81. 踝关节扭伤

踝关节扭伤是常见病、多发病。踝关节亦即距骨小腿关节，由距骨与小腿骨（胫、腓骨）下端的关节面构成。踝关节内侧有内侧副韧带（亦称胫侧副韧带或三角韧带），外侧有外侧副韧带（亦称腓侧副韧带）。由于内侧副韧带较坚韧不易断裂，而外侧副韧带较薄弱，因此外侧副韧带损伤较多见。当足骤然内翻及跖屈时，均可致外侧副韧带的中段或前段撕裂。

当踝部扭伤后，常见踝关节骤然剧痛，尤以走路或负重时最明显。检查时，外踝下方及前下方显著压痛。由于皮下组织、韧带、关节囊撕裂后毛细血管破裂，皮下出血，局部可见淤血，伤后2—3天更为明显。损伤后因局部出血、组织渗液，踝前外侧和足背部可见肿胀。又由于出血积聚于关节间隙或软组织嵌入关节内，使患者跛行，足跖不敢着地。

过去很多人认为，踝关节扭伤，可作热敷，或立即作按摩（揉搓），这样处理是不对的。这是因为：踝部急性损伤后，局部毛细血管出血，软组织的韧带撕裂，如果再作热敷或用力按摩，一方面会加重软组织损伤，另一方面由于热敷

后血液循环加快，组织内的渗透压增高，肿胀淤血会更加剧烈，对损伤的恢复是不利的。

外治法

(1) 局部立即作冷敷(可减少出血和肿胀)。

(2) 局部外敷七厘散、百宝丹(均为成药)，并加包扎。

(3) 半个月后仍无好转，可作按摩。

(4) 针刺疗法：取穴：昆仑、丘墟、夹溪、阳陵泉，平补平泻。

内治法

方药：木瓜30克，苡仁45克。水煎服。

皮 肤 科

82. 夏季皮炎

夏季皮炎发生于夏季，成人较多见。好发于四肢伸侧面，呈对称性发作，严重者可累及其他各部位。皮损先为潮红，继则发出成片细小丘疹，自感剧痒，抓之无滋水流出，可形成血痂。皮损处如经热水洗涤或搔抓，皮肤可形成轻度肥厚及色素沉着。一般无全身症状，严重者可有烦躁、胸闷、纳呆、睡眠不安、小便短赤等。夏季皮炎至秋凉后自行消失，皮损处不留任何痕迹。

夏季皮炎属于祖国医学的“血热”、“暑湿”范畴。治宜清暑化湿。

内治方

方一：青蒿^{15克}（后下），藿香^{12克}，佩兰^{12克}，地骨皮^{30克}，大青叶^{30克}，蒲公英^{30克}，黄柏^{10克}，苦参^{15克}，苡仁^{30克}，六一散^{10克}。水煎服。

方二：大黄^{10克}，黄芩^{10克}，黄柏^{10克}，苍术^{10克}，苡仁^{30克}。水煎服。

外治方

方一：大黄、黄芩、黄柏、苦参各等分，共研细末。用

上药10—15克，加蒸馏水100毫升，医用石炭酸1毫升，用时摇匀，以棉花蘸药汁搽患处，一日4—5次。

方二：绿豆50克，樟脑18克，氧化锌5克，滑石粉100克。将绿豆、氧化锌、滑石粉研细后，再加入樟脑，研匀即成。用时将药粉干扑患处，一日3—5次。

83. 念珠菌性甲沟炎

念珠菌性甲沟炎属于霉菌感染。致病的主要是白色念珠菌。念珠菌在人体内皆有，一般不致病。但当机体抵抗力下降，或患有糖尿病、肿瘤以及大量使用广谱抗菌素、激素及免疫抑制剂时，使体内菌群失调，念珠菌大量繁殖而引起疾病。

念珠菌性甲沟炎多见于指甲。甲沟部红肿疼痛，颇似化脓感染，但少有脓液排出。甲皱襞皮肤变薄，有光泽，指甲变硬增厚，呈褐色，有横的波浪状沟纹，但仍保持光泽。本病发病缓慢，病程长，易复发。多发于成人。经常与糖及水接触者、罐头制造者、厨师、家庭主妇等易患本病。由病灶取样直接镜检，可确诊。

念珠菌甲沟炎属于祖国医学的“代指”、“代甲”、“蛇眼疔”、“指甲疳”等范畴。治宜清热解毒。

方药：紫草30克，黄精30克，大黄10克，百部10克，贯众15克，千里光30克。水煎服。并外搽大蒜汁。

另可用刮胡刀片或薄玻片，刮薄患指指甲，再用重庆市中医研究所生产的黄马酒或消毒用碘酒，浸涂患病指甲，日数次，疗效较佳。

患者的饮食应富于营养并容易消化，如已使用大量抗菌素和激素时，应停用，用中药代替。患有糖尿病等全身疾病者，要进行相应的治疗，以增强抗病能力。局部应避免用肥皂和热水洗浴，保持干燥。还可煎一枝黄花30克、凤仙花15克，煎水，放冷后洗患处，洗后擦干。

84. 糜烂性包皮龟头炎

糜烂性包皮龟头炎系龟头、包皮内面及冠状沟处发生的糜烂渗出性炎症。由包皮垢杆菌或奋森氏螺旋体或梭形杆菌感染所致。包皮过长或包口过小、包皮垢及尿液等的刺激均易引起发病。

症状：阴茎头部、冠状沟及包皮内叶潮红、肿胀、糜烂有渗液。如感染严重时可形成浅在性溃疡，类似软下疳，包皮肿胀明显，形成炎性包茎，如强行将包皮翻起，有时可形成包皮嵌顿现象。患者自觉龟头、包皮瘙痒或剧烈疼痛。

慢性龟头炎有环状红斑样损害，表面有少量渗液。

全身症状表现为疲劳、乏力、低热、纳呆、口干、大便干、腹股沟淋巴结肿大等。局部症状尚有排尿疼痛，包皮不能反转。

糜烂性包皮龟头炎属于祖国医学的“袖口疳”、“腺疳”、“下疳”、“蛙疳”、“蜡烛笑”、“瘰疬”等范畴。《外科启玄》说：“此疳是龟头及茎上有疮，肿焮于内，而外则皮裹不见其疮。如袖口之包手，故名之”。“玉茎有疮，痒且痛，赤燥燥有水，盖因交媾不洗，肝经有湿热所致”。《外科证治全书》说：“下疳一证，属肝、肾、督

三经之病，分下疳（生马口下），蛀疳（生玉茎上），袖口疳（茎上生疮外皮肿胀包裹），蜡烛笑（疳久偏溃），鸡脰疳（痛引睾丸，阴囊重坠），瘙疳（痛而痒，溃而不深，形如烂杏）”。其病因、病机为湿热下注，蕴久成毒。治宜清热利湿，佐以解毒。

内治法

方药：龙胆草15克，当归15克，山栀12克，黄芩15克，车前草30克，泽泻30克，生地15克，柴胡12克，银花30克，连翘30克，丹皮12克。水煎服。

外治法

方一：马齿苋60克。煎水外洗。每日1次。洗后敷药。

方二：生大黄粉30克，黄芩粉30克，寒水石粉30克，青黛8克，甘草粉10克。植物油调敷患处。

方三：生肌散（成药）或七厘散（成药）植物油调敷患处（此方适用于已形成溃疡者）。

85. 鳞状毛囊角化症

鳞状毛囊角化症的发病原因尚不明瞭。皮肤损害特点为皮肤出现灰白色至褐色圆形小鳞屑斑，鳞屑中央有与毛孔一致的黑色小点。

鳞状毛囊角化症多见于青年，无自觉症状，冬重夏轻，发病缓慢，可有家族史，多对称发生于胸、腹、腰、臀及大腿外侧等处。

皮疹有小指甲盖大小和孤立散在周围游离，可伴有浅色晕。除去鳞屑，可见嵌塞于毛囊的角质栓及卷曲的毳毛；不

久又可由此再生出新的同样鳞屑斑。

中医认为本症的病因病机的血虚风燥，湿热内蕴。血虚不能营养肌肤，肤失濡润，腠理不密。风燥逗留肌肤引起皮肤脱屑。治宜养血滋阴润燥。

方药：制首乌30克，当归30克，白芍30克，熟地20克，山药30克，川芎6克，桑椹30克，苡仁30克，生地20克，天冬15克，麦冬15克。水煎服。

86. 毛发红糠疹

毛发红糠疹属于角化性皮肤病。皮损好发于躯干、四肢伸面和手指背等处。

丘疹为粟粒大小，坚硬，淡红或浅红褐色，有毳毛贯穿。丘疹表面被覆细小鳞屑，剥除后可见毛囊口角栓嵌入，基底浸润发红。皮疹继续增多后可相互融合。头部、耳、颈等处往往有鳞屑性红斑。严重者可波及全身甚至形成红皮病样，自觉瘙痒。

患处皮肤干燥，易发生皲裂，可伴有掌跖角化过度和指甲（趾甲）改变。

中医无毛发红糠疹的病名，根据其临床表现属“血热风燥”。治宜清热解毒，滋阴润燥。

方一：银花30克，当归30克，桑椹30克，熟地15克，桃仁10克，首乌15克，白藓皮30克，生地30克，火麻仁12克。水煎服。

方二：生苍术30克，枸杞30克，珍珠母30克，鸡内金15克，生甘草10克。水煎服。

87. 利尔黑变病

本病系一种多因子影响的色素沉着病。临床特点为皮肤出现瘙痒、发红、脱屑及点状棕色沉着，多见于前额、颊部及颈侧。

利尔黑变病的病因尚不明瞭，可能与营养不良，维生素A、C、B族缺乏，长期外用含有光感性物质的化妆品有关，加之日光照射而诱发本病。亦有认为与血清铜含量高有关。

患者有长期与石油类或润滑油等接触史。开始皮肤发痒，局部发红，以后逐渐变为淡褐色至深褐色色素斑，边缘境界不清，周围常有围绕毛囊口的点状色素斑。有的尚可见毛细管扩张、毛囊角化及鳞屑等，可融合成大片。

好发部位主要为颜面及颈部，尤以前额、两耳周围及两侧面颊周围常见，亦可见于两手、前臂、腹部、大腿及其他暴露部位。

利尔黑变病常伴有缓脉、头痛、食欲减退、消瘦、全身衰弱等。患处开始自觉瘙痒，病情发展至一定程度时，即无自觉瘙痒感。

本病女性较多，病程缓慢。

利尔黑变病属于祖国医学的“黧黑黧黯”范畴。中医认为本病系脾虚不能化生精微，气血亏虚，肌肤失养，或因肾水亏不能制火。久则燥结而致病。

辨证分型治疗

() 肾虚血淤型：面色黧黑，形体虚弱，腰酸腿软，神疲乏力，舌红少苔，脉细。治宜活血化淤，补益肾阴。

方药：桃仁10克，红花10克，当归30克，熟地20克，川芎10克，赤芍15克，山萸10克，山药30克，丹皮10克，茯苓10克，泽泻30克。水煎服。

（2）肝郁血淤型：面色黧黑，胸胁胀闷，眩晕肢麻，月经不调，痛经，舌紫暗，苔薄白，脉弦。活宜活血化淤，疏肝理气。

方药：白芍30克，当归30克，柴胡15克，白术15克，茯苓15克，桃仁10克，红花10克，熟地30克，川芎10克，赤芍15克。水煎服。

（3）阳虚血淤型：面色黧黑，呈网状，形寒怕冷，手足不温，乏力，腰膝酸软，舌淡胖，脉沉。治宜活血化淤，温阳通脉。

方药：附片20克（先熬），肉桂6克，熟地30克，当归20克，赤芍20克，川芎10克，桃仁10克，红花10克，山药30克，山萸12克，茯苓15克，丹皮10克，泽泻30克。水煎服。

加减：血淤重者加莪术、土鳖虫；血热者加玄参、丹参；气虚者加党参、黄芪；肾虚明显者加仙灵脾。有明显接触焦油类史者加土茯苓（本加减法用于以上三型）。

外治方

（1）生白术40克，陈醋250毫升，泡7天后，局部涂搽，每日2次。

（2）白薇、白芷、白蔹、白僵蚕、白附子、白鲜皮、白扁豆各15克，水煎洗局部，每日1剂。

（3）耳压法：取穴肺、皮质下、内分泌、肾上腺、额。每周换2次。

88. 足 口 病

足口病是由于食用被病毒（柯萨奇A组病毒）污染的牛奶、奶油、乳酪等食品（或接触患病动物，通过皮肤破伤）而传染的病毒性皮肤病。足口病在人与人之间一般不易互相传染。

足口病多发于农民、兽医及牧民。好发于口、唇、颊、咽及舌缘、齿龈，其次为鼻腔粘膜、眼结膜及手掌、足趾。

皮疹多为米粒大小水泡，内容清亮或混浊，继之成脓疱或融合成大疱，疱易破裂形成浅表性溃疡，附近淋巴结肿大。

足口病的潜伏期为2—10天，开始往往有发热、流涎、口腔粘膜充血、食欲减退、全身不适。小儿症状较严重。皮疹出现后，全身症状即减轻或消退。

本病一般1—4周可自愈，预后良好。

足口病属于祖国医学的“湿温”范畴。治宜清热解毒。

方药：连翘30克，黄芩15克，黄连10克，黄柏12克，栀子12克，人工牛黄8克（冲服），银花15克，板蓝根30克，苍术12克。水煎服。并用此药汤漱口。

足部皮损亦可用上方药熬水浸洗（每天1次，浸洗30分钟）。

患者应卧床休息，多饮水，保持口腔清洁，进食易消化的食物。

89. 松 毛 虫 病

松毛虫病是松毛虫引起的一种变态反应性疾病。松毛虫

是寄生在松树上的毛虫，身上有毒毛，它爬过的地方或物品上可以沾上毒毛。松毛虫在脱壳后，茧壳上带有很多毒毛，茧壳随风飘扬，除污染松树下的地面外，还可以污染一定距离的环境。当人们上山砍柴、采果、采矿、游玩时可沾染毒毛而发病。

松毛虫之毒毛能引起过敏性皮炎、耳廓炎、眼炎、关节炎等。

在松毛虫严重流行区，松毛虫脱壳后，毒毛随风飘扬，除沾染人体皮肤外，还可通过呼吸进入人的体内。毒毛飘入水田，漂浮在水面被泥鳅吃入，人再吃这种泥鳅，也可以发生松毛虫病（变态反应性疾病）。

松毛虫病的流行期，在每年的10月份至次年3月份。

临床表现

全身症状较轻，主要为低热、乏力和食欲不振等，而局部症状明显。大部分病例10—15天可痊愈，但损伤骨、软骨、关节者可迁延数月乃至数年之久。

（1）急性期：关节明显疼痛、肿胀。关节呈突然针刺样跳痛，持续或阵发性加剧。尤以午后和夜间为重，彻夜难眠，随之发生关节周围软组织肿胀，以及出现皮疹、斑丘疹、风团、瘙痒等皮炎，7—10天内达高峰。部分患者的皮肤皱纹消失，呈紫红色，发亮，有波动感，关节腔穿刺有渗出液，并出现局部功能障碍。

（2）慢性期：部分患者久治不愈，从急性转为慢性，关节仍疼痛，持续肿胀，功能障碍，变形或强直。

中药内治法

（1）急性期：银花30克，连翘15克，车前草30克，赤芍30克，丹皮12克，紫花地丁12克，蒲公英30克，皂刺10克，野菊花20克。

水煎服。

(2) 慢性期：羌活12克，独活12克，丹参30克，车前草30克，白花蛇舌草30克，半枝莲30克，黄芪30克，续断30克，威灵仙12克，秦艽15克，当归30克，川芎12克，苍术15克，川牛膝30克，黄柏12克，苡仁30克。水煎服。

中药外治法

(1) 急性期：

方一：公丁香30克，薄荷脑5克，95%乙醇750毫升。

用法：先将公丁香研碎，加入750毫升乙醇中，浸泡3天或3天以上，时常搅动，以药汁浸出为宜，然后用纱布过滤取渣，再加入薄荷脑，装瓶密封备用。用时，先将患处用橡皮胶布粘去刺入皮肤的毒毛，然后搽此药液。每天2—3次。

方二：紫花地丁适量，捣烂外敷患处，或用蜈蚣、白芷各等份，研成细末，用鸡蛋清调敷患处。

(2) 慢性期：威灵仙30克，川断60克，苍术30克，玄胡30克，熬水熏洗患处（关节疼痛处）。

护理

(1) 急性期：解除思想顾虑，树立战胜疾病的信心。用肥皂水清洗患处，不要用手搔抓，以防破溃，并用中药外敷患处。抬高肿胀患肢，以减轻疼痛。

(2) 慢性期：定时进行患肢关节的功能锻炼，以改善血液循环，有助于消肿、散淤、松解粘连，防止肌肉萎缩，防止关节强直。功能锻炼以屈伸、旋转为主，循序渐进，不要用力过猛。

90. 肛门瘙痒症

肛门周围皮肤顽固瘙痒，经久不愈，称为肛门瘙痒症，为一种常见的局限性瘙痒病。肛门瘙痒症可有下列因素引起：

（1）过敏反应：食用刺激性食物，如辣椒、芥菜、香料、烟、酒或特异蛋白质食物等。此外，使用某些药物，如吗啡、奎宁、砒剂、磺胺类、抗菌素、麻醉药等均可引起肛门瘙痒。

（2）疾病因素：慢性消化不良，糖尿病，血液病，风湿病，更年期综合征，黄疸，尿毒症，内分泌障碍，荨麻疹，梅毒，阴道霉菌感染，滴虫病等均可引起肛门瘙痒。

（3）精神因素：如神经衰弱，癔病，精神过度紧张，兴奋，激动等均可引起肛门瘙痒。

（4）遗传因素：对知觉异常敏感的人，有家族遗传史，60%左右均有肛门瘙痒。

（5）刺激性因素：肛门潮湿和分泌物刺激，是常见的致病因素。如肛痿、内外痔、肛裂、肛窦炎、肛乳头炎，肛门松弛，使分泌物增加，粘液外溢。妇女阴道分泌物过多，肛周皮肤汗腺和皮脂腺分泌物刺激，粪渣，粪臭素，化学药物的刺激均可引起肛门瘙痒。此外，体胖臀裂深，老年皮肤萎缩退化，或因干燥、气候寒冷、温度变化，或肥皂及便纸太硬等刺激，也易引起肛门瘙痒。

（6）寄生虫如蛲虫、阴虱、蛔虫、疥疮都可引起肛门瘙痒。

(7) 皮肤病如湿疹、癣、湿疮、毛囊炎、皮炎、神经性皮炎等，也可引起肛门瘙痒。

本病以肛门周围顽固性发痒为主要症状，时轻时重，间歇或持续性发痒。用于搔抓后灼痛更加剧烈。有时刺痛，或有时如虫咬、虫爬，有时有烧灼、蚁走等感觉，夜间更甚，影响睡眠。局部有抓痕，常有出血、糜烂、裂口、渗液、结痂等继发性损害，患处皮肤变厚，皱襞肥大，久病后皮肤发生苔藓样变化，色素沉着或色素减退。

肛门瘙痒症属于祖国医学的“痒风”的范畴。中医认为痒属风、湿、热、虫、血虚所致，又有“诸痒属虚、属风，热盛则痛，热微则痒”之说。肛门瘙痒症，乃血虚生风，风胜挟湿，湿热阻滞及虫淫骚扰肛门皮肤所致。治疗宜养血润燥，清热利湿，祛风杀虫。

内治法

(1) 血虚生风：肛门局部瘙痒，伴面色苍白，眩晕，心悸，手足蠕动等全身症状。治宜补血滋阴，润燥祛风。

方药：生地30克，玄参20克，麦冬20克，赤芍30克，丹皮10克，首乌30克，知母12克，合欢皮15克，白藓皮30克，蝉蜕6克。水煎服。

(2) 湿热阻滞：肛门瘙痒，伴午后身热，身重胸闷，疲乏无力，头昏，不思饮食，小便不利等全身症状。治宜清热祛湿。

方药：龙胆草10克，木通10克，泽泻30克，柴胡10克，车前草30克，生地30克，当归10克，炒山栀10克，紫花地丁30克，黄柏10克。水煎服。

外治法

苦参30克，苍耳子15克，蛇床子30克，威灵仙30克，冰片1克

（后下）。水煎，先熏后洗。

针刺疗法

取穴：长强，腰俞，承山，三阴交，阴陵泉、血海、太冲。

手法：强刺激，每天1次。

预防

（1）去除病因，特别要注意病人有无内脏及局部疾病，如有其他疾病，应予及早治疗。

（2）忌食刺激性和过敏性食物和药物，如酒、浓茶、辣椒、咸鱼等。药物过敏者应立即停药。

（3）避免局部刺激，避免搔抓，对衣物过敏者应予更换，不用碱性太强的药物洗涤患部。

（4）保持局部清洁卫生，大便后用温水浴洗肛门。

91. 肛门疣状皮肤结核

肛门疣状皮肤结核，是由于肛门疣状皮肤破损后感染结核杆菌而发生的增生性疣状病损，为局限性皮肤结核病的一种。此外，当病人内脏器官或深部组织（如肺、肠、淋巴结、骨等）有结核病灶时，结核菌可通过血液循环、淋巴系统而感染。

本病初起时，肛门处有硬性暗红色小结节，数目不定，发展缓慢，以后逐渐长大，角层增厚、有鳞屑或痂皮覆盖，并彼此融合，构成乳头状或疣状病损。疣状增生间可见裂隙，有脓汁，病损四周有炎性晕，有痒感，一般无痛感。损害中央可自行消退，留有光滑萎缩性疤痕。病程迁延，可数年

不愈，常伴有腹股沟淋巴结核。

祖国医学认为本病为肝气郁结，久而化火，下灼肾阴，煎熬津液所致。治宜养阴散结。

方药：当归30克，熟地20克，山萸12克，山药30克，丹皮12克，茯苓15克，泽泻15克，浙贝12克，玄参20克，鳖甲30克，夏枯草30克。水煎服。

92. 肛门扁平湿疣

肛门扁平湿疣是肛门直肠梅毒第二期损害。患者有梅毒病史。

肛门扁平湿疣生在肛管内或肛门周围皮肤上，呈扁平突起，有时丛生。初起在皮肤上生一圆形白色斑点，渐次增生长大，蔓延并围绕肛门，甚至可蔓延到阴唇或阴囊。突起扁平，底宽，常盖有灰色坏死薄膜，分泌物有臭味，表面常形成溃疡。先在肛门一侧，以后蔓延到对侧。病人感觉肛门部潮湿，瘙痒，有时刺痛。

血液检查。有阳性梅毒反应。

肛门扁平湿疣是肛门直肠性病的一种，主要是通过性交感染梅毒螺旋体所致，属于二期早发梅毒。

肛门扁平湿疣属于祖国医学的“阴蚀疮”、“结毒”等范畴。是由于与有梅毒之妇女交接，感触淫毒所致。《疮疡经验全书》说：“阴蚀疮之生，皆由脏中虚怯，肾气衰少，风邪入腑，毒恶损伤荣卫。或与有毒妇人交接，不曾洗净，故时痛时痒，……若不早治，命亦难保”。

肛门扁平湿疣的治疗，与肛门部下疳的治疗相同。请参

93. 胼 胝

胼胝是局部皮肤（特别是脚底部、手掌的皮肤）经受长期机械性摩擦与挤压所致的片状角质增生，系机体对刺激的保护性反应。常与职业有关，多见于体力劳动者（成人）。好发于手掌、足跖易受压迫或摩擦的部位，为淡黄色较厚而坚硬的角质增生斑块，中央较厚，边缘不清，表面光滑，表面皮纹清晰，局部感觉迟钝，有轻度压痛。

中医亦称胼胝，其治疗，多采用外治法。

方一：红花40克，地骨皮40克，甘油100克。

用法：先将红花、地骨皮研成细末，加入适量甘油搅拌均匀。备用。用时将药涂于患处，每天2次，涂后用消毒纱布包扎。涂药前用温开水浸洗患处半小时，擦干，然后涂药。

方二：乌梅30克，醋15毫升。

用法：将乌梅浸于20%的100毫升盐水中，24小时后取出，去核取肉，加醋15毫升，共放于乳钵中研烂成膏状即得。用时，先将患处洗净消毒，以消毒之割刀将过厚之角质层削薄，然后敷上乌梅药膏，用绷带缚紧，每日换药1次。连续用2—4次。

94. 鸡 眼

鸡眼系局部长期受挤压或摩擦而致之角质增生。穿着紧

窄的鞋靴，长期行路或足部畸形者易于发生。

鸡眼为淡黄色圆锥形角质栓，尖端楔入皮内，境界明显，状如鸡眼，好发于跖部及趾侧，行走或站立过久。因尖端压迫真皮内末梢神经，疼痛异常。

鸡眼，中医称为“肉刺”，亦称鸡眼。多采用外治法治疗。

方一：患处用75%酒精消毒，将经过酒精灯烧红的三棱针对准鸡眼角质层由浅入深逐渐进行烧灼，使其成为焦痂，鸡眼的根部即角质栓的尖端要另行刺入烧灼一次。烧灼后局部再用酒精消毒一次。然后盖上消毒纱布并以胶布固定。如一次治疗未能痊愈，可间隔3—5天再用同法治疗1至数次。治疗当天，患部不能用水浸洗。

方二：半夏茎。

用法：将半夏茎晒干粉碎备用。先将鸡眼在温水中泡软，削去角化组织，放上生半夏粉，并用胶布贴上，过6天鸡眼即脱落。未脱落者可继续敷药。

方三：干蜈蚣30条，乌梅9克，菜油或香油适量。

用法：将蜈蚣、乌梅焙干，共研细末，装入瓶内，再加入菜油（以油浸过药面为度），浸泡7—10天后，即可使用。用时先将1%盐水浸泡患部15—25分钟，待粗皮软化后，剪除粗皮（以见血丝为度），再取适量药膏调匀，外敷患处，用纱布包扎，每12小时换药1次。

方四：患者俯卧，头朝右侧，在患侧腓窝及胫窝上2—3寸范围内选择显露于皮肤下面的红色或紫红色血管2—3处作为放血点，局部消毒后，右手持一3分长消毒好的毫针，以45°角顺血管向下刺入血管内，迅速出针。当血液流出象火柴头样大小时，即用消毒棉球拭干并压迫止血（不出血者

可挤压出血)。依次放血，每隔 7—10 天放血 1 次。

方五：蓖麻子 1 粒。

用法：用火烧其外壳出油，直接按在泡软的鸡眼上，外用胶布固定。

注：适用于较小的鸡眼。

方六：紫皮大蒜一个，葱头一个。

用法：把大蒜和生葱捣成泥状，再加入食醋调匀（必须随用随配制）。用药前，先在患处作常规消毒，用利刀割除鸡眼表面粗糙角质层，以不出血或刚出血为度。接着用盐水（温开水 200 毫升加食盐 5 克）浸泡 20 分钟，使真皮软化，以便发挥药物的作用。然后用布抹干，取葱蒜泥塞满切口，用消毒纱布、绷带和胶布包好即可。每天或隔天换药 1 次。

方七：五倍子、生石灰、石龙芮、樟脑、轻粉、血竭各等量。

用法：上药共研成极细粉末，用重两倍的凡士林调匀（可加温）成软膏即成。用时先用热水洗患部，待鸡眼外皮变软后，用刀片仔细刮去鸡眼角质层，贴上剪有中心孔的胶布（露出鸡眼），敷上此药，再用另一块胶布贴在上面。每天换药 1 次。

95. 瘢痕疙瘩

瘢痕疙瘩是纤维组织的过度生长，多续发于外伤、烧伤或手术后的瘢痕上（继发性）。也有突然发生于正常皮肤上，或由未被察觉的轻微擦伤，经搔抓而促成，称为特发性瘢痕疙瘩。

癰痕疙瘩成堅硬的扁平隆起，表面平滑，不与皮下組織粘連。顏色淡紅或黃紅。可隨搔抓及各種機械性刺激而擴大，表面常有毛細血管擴張或樹枝狀增生，患部少毛髮。自覺有癢感。

癰痕疙瘩好發於胸前，亦可發於背部、肩胛及四肢。由瘰癧或疔瘡繼發的限於毛囊口，而繼發於火傷的往往面積甚大，形狀不等，可呈條狀、橋狀。發於顏面者可因挛縮而影響容貌。發於關節者可影響關節功能。

癰痕疙瘩屬於祖國醫學的“肉龜瘡”範疇。多由先天因素或由金刀所傷，或由水火燙傷，余毒未淨，復受外邪入侵肌膚，致使濕熱搏結，氣血凝滯而成。治宜活血理氣，軟堅散結。

內治法

方藥：大黃廬蟲丸（成藥）每次服10克，每日服3次。

外治法

方一：鴉胆子適量。

用法：將鴉胆子除去殼皮，置乳鉢中研碎成泥狀，然後加入70—80%凡士林攪拌均勻（無需加熱），制成軟膏，放置48小時後即可塗用。敷藥膏時，先將患處皮膚消毒，後將膏藥塗於患處範圍之內（不要觸及正常皮膚），敷蓋消毒紗布，約經48小時後可第一次換藥，以後每隔2—4天換藥1次。

方二：蜈蚣10條，蜂蜜180克，五倍子900克，黑醋2500克，研磨，外敷患處。敷時避免接觸金屬用具。

五官科

93. 突发性耳聋

突发性耳聋是听力突然严重下降。其发病原因多与内耳血管功能障碍及病毒感染有关。多发生于中年人，女性偏高。发病前无明显预兆，多发生于晨间，也可发生于睡眠中。少数病人则发生于轻、中、重度感冒，过度疲劳或情绪激动之后。发病多为单耳，罕为双侧。常伴有低音调耳鸣。部分病人有复听或耳内阻塞、胀满感。

祖国医学认为“暴聋多实”。以实证临床多见，但虚证或虚实夹杂者亦不乏其例。大致有以下几种：

（1）六淫侵袭，阻遏少阳：少阳之脉从耳后入耳中出耳前。若六淫邪毒侵袭机体，正气素虚，驱邪不力，以致邪伏不去，留淫少阳，循经犯耳，壅遏耳脉，正气不充于耳而突发卒聋。

（2）情志失调，肝郁化火：肝主疏泄，调畅情志，若愤怒忧郁等致肝失疏泄，气机不畅，气闭耳窍。或肝气郁结，气郁化火，肝火上炎，壅闭耳窍，听神失聪而暴聋。

（3）气血淤滞，耳脉受阻：六淫侵袭留滞，或肝气郁结，正气虚弱，行血无力等因素均可产生淤血。淤血既成，

阻滞耳脉，使耳窍闭塞不通而卒聋。

（4）劳倦过度，心脾虚损：心主神，忧愁思虑则伤心。脾主肌肉，劳倦过度则伤脾。心脾损伤，气血不足，清阳不升，阴血不达，则耳窍失濡，听神失聪而卒聋。

（5）阴精亏损，虚火上炎：本病以中年人为多见。中年人肾气渐衰，或素体阴虚，房劳过度，耗伤肾精，以致耳失濡养。加之阴虚阳亢，虚火上炎，闭塞耳窍而致暴聋。

中医治疗突发性耳聋，宜清解少阳，清火开闭，通络开窍，升清聪耳，补益开窍。

辨证分型治疗

（1）六淫遏阻：突然耳聋，伴耳鸣，耳内闷胀。发病前有外感病史，头昏头痛，口苦咽干。舌淡红，苔薄黄，脉弦数。治宜清解少阳，导滞通窍。

方药：柴胡30克，葛根30克，连翘30克，当归15克，水蛭8克，党参30克，川芎10克，甘草10克。水煎服。

（2）肝郁化火：突然耳聋，耳鸣头痛或有眩晕，心烦易怒，胸胁闷胀，口苦咽干，便干尿赤，舌红苔黄，脉弦数。治宜疏肝解郁，清火开闭。

方药：香附15克，川芎15克，柴胡20克，龙胆草10克，黄芩30克，葛根30克，木香10克。水煎服。

（3）气血淤滞，耳脉受阻：卒然耳聋、耳鸣，头痛失眠，耳内闷胀或有刺痛，舌暗有淤点，舌下青筋暴涨，脉涩。治宜活血化淤，通络开窍。

方药：丹参30克，鸡血藤30克，当归30克，葛根30克，川芎15克，桃仁10克，红花10克，葱白3根。水煎服。

（4）心脾两虚：耳聋突然发作于夜间或清晨，耳鸣细尖，发病每与疲劳过度有关。心悸，健忘，失眠多梦，倦怠

乏力，纳差便溏。舌淡苔白，脉细弱。治宜补益心脾。

方药：磁石30克，菖蒲30克，葛根30克。水煎送服归脾丸（成药）。

（5）阴精亏损，虚火上炎：突发耳聋，耳鸣如蝉，眩晕，腰膝酸软，健忘神疲，口舌干燥，五心烦热，颧红潮热。舌红少苔，脉细数。治宜滋补肝肾。

方药：熟地30克，枸杞15克，山药30克，山萸15克，茯苓12克，丹皮12克，泽泻30克，当归30克，知母12克，黄柏12克，菖蒲30克，远志10克。水煎服。

专方专药治疗

方一：葛根60克，赤芍30克，白芍30克，丹参30克，当归30克，黄芪60克，党参30克，磁石45克，桂枝15克，甘草10克。水煎服。

加减：有心血管病变者加酸枣仁、龙胆草。五官科检查时发现鼓膜明显充血，或疑有内耳出血者加生地、茅根、茜草。脾胃虚弱者加白术、茯苓、白蔻。肾虚腰膝酸软者加山药、补骨脂、淮牛膝、黄精、枸杞。

方二：石菖蒲50克，连翘12克，牛蒡子12克，苍耳子12克，藿香10克，菊花10克，川芎6克，辛夷6克，薄荷6克，防风6克，甘草6克。水煎服。

注：石菖蒲为治耳聋之要药，唯剂量宜大，犹如紧闭之门，非猛力难以开启。当然，不宜久用，中病即止。

总的说来，突发性耳聋宜早治，不可拖延，每日服药1剂，连服7—12天后，听力可获提高。中药对解除病变区的血管痉挛，促进末梢血管扩张，增加微循环活力，改善局部神经营养，促进听力之提高，有较好疗效。

针刺治疗

（1）体针：取穴耳门、听宫、听会、风池、翳风、下

关、外关、太冲，平补平泻，每天3—5穴交替使用。

(2) 耳压法：取穴耳、肾、皮质下、内分泌、神门、交感、心。

97. 夜盲症

夜盲症俗称“鸡摸眼”、“鸡盲眼”。这种病是由于人体内缺乏维生素A引起的。得这种病的人，一到晚上就看不清东西了，白天在较暗的地方也看不清东西，在光线亮的地方可以看得清。夜盲症如果不加以治疗，严重时会引起失明。因此要积极治疗，不能大意。

夜盲症属于祖国医学的“雀目”、“雀目内障”范畴。中医认为雀目分先天后天两种，先天者称“高风雀目”，多由肾阳不足，脾失健运所致；后天者多属“肝虚雀目”，由脾失健运引起，治宜温补肾阳，健脾益气。

方一：苍术15克。水煎服。连服3—5日。

方二：石决明10克，车前子10克，苍术(盐水拌，晒干)10克，草决明(炒)12克，猪肝18克(不落水)。

用法：将上药共研细末，把猪肝切一条缝，纳入上药，用线扎住，放入锅内煮熟。令患者两目乘热熏之，然后服下。

方三：谷精珠15克，钩藤15克，石决明12克，小茴香12克，蒙黄片12克。羊肝或猪肝12克(不落水)。

用法：上药用水煎服，每日1剂。儿童用量酌减。

方四：羊肝300克，猪肝300克，牛肝250克，鸡肝60克，鸭肝30克，鸡内金15克。

用法：先将上述五种肝脏蒸熟，然后烘干共研细末，鸡内金也研成细末，加入红糖、芝麻适量。每次服 10—15 克，饭前服。服药期忌萝卜、忌茶叶。

夜盲症除服药治疗外，平时宜多吃菠菜、胡萝卜、猪肝、羊肝、牛肝等富含维生素 A 的食物。

菠菜中含维生素 A、B、C、K 等物质以及其他营养物质，是明目的理想食物，还有促进消化、提高食欲、预防大便干燥等治疗作用。

菠菜营养虽好，但软骨病患儿却不宜吃，因为菠菜中含有草酸。草酸在人体内遇到钙时，极易结合成一种不易溶解的物质——草酸钙。

吃菠菜最好凉拌，不要喝菠菜的汤，草酸大部分溶解在汤里面。

胡萝卜能防治夜盲症及视力减退等疾病。胡萝卜中含的胡萝卜素，比任何蔬菜都高，但是，胡萝卜素仅仅是维生素 A 的半成品，很难被人体直接吸收，这就必须食用得法。

胡萝卜素是脂溶性物质，只能溶解在油脂中，在水中不溶解。人摄入胡萝卜素后，在人体肠壁、肝脏中所含的胡萝卜素酶的作用下转变为维生素 A，才能被人体吸收。因此，吃胡萝卜一定要用油炒，或与猪肉同炒，不能用清水煮。如果生吃胡萝卜，90% 的胡萝卜素不能被人体吸收，是一种浪费。

吃胡萝卜不能放醋，因为胡萝卜素容易被酸性物质破坏。

猪肝、羊肝、牛肝都富含维生素 A，夜盲症患者可常吃动物肝。

另外有一点须注意，过多地吃茼蒿菜，会引起夜盲症，

过食莴苣菜所造成的夜盲症，并非缺乏维生素A，而是一种中毒反应，因此吃莴苣菜时要适可而止。

98. 色 盲

色盲，又称色觉障碍，由于锥体内感光色素异常或不全所出现的色觉紊乱。先天性色盲则系隐性遗传性眼病。

色盲患者对红绿色辨识不清，用《色盲检查图》进行检查，图中88可看成99，602可看成98，或辨识不清，动物“羊”识为“鸡”。

色盲属于祖国医学“视物易色”范畴。中医认为色盲系禀赋不充。肾之精为瞳子，肝之精为黑眼，肝肾阴亏或眼内脉络阻滞，以致肝肾之精不能上升，故而两目昏朦不辨。

《内经》说：肝虚则目眊，无所见。治宜补肝肾，通经络，调气血。

中药治疗

方药：蔓荆子15克，熟地30克，荆芥穗10克，菊花60克，白蒺藜20克，羌活6克，升麻6克，葛根30克，细辛15—30克（后下），黄柏10克，巴戟天20克，肉苁蓉20克，辛夷20克，夜明砂30克（包煎），蜜蒙花12克，茺蔚子20克，五灵脂12克，元参30克。水煎服。隔日1剂，连服60—80天。

本方须重用细辛，以通巅顶。据《辽宁中医杂志》1986年7期报道，细辛由30克增至90克，每15剂递增20克，疗效满意。

针灸治疗

（1）取穴：I组：风池、攒竹、太阳、足三里。II组：

四白、合谷、光明、丝竹空。Ⅱ组：鱼腰、承泣、太溪、三阴交。依次轮流取一组穴位，均用平补平泻手法，留针 20—30 分钟。开始时每日 1 次，10 次为一疗程。连续针治 2 个疗程后改为隔日针治 1 次。

(2) 取穴睛明、攒竹、丝竹空、听宫、臂臑、合谷、风池、光明、肝俞、脾俞、肾俞等穴，每次选 4—6 穴，平补平泻手法，加艾条温热灸，留针 20 分钟，出针后施推拿手法，先用拇指推法（“一指禅”推法）及抹法施于眶周穴位和头额、两侧太阳，接着用点按法施于背部俞穴，后用双手拇指推法（“蝴蝶双飞”法）和拿、搓法施于风池穴及颈项、肩背部。每天 1 次，12 天为 1 疗程。

99. 眶上神经痛

眶上神经痛为眼科疾患。患者双眼眶眉棱骨疼痛，额痛，检查视力、眼压、瞳孔、眼底等均属正常，排除青光眼等其他疾患，惟眶上神经（位于眶上缘内 1/3 与外 2/3 交界处）切迹处有明显的压痛或触痛者，即可诊断为本病。

眶上神经之位为祖国医学足阳明经脉之所过。《灵枢·经脉篇》说：“足阳明之脉，……上耳前”。《灵枢·邪气脏腑病形篇》说：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面，而走空窍。……其别气走于耳而为听”。说明耳与全身经脉（特别是眼眶部经脉）相联系，而刺激耳部的相应穴位，可以通过经脉，调和气血，达到治疗眶上神经痛之目的。

耳穴按压治疗

取穴：耳垂中心“眼”穴。

方法：先以75%酒精棉球擦净耳垂眼穴，取中药王不留行籽一粒放于穴中，外贴橡皮胶布盖之，以拇指、食指加压按揉，一般在5分钟左右可有止痛效果，连贴3天，一日按压3次，痛时亦可加压。单侧眶上神经痛则贴患侧，双侧痛则贴两侧。

王不留行籽，入肝胃，行血通经，催生下乳，消肿敛疮，以行血著称，贴于穴位，可促进血液循环，达到“通则不痛”的治病效果。

电针治疗

取穴：攒竹（双）。

仪器：可选用广东佛山市光学研究所生产的EA1-10型家用电子针灸器。

使用方法：①把调幅旋转向“开”，见指示灯闪亮，说明仪器正常，可以开始工作。②把电针置于欲针部位，使全部导子接触皮肤，调节幅旋扭，同时移动导子寻找穴位，当出现明显的刺、酸、麻、胀感时，说明已对准穴位，即停止移动。③如感到刺感太大（或太小）时，可逆时针方向（或顺时针方向）旋动调幅旋扭，每次时间20分钟，5天为一疗程。

100. 眼底出血症

眼底出血可出现于多种眼底病的过程中，是眼科疾病的一个重要症状。视网膜静脉周围炎、视网膜静脉阻塞、高血压眼底病变、糖尿病性眼底病变等均可引起眼底出血。眼底出血往往是导致失明的重要原因。眼底出血的症状有：眼球

渗血，视力急骤下降，视物变红等等。可通过眼底镜窥视检查、眼底荧光血管造影术等检查明确诊断。

眼底出血属于祖国医学的“视瞻有色”、“视瞻昏渺”、“云雾移睛”、“暴盲”、“青盲”、“目衄”等病的范畴。中医认为，气虚不摄，血不归经；痰湿阻脉，迫血外溢；阴虚火旺，灼伤目络；瘀血阻络；外感热邪，传变入里，耗血动血；肝火上熿，迫血外溢；抑郁不乐，气滞脉涩，血不循经，均可引起目衄（眼底出血）。

辨证分型治疗

（1）热盛动血型：高热烦渴，或身现斑疹，视物不见或视物变红。窥视眼底可见视网膜静脉充盈，视网膜有大片圆形及零星小出血。治宜凉血止血。

方药：水牛角屑30克，赤芍30克，生地30克，丹皮12克，夏枯草30克，黄芩30克，紫花地丁30克。水煎服。

（2）肝火旺盛型：烦躁易怒，面红耳赤，两胁胀痛，头昏耳鸣，口干口苦，视网膜出血量较多，舌红苔黄，脉弦数。治宜清热泻肝凉血。

方药：龙胆草10克，生地30克，栀子12克，当归15克，赤芍30克，槐花15克，黄芩15克，白芷10克，甘草6克。水煎服。

（3）肝郁气滞型：两胁胀闷，胸脘不舒，善太息，口干口苦，眼睛干涩，视物昏花或渐至失明，眼底有片状出血或条状出血，或有玻璃体积血。治宜舒肝解郁，行气止血。

方药：白芍30克，当归15克，白术15克，柴胡12克，茯苓15克，防风10克，菊花15克，木贼10克，赤芍15克，枸杞15克，夏枯草30克，白及15克。水煎服。

（4）瘀血阻滞型：眼底出血，血色紫暗，或玻璃体积血，视力障碍，头昏眼胀，口苦咽干，渴不欲饮，舌赤或有

淤点、淤斑，苔白，脉沉弦。治宜活血祛淤，止血明目。

方药：当归30克，生地30克，川芎10克，桃仁10克，红花10克，黄芪30克，赤芍30克，枳壳10克，甘草6克，丹皮15克，夏枯草30克。水煎服。

（5）阴虚肝阳上亢型：头晕耳鸣，腰膝酸软，口干眼花，眼底出血量少，色鲜红，且易反复发生出血，脉沉细数，舌红少津无苔。治宜滋阴清热，凉血止血。

方药：仙鹤草30克，旱莲草30克，枸杞15克，菊花15克，石斛15克，丹参30克，红花10克，决明子30克，生地30克，茅根30克。水煎服。

（6）阴虚心火上炎型：失眠多梦，口干颧赤，手足心热，心悸怔忡，或口舌生疮，小便黄赤，眼底出血鲜红，舌尖红，苔薄黄，脉细数。治宜滋阴清热，养血止血安神。

方药：生蒲黄10克，旱莲草30克，藕节12克，丹皮12克，丹参30克，生地30克，山梔12克，荆芥炭12克，甘草6克。水煎服。

（7）脾不统血型：纳少乏力，面色少华，腹胀便溏，心悸失眠，视网膜出血量多，视力下降，疾病迁延不愈，舌胖嫩有齿痕，脉沉细无力。治宜补气、摄血、化淤。

方药：当归30克，远志12克，生姜10克，党参30克，黄芪30克，白术12克，龙眼肉12克，茯神10克，酸枣仁15克，木香6克，大枣15克。水煎服。

（8）痰湿阻滞型：胸脘满闷，心烦喜呕，眩晕头胀，眼底出血久不吸收，或眼底有白色机化物，舌嫩而滑，脉弦滑。治宜化痰散结，祛淤止血。

方药：夏枯草30克，海藻30克，昆布30克，藕节15克，黄芪30克，鸡内金15克，血余炭15克，海金砂10克，桂枝10克。水

煎服。

单方治疗

三七粉 3 克，冲服，此为 1 日量。

针刺疗法

（1）体针：四白、太冲、太溪、合谷。必要时太阳、头维、印堂点刺出血。

（2）耳针：目₁、目₂、肝、肾、神门、交感。耳尖穴可点刺放血。诸穴均可用耳压法或针刺。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病良方 第五集

作者=贾河先 赵鸿鸣编著

页数=167

出版社=科学技术文献出版社重庆分社

出版日期=1989年06月第1版

SS号=10297981

DX号=000001100714

u r l = h t t p : / / b o o k 1 . d u x i u

. c o m / b o o k D e t a i l . j s p ? d x

N u m b e r = 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 1 4 & d =

6 1 A 6 1 5 0 C 4 A A C A 5 1 2 E D 2 9 C C

7 1 B D D 5 3 3 F 9 & f e n l e i = 1 6 0 5

0 5 & s w = % B C % D 6 % B A % D 3 % C F %

C 8